

Systeem-Audit

Grensoverschrijdend bevoegdheidsvacuüm in de sociale zekerheid

Document C — De visuele architectuur

Auteur: Eric Messa

Versie bijgewerkt: 6 oktober 2026, 14:20

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding en leeswijzer	8
Wat dit document is	8
Het verschil met de andere documenten	8
De vaste grammatica	8
De twee werelden	8
Het membraan	9
De drie kanalen	9
De kleuren	9
De volgorde van dit document	9
Hoe je het leest	10
Wat de lezer kan verwachten	10
De positie van Document C in het geheel	10
I. De mens	12
De presentatie	12
Deel I-A — De structuur	12
Deel I-B — De actoren	15
Deel I-C — De verhoudingen	24
De cascade	27
Frame 1 — De trigger	27
Frame 2 — Wat blijft stromen	27
Frame 3 — Wat weglekt	27
Frame 4 — Wat niet binnenkomt	28
Frame 5 — Het resultaat	28
II. België	30
De potjes en de koppelverkoop	30
Deel II-A — De potjes	30
Deel II-B — De koppelverkoop	34
Deel II-C — De vier catch-22's	35
Wat dit hoofdstuk vaststelt	37
Vaststelling en beslissing	39
De vijf stemmen	39
Twee beslissers, één mechanisme	39
Het gemeenschappelijke patroon	40
De Parentia-trap	41
Niveau 1 — De KSZ-blokkade	41

Niveau 2 — De bypass wordt aanvaard	41
Niveau 3 — De inkomensweigering	41
Het patroon keert terug	42
De Belgische fiscale route	43
Deel A — Wat er werkt	43
Deel B — De bypass voor de verhoogde belastingvrije som	44
Deel C — De dubbele bevestiging	45
Deel D — AGODI: het bewegende doelwit en de uiteindelijke afronding	46
Deel E — Wat dit hoofdstuk vaststelt	47
De heropening	49
Wat de brief zegt	49
Wat de website zegt	49
Wat dit oplevert	50
De CM en de geldstromen	51
Deel A — De drie geldstromen	51
Deel B — De RSZ-bijdrage en de bestemming	51
Deel C — Waarom hulpmiddelen wel en uitkeringen niet	52
Deel D — De CDZ als toezichthouder	53
Deel E — Het Arbeidsauditoraat: wie controleert de controleur?	53
Deel F — De Orde der Artsen: tuchtrecht tegen de adviserend arts	54
Deel G — Wat dit hoofdstuk vaststelt	55
III. Nederland	56
Het UWV en de bezwaarmolen	56
Deel A — Zes rondes bij het UWV	56
Deel B — De RVA en het C4-formulier	56
Deel C — De weigering om buitenlandse data te synchroniseren	57
Deel D — Het patroon: procedureel afwijzen	58
Deel E — De afwijzingsredenen op een rij	58
Deel F — De twee bezwaren in detail	59
Deel G — Wat dit hoofdstuk vaststelt	59
CZ — de twee gezichten van de poortwachter	61
Verhaal 1 — De verdragspolis en de zorgtoeslag	61
Verhaal 1bis — De keten van de blokkade: CZ, CAK, ZIN	62
Verhaal 2 — Het ziekenvervoer	63
Deel C — De parallel: CZ en CM	64
Deel D — Wat dit oplevert	65
De gemeente Hulst-trap	67
Deel A — De gemeente als eerste hulplijn die niet helpt	67

Deel B — Het lopende bezwaarschrift	68
Deel C — De rekenmodellen die de werkelijkheid niet lezen	69
Deel D — De mobiliteitsfratsen	69
Deel E — De grenslimieten van het Wmo-vervoer.....	70
Deel F — Het patroon herhaalt zich	71
Wat de gemeente had moeten zijn	71
Belastingdienst en toeslagen.....	73
Deel A — De drie toeslagen	73
Deel B — De mechaniek die erachter zit	73
Deel C — De medische kosten die nul werden	74
Deel D — De verantwoordelijkheid bij de burger.....	75
Deel E — Wat dit oplevert.....	76
IV. Heen en weer	77
Het manuele U1-probleem	77
De twee richtingen.....	77
Richting 1 — België naar Nederland.....	77
Richting 2 — Nederland naar België.....	78
Het patroon.....	78
ESSPASS in 2030 — wat verandert er niet	79
Wat de ESSPASS wel en niet oplost	80
Waarom dit een brug is naar het Nederlandse deel	81
SVB en Parentia — het werkende voorbeeld	83
Deel A — De splitsing.....	83
Deel B — Waarom dit werkt.....	83
Deel C — De herberekening die het succes bedreigt	84
Deel D — Wat dit hoofdstuk toont	85
Het lichaam zonder achterwacht.....	87
Deel A — De wettelijke onmogelijkheid.....	87
Deel B — De gevolgen in de praktijk.....	87
Deel C — De wet die het gezin beschermt en verlamt	88
Deel D — De paradox.....	89
Wat dit hoofdstuk vaststelt	89
De centrale pot	91
Deel A — De rekening als reservoir	91
Deel B — De drie private poorten.....	91
Deel C — De bank als de-facto schuldeiser van de verzorgingsstaat.....	92
Wat dit hoofdstuk vaststelt	93
V. Europa	94

De Europese laag.....	94
Deel A — De Europese en internationale laag	94
Deel B — De cirkelverwijzing	94
Deel C — De twee openingen	95
Deel D — De inbreukprocedure die niet komt	96
Deel E — De Europese tegenstrijdigheid	97
Wat dit hoofdstuk vaststelt	97
VI. Wie toekijkt.....	99
De controle- en bemiddelingslaag	99
Deel A — De vier bemiddelaars	99
Deel B — Het verschil tussen de twee ombudsmannen.....	99
Deel C — De cirkelverwijzing tussen de twee SOLVIT-centra	100
Deel D — De ELA: de weg die niet opengaat	100
Deel E — Het patroon	101
De rechtbanken	103
Deel A — De twee rechte wegen.....	103
Deel B — De pro deo-drempel.....	103
Deel C — De ironie van het peiljaar.....	104
Deel D — Wat dit betekent	105
De politiek	107
Deel A — De scheiding der machten.....	107
Deel B — Wat de politiek wel en niet kan	107
Deel C — De Belgische parlementaire praktijk	108
Deel D — De Nederlandse parlementaire praktijk	109
Deel E — De verschillen op een rij	110
Deel F — De kracht van de framing	111
Deel G — Wat dit dossier doet.....	112
De adel.....	113
Deel A — De formele macht: wat de koning wel en niet kan	113
Deel B — Het petitieright.....	113
Deel C — De praktijk: hoe petitie worden behandeld	114
Deel D — De paradox van het informele kanaal.....	114
Deel E — De praktijk in dit dossier	115
Deel F — Wat dit hoofdstuk vaststelt	115
De bondgenoten en de waakhond.....	117
Deel A — ACV: de vakbond die helpt en stopt	117
Deel B — UNIA: de waakhond die niet mag bijten	118
Deel C — De academische observatielaag	119

Deel D — Wat dit hoofdstuk vaststelt	120
VII. Slot	122
Slot — de volledige piramide	122
De piramide	122
Wat dit dossier heeft laten zien	122
De brug naar Document D.....	123
Het volledige netwerk.....	124
Wat het gezin ziet	124
Wat dit schema doet.....	125
Wat er niet in staat.....	125

Inleiding en leeswijzer

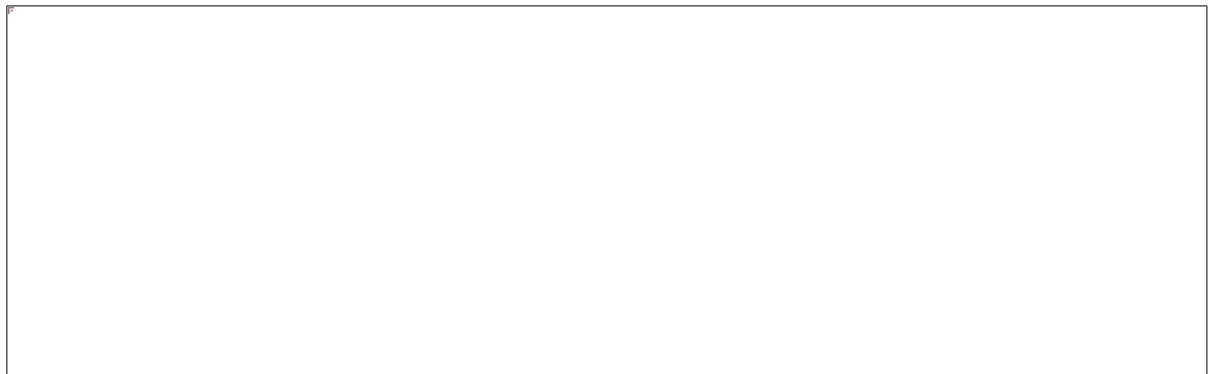
Document C is het visuele document van het Systeem-Audit-project. Het toont in één oogopslag wat in de andere documenten verspreid staat: de structuur van het netwerk, de doorstroming tussen instanties, en de mechanismen die het falen veroorzaken.

Wat dit document is

Document C is geen herhaling van de andere documenten in beeldvorm. Het is een eigen perspectief dat alleen in schema's bestaat. Waar Document A het verhaal vertelt, Document B de feiten ordent, en Document D de conclusies trekt, toont Document C de **architectuur** die aan al die feiten ten grondslag ligt.

Het document is opgebouwd als een reeks hoofdstukken. Elk hoofdstuk is een eigen schema met korte tekst. Geen doorlopend verhaal, geen lange analyses. Elk schema toont één mechanisme, één patroon, of één verband dat in de andere documenten wel te vinden is, maar nooit in één oogopslag.

Het verschil met de andere documenten



Figuur 0.1 — De vijf documenten. Elk document heeft een eigen functie. Document 0 is de inleiding en leeswijzer, Document A is de narratieve audit, Document B is de data-matrix, Document C is de visuele architectuur, Document D is de synthese. Document C toont de architectuur die aan alles ten grondslag ligt.

De vaste grammatica

Elk hoofdstuk van Document C gebruikt dezelfde visuele taal. Wie die taal eenmaal kent, kan elk schema lezen. Hier volgt het vocabulaire.

De twee werelden

België en Nederland worden getoond als twee **werelden**: starre, gesloten systemen die hun regels niet aanpassen voor een burger die in twee landen tegelijk leeft. Beide werelden zijn opgebouwd uit **vier concentrische lagen**: uitvoering, toezicht, politiek, symboliek.

Het membraan

Tussen de twee werelden leeft het gezin. Het gezin is geen bol maar een **membraan**: een flexibele, doorzichtige vorm die rekt en krimpt naargelang wat de dag vraagt. In het weekend helemaal in Nederland, op werkdagen uitgestrekt over beide werelden.

De drie kanalen



Figuur 0.2 — De drie kanalen. Het karakter van een kanaal bepaalt of gegevens doorstromen, wringen of volledig geblokkeerd worden. Kanaal 1 werkt voor controle en heffing achteraf; niet voor de voorafgaande informatiepositie van de burger.

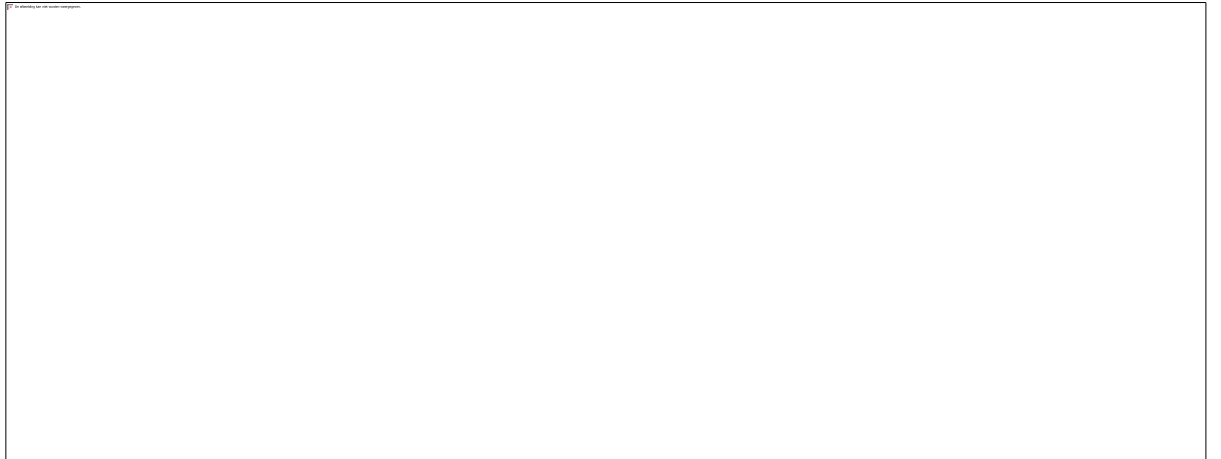
De kleuren

In de schema's worden verbindingen gekleurd op basis van wat er gebeurt:

- **Groen** — de doorstroming werkt. Automatisch, zonder vertraging, zonder menselijke tussenkomst.
- **Oranje** — het wringt. Er is een kanaal, maar het is smal, eenmalig of vertraagd.
- **Rood** — het is geblokkeerd. Er is geen kanaal, of het kanaal is gesloten.

De volgorde van dit document

Document C volgt de menselijke volgorde. Het begint bij de mens, daarna bij België (omdat de auteur Belg is), dan bij Nederland, dan tussen beide landen heen en weer, dan naar Europa, dan naar wie naar Europa kijkt, en ten slotte naar de wereld die het geheel zou moeten zien.



Figuur 0.3 — De weg door dit document. Zeven blokken, in de volgorde van de menselijke werkelijkheid: van het lichaam, via de twee landen, naar Europa, naar wie toekijkt, en ten slotte naar het slot.

Hoe je het leest

Document C is niet bedoeld om in één keer van voor naar achter te worden gelezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf. De lezer kan zelf zijn weg kiezen.

Voor wie het geheel wil begrijpen: begin bij Blok I (De mens), daarna volgen de blokken in volgorde. Zo bouwt het beeld zich stap voor stap op: van de mens, via de twee landen, naar Europa, naar wie toekijkt, naar het slot.

Voor wie specifiek geïnteresseerd is in één onderwerp: kies het bijbehorende hoofdstuk. De koppelverkoop, de cascade, het UWV, CZ, de gemeente, de Belastingdienst, de Europese laag — elk heeft een eigen hoofdstuk.

Voor wie het volledige netwerk wil zien: lees Blok I (De mens) eerst, daarna het slot. Die twee samen geven de structuur in één oogopslag.

Wat de lezer kan verwachten

- Elk schema heeft een eigen titel en een korte toelichting onder het figuur.
- Organisaties worden getoond als blokken of als genummerde dots op een ring. Namen zijn publiek en worden vermeld.
- Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool. Nooit met hun naam.
- Bedragen, datums en referentienummers komen uit Document B. Waar een bedrag of datum onzeker is, wordt dat expliciet vermeld.
- Waar het schema een patroon toont dat in Document D nader wordt uitgewerkt, staat een verwijzing naar het betreffende hoofdstuk in D.

De positie van Document C in het geheel

Document C staat tussen Document B en Document D in. Waar B de feiten vastlegt en D de conclusies trekt, toont C de architectuur die het falen mogelijk maakt. Wie de feiten wil: B. Wie de conclusies wil: D. Wie wil begrijpen waarom de feiten tot deze conclusies leiden: C.

Wat dit document toont, is de kern van het bevoegdheidsvacuüm in één oogopslag: één lichaam, twee werelden, drie kanalen. En een burger die zich in het gat tussen de twee werelden staande moet houden.

Dit is Document C — De visuele architectuur. Alle organisaties in dit document zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool. De feiten zijn gebaseerd op Document B. De conclusies staan in Document D. Dit document is geen juridisch advies.

I. De mens

De presentatie

Twee starre werelden. Eén membraan dat rekt en krimpt. Drie kanalen met elk een eigen karakter. En binnen elke wereld vier institutionele ringen die de burger moet doorlopen om iets gedaan te krijgen. Dit hoofdstuk toont het speelbord: wie waar staat, hoe de lagen zijn opgebouwd, en welke actoren in elke laag opereren.

Deel I-A — De structuur

De twee werelden

In dit dossier worden België en Nederland aangeduid als twee **werelden**: **Wereld België** en **Wereld Nederland**. Elke wereld is een intern sluitende, soevereine rechts- en uitvoeringsorde. Voor een burger die zijn volledige levensloop binnen één wereld voltrekt, sluiten de interne schakels in de regel op elkaar aan.

Beide werelden zijn echter **star**. Ze ademen niet. Ze passen hun administratieve grenzen niet aan wanneer een burger gebruikmaakt van het recht op vrij verkeer. Elke wereld toetst aanvragen aan uitsluitend nationale definities, nationale medische barèmes en territoriale voorwaarden — het woonplaatsbeginsel tegenover het werklandbeginsel. De twee werelden liggen fysiek tegen elkaar aan bij de staatsgrens en schuren langs elkaar, maar fuseren op uitvoeringsniveau nergens.

Het membraan

Tussen de twee starre werelden bevindt zich **het membraan**: het gezin. Anders dan de twee nationale stelsels heeft het gezin geen vaste geometrische vorm. Het is een doorzichtige, onregelmatige vorm die moet rekken en krimpen om de incompatibiliteit tussen beide systemen op te vangen. Waar de instituties star blijven, wordt volledige flexibiliteit van de burger geëist.

Het membraan kent een cyclische beweging met twee standen:

- **Weekdagstand** (doorgetrokken contour): het membraan strekt zich uit over beide werelden. Het gezin woont in Nederland, maar steekt dagelijks de grens over voor school, medische behandelingen en lopende procedures aan Belgische zijde.
- **Weekendstand** (gestippelde contour): het membraan trekt zich terug binnen de Nederlandse wereld. De fysieke aanwezigheid is dan volledig in Nederland, terwijl de juridische en financiële afhankelijkheid van België onverminderd doorloopt.

Binnen het membraan bevinden zich drie personen, weergegeven met symbolen:

- **De vader (♂)** — Belg met Franco-Italiaanse origine, geboren in België, woonachtig in Nederland. Zijn arbeids- en ziektegeschiedenis speelt zich af in België; zijn woonplaats en een deel van zijn zorg- en uitkeringsrelaties liggen in Nederland.
- **De moeder (♀)** — Belgisch, woonachtig in Nederland. Zij werkt in België en vormt de dagelijkse logistieke en administratieve draaischijf tussen de Nederlandse woonomgeving en de Belgische instanties.
- **De zoon (kleine ♂)** — woont in Nederland, gaat naar school in Vlaanderen. Hij beweegt dagelijks over de grens tussen het Nederlandse woonland en het Vlaamse onderwijs- en gezinsbijslagstelsel.

De vier institutionele lagen

Elke wereld is van buiten naar binnen opgebouwd uit vier concentrische ringen. Wie in de buitenste laag vastloopt en hogerop bescherming zoekt, beweegt van buiten naar binnen door deze vier lagen:

1. **Uitvoering** — de loketten waar de burger rechtstreeks mee te maken heeft: ziekenfondsen, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, belastingdiensten, uitkeringsinstanties, gemeenten, nutsbedrijven. Hier worden beslissingen genomen, betalingen verricht of geblokkeerd.
2. **Toezicht** — de controleurs en ombudsdiensten. Zij monitoren het systeem, maar grijpen in individuele grensoverschrijdende dossiers niet dwingend in op de uitvoeringslaag.
3. **Politiek** — de nationale parlementen, parlementscommissies en politieke partijen. Zij bezitten de formele macht om de wet te wijzigen, maar laten individuele systeemblokkades ongemoeid.
4. **Symboliek** — de hoogste postbus van de staat: het Koninklijk Paleis in België, het Koninklijk Huis in Nederland. Deze kern bezit geen uitvoerende of corrigerende macht en stuurt verzoekschriften terug naar de politieke of uitvoerende laag.

De drie kanalen tussen de werelden

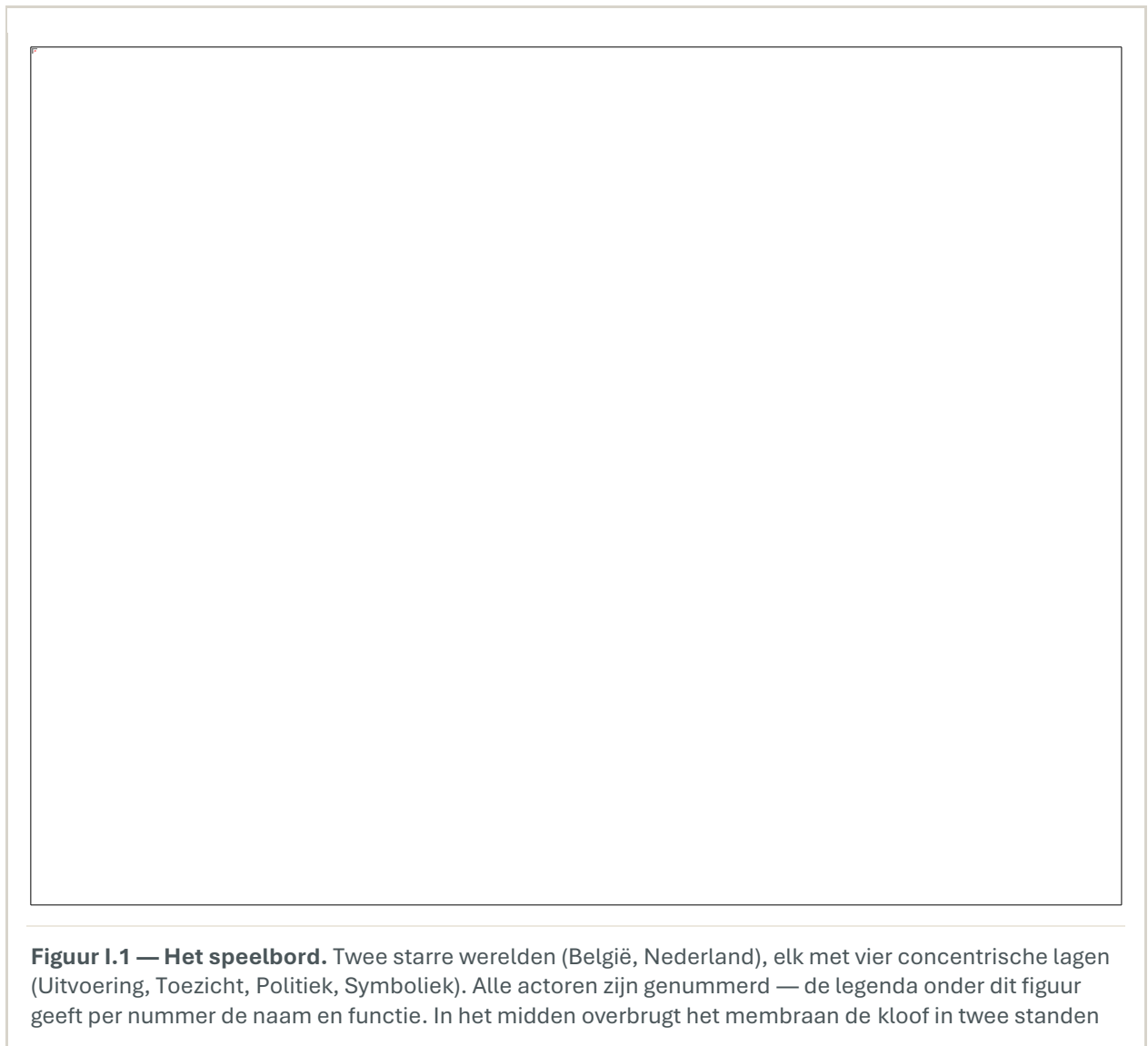
Hoewel de twee werelden niet fuseren, bestaan er drie structurele verbindingssassen tussen België en Nederland. Ze tonen een fundamentele asymmetrie tussen wat de staat van de burger weet en wat de staat voor de burger faciliteert.

- **Kanaal 1 — dik groen, geautomatiseerd.** De fiscale en administratieve data-infrastructuur van de EU: de Directive on Administrative Cooperation en de wereldinkomensuitwisseling. Fiscale gegevens stromen automatisch tussen de Belgische FOD Financiën en de Nederlandse Belastingdienst. Op het gebied van controle en heffing weet de overheid alles.
- **Kanaal 2 — smal oranje, eenmalig.** De verdragspolis tussen het Belgische ziekenfonds en de Nederlandse zorgverzekeraar (S072) en het CAK. Een smalle, eenmalige administratieve buis die standaardvergoedingen afdekt en onmiddellijk wringt zodra zorg of status buiten het standaardformulier valt.

- **Kanaal 3 — rood onderbroken, manueel.** Het medische en sociaal-maatschappelijke vlak. Tussen Belgische en Nederlandse ziekenhuizen, huisartsen, keuringsartsen en sociale diensten bestaat geen geautomatiseerd kanaal. De lijn is onderbroken en gemarkeerd met een X: het gezin moet dossiers, medische beeldvorming en attesten zelf fysiek van de ene naar de andere wereld dragen.

De EU-buitenlaag

Rondom beide nationale werelden ligt **de EU-buitenlaag**. Deze laag omvat drie clusters: officiële Europese en verdragsrechtelijke instellingen, grensoverschrijdende bemiddelingsorganen, en de maatschappelijke resonantielaag (wetenschap, strategische procesvoering, media en VN-mensenrechten). De gestippelde lijn visualiseert het grondprobleem van het Europese sociaal recht: de EU proclameert het vrije verkeer en coördineert op papier (Verordening 883/2004), maar heeft geen eigen uitvoeringsloket dat een vastgelopen nationale keten kan openbreken.



(weekdag uitgestrekt, weekend teruggetrokken). De drie kanalen tonen de structurele spanning: dik groen (geautomatiseerd), smal oranje (eenmalig), rood onderbroken (manueel).

Deel I-B — De actoren

Voor lezers die België en Nederland niet kennen: hieronder staat elke organisatie die op het speelbord voorkomt, geordend per wereld en per laag. Eerst de publieke of privaatrechtelijke functie, dan de specifieke rol in dit dossier.

WERELD BELGIË

Uitvoering

1 Christelijke Mutualiteit (CM)

Het grootste Belgische ziekenfonds; een privaatrechtelijke vereniging met een wettelijk publiek mandaat om de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering uit te voeren en vervangingsinkomens uit te keren.

Rol in dit dossier: Primaire poortwachter voor ziekte-uitkeringen, medische kosten en het verdragsformulier S072. Blokkeert of vertraagt dossierstromen zodra de verzekerde in Nederland woont.

2 Vitaz

Algemeen tweedelijnsziekenhuis in het Waasland, dicht bij de Nederlands-Belgische grens.

Rol in dit dossier: Eerste medische schakel in het dossier. Levert acute zorg maar geen administratieve vertaling. Klinische data blijven opgesloten in het eigen systeem.

3 Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent)

Academisch derdelijnsziekenhuis voor hooggespecialiseerde en complexe diagnostiek en behandeling.

Rol in dit dossier: Academische overkoepeling. Levert wél de administratieve vertaling die de eerste lijn weigert, en publiceert via het eHealth-netwerk.

4 Oogartsen Sint-Niklaas

Gespecialiseerde oftalmologische privépraktijk in Sint-Niklaas.

Rol in dit dossier: Voert invasieve behandelingen uit maar registreert de gedwongen stopzetting als patiëntweigering. Geen koppeling met enig eHealth-platform.

5 Huisartsenpraktijk Ter Vierschaar

Eerstelijns huisartsenpraktijk aan Belgische zijde.

Rol in dit dossier: Overkoepelend medisch regisseur, sinds het begin

betrokken. Levert de vertaling naar de administratieve systemen van beide landen. Werkt via Vitalink en SumEHR.

6 Onafhankelijke Experts BE

Zelfstandige artsen-deskundigen die medische schade en invaliditeitspercentages vaststellen in opdracht.

Rol in dit dossier: Volledige radiostilte. Geen enkele aangeschreven expert reageert op verzoeken tot onafhankelijke beoordeling.

7 Vertico Business Solutions

Belgische private werkgever.

Rol in dit dossier: Voert de wettelijke loondoorbetaling correct uit. Levert tijdig de tewerkstellingsattesten af. De frictie begint pas bij de overdracht naar de publieke instanties.

8 FOD Sociale Zekerheid — DG Personen met een Handicap (DG HAN)

Het Belgische federale ministerie dat de ernst van een handicap medisch beoordeelt en officiële erkenningsattesten aflevert.

Rol in dit dossier: Erkent de medische beperkingen formeel, maar koppelt de erkenning aan een binnenlandse woonplaats. Weigert zelfs een zuiver medische erkenning voor fiscale doeleinden wanneer de burger in Nederland woont.

9 FOD Financiën

De Belgische nationale belastingadministratie.

Rol in dit dossier: Wisselt via het groene EU-kanaal automatisch inkomensdata uit met Nederland, maar beslist autonoom over fiscale vrijstellingen en eist een attest van DG HAN dat deze instantie in dit dossier niet levert. Verhoogt vervolgens de drempel (9 punten) boven wat DG HAN toekent (8 punten).

10 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

De Belgische federale instelling die de werkloosheidsverzekering reguleert en Europese loopbaanattesten (PD U1) aflevert.

Rol in dit dossier: Weigert buitenlandse loopbaangegevens in het eigen systeem te integreren. Eist voor onderwijsloopbanen een C4-formulier dat in dat statuut juridisch niet bestaat.

11 Parentia

Erkend Belgisch uitbetalingsorganisme voor gezinsbijslagen en het Vlaamse Groeipakket.

Rol in dit dossier: Leest inkomensdata via de Kruispuntbank (KSZ) en is daardoor blind afhankelijk van wat het ziekenfonds (CM) doorgeeft. Wanneer CM de ziektestatus niet registreert, bevriest de sociale toeslag.

12 Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Uitvoerend agentschap van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs dat de

loonadministratie van onderwijspersoneel verzorgt.

Rol in dit dossier: Voert de bedrijfsvoorheffing af voor de moeder, maar weigert retroactieve fiscale correcties op basis van een federaal handicapattest. Verschuilt zich achter het schoolsecretariaat en de federale fiscus.

13 Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)

De grootste Belgische vakbond, tevens uitbetalingsinstelling en verstrekker van sociaalrechtelijke bijstand.

Rol in dit dossier: Erkent de systeemfout volmondig maar weigert juridische interventie tegen de CM zodra de patiënt zelf geen lidnummer heeft. Solidariteit stopt bij de individuele lidmaatschapsgrens.

Toezicht

14 Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

De centrale federale instelling die de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering aanstuurt en financiert.

Rol in dit dossier: Bevestigt schriftelijk dat medische erkenning losstaat van een financieel uitkeringsrecht, maar weigert in individuele dossiers dwingend in te grijpen op beslissingen van het ziekenfonds.

15 Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ)

Federale toezichthouder op de ziekenfondsen.

Rol in dit dossier: Verklaart zich onbevoegd voor individuele dossiers. Kwalificeert een structurele schending van het Unierecht als een individueel medisch geschil en sluit het dossier.

16 Federale Ombudsman

Onafhankelijke klachtenbehandelaar van de Belgische federale overheid.

Rol in dit dossier: Bereikt een procedurele doorbraak bij DG HAN, maar capituleert voor het administratieve verweer van de CM. Sluit het dossier definitief zonder de onderliggende impasse op te lossen.

17 Arbeidsauditoraat Gent

Het gespecialiseerde openbaar ministerie bij de arbeidsrechtbanken, bevoegd voor de sociale zekerheidswetgeving.

Rol in dit dossier: Verklaart zich onbevoegd voor toezicht op de ziekenfondsen. Kwalificeert de administratieve impasse als een burgerlijk geschil en verwijst door naar de Arbeidsrechtbank.

18 UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum)

Onafhankelijke instelling die discriminatie bestrijdt.

Rol in dit dossier: Verklaart zich onbevoegd omdat woonplaats geen beschermd criterium is in de antidiscriminatiewetgeving. Uitsluiting die rechtstreeks uit een wet of decreet voortvloeit valt buiten het mandaat.

19 Orde der Artsen

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie die toezicht houdt op de medische deontologie en het tuchtrecht uitoefent.

Rol in dit dossier: Behandelt klachten over controle- en expertiseartsen binnen een gesloten tuchtrechtelijke procedure. De patiënt is geen procespartij, en het mandaat is beperkt tot het individuele handelen van de arts.

Politiek**20 Kamer van Volksvertegenwoordigers — Commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen**

De vaste parlamentscommissie die de federale socialezekerheidswetgeving opstelt en de bevoegde ministers controleert.

Rol in dit dossier: Ontvangt een gedocumenteerde melding van systeemfalen, maar activeert geen parlementair instrument. Geen vraag, geen interpellatie, geen hoorzitting.

21 Kamer van Volksvertegenwoordigers — Commissie voor de Verzoekschriften

De parlementaire commissie die het grondwettelijke petitierecht behandelt.

Rol in dit dossier: Verklaart het verzoekschrift ontvankelijk en stuurt het door naar de bevoegde vakcommissie en de minister. Daarmee stopt de interventie. Procedurele afvinking zonder inhoudelijke actie.

22 Belgische Politieke Partijen

De partijen die de wetgevende en uitvoerende macht vormen.

Rol in dit dossier: Negen partijen worden aangeschreven. Vijf produceren geen reactie. De andere vier verwijzen naar studiediensten of verklaren zich onbevoegd. Geen enkele partij activeert een parlementair instrument.

Symboliek**23 Koninklijk Paleis van België**

Het kabinet van de Koning, dat verzoekschriften van burgers behandelt.

Rol in dit dossier: Symbolische eindhalte. Bevestigt de ontvangst en stuurt door naar de bevoegde minister — waarmee de burger terug bij de uitvoeringslaag belandt. De mailserver van het Paleis is technisch onbereikbaar.

WERELD NEDERLAND

Uitvoering

24 CZ (Centrale Zorgverzekeraar)

Grote Nederlandse zorgverzekeraar die de verplichte basisverzekering uitvoert en de verdragspolis aan Nederlandse zijde beheert.

Rol in dit dossier: Vergoedt medische rekeningen, maar weigert ziekenvervoer op basis van een perimetrie-eis die in België niet standaard wordt gemeten. Verzuimt de verdragspolis te registreren in het RIV-register.

25 ZorgSaam

Regionale zorgaanbieder in Zeeuws-Vlaanderen.

Rol in dit dossier: Levert maandenlang complexe wondzorg aan huis en documenteert 126 klinische entrees. Deze rapportage is niet automatisch zichtbaar voor UWV, CZ of de Belgische sociale zekerheid. Externe Belgische documenten worden passief gearchiveerd onder een multimedia-tab.

26 CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Zelfstandig bestuursorgaan dat het landelijke verzekeringsregister (RIV) beheert en de verdragsregelingen uitvoert.

Rol in dit dossier: Weigert de verdragspolis te registreren met een procedureel argument: het systeem kent alleen de "gewone" grensarbeider (werken in Nederland, wonen in het buitenland), niet de omgekeerde situatie (wonen in Nederland, werken in België). De computer kent het veld niet.

27 Zorginstituut Nederland (ZIN) — uitvoering

Zelfstandig bestuursorgaan onder het Ministerie van VWS.

Rol in dit dossier: Beheert en superviseert het RIV-register op systeemniveau, maar weigert inzage in individuele persoonsgegevens. Verwijst terug naar CZ en het CAK.

28 Pallion Huisartsenpraktijk

Eerstelijns huisartsenpraktijk in Hulst.

Rol in dit dossier: Weigert informatieve inschrijving. De Nederlandse wet verbiedt dubbele inschrijvingen over de grens. De patiënt heeft in zijn eigen woonland geen lokale medische achterwacht die zijn Belgische dossier kent.

29 Onafhankelijke Experts NL

Publieke en private keuringsartsen en medische beoordelaars.

Rol in dit dossier: De GGD weigert particulieren. Huisartsen weigeren niet-patiënten. Commerciële bureaus vragen exorbitante tarieven voor een keuring op afstand. Het systeem eist een Nederlandse medische nulmeting maar produceert geen toegankelijke weg om die te verkrijgen.

30 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Zelfstandig bestuursorgaan dat de werknemersverzekeringen (WIA, WW, Ziektewet) uitvoert en sociaal-medische beoordelingen verricht.

Rol in dit dossier: Past het Vester-arrest niet toe. Hanteert een foutieve peildatum (11 mei in plaats van 11 april 2025) en weigert de medische situatie

inhoudelijk te beoordelen. Levert een gebrekkig PD U1 af waarin 21 jaar Belgische loopbaan wordt gewist.

31 Sociale Verzekeringsbank (SVB) met Bureau voor Belgische Zaken (BBZ)

Uitvoerder van de Nederlandse volksverzekeringen, met een gespecialiseerd bemiddelingsloket voor grensarbeiders.

Rol in dit dossier: Kent de kinderbijslag toe aan de vader omdat de moeder in België werkt, en activeert daarmee het kindgebonden budget. Het BBZ bemiddelt tussen RIZIV en UWV, maar kan niets afdwingen. De bemiddelingsrol wordt beëindigd zonder resultaat.

32 Belastingdienst (inclusief Dienst Toeslagen)

De Nederlandse rijksbelastingdienst voor heffing van inkomstenbelasting en premies, en uitbetaling van inkomensafhankelijke toeslagen.

Rol in dit dossier: Het online aangifteportaal is gebouwd voor een huishouden met Nederlands belastbaar inkomen. Een grensarbeidershuishouden met buitenlands inkomen produceert een nulresultaat. De zorgtoeslag blijft op nul door de RIV-blokkade; huurtoeslag en kindgebonden budget worden deels toegekend.

33 ING Nederland

Commerciële huisbank.

Rol in dit dossier: Biedt een betalingsregeling voor de opgelopen roodstand en creditcardschuld (ca. € 6.709 totaal), met strikte bancaire beperkingen. De bank wordt de facto schuldeiser van de falende verzorgingsstaat.

34 Vattenfall

Commerciële energieleverancier.

Rol in dit dossier: Eist een medische verklaring van een onafhankelijke Nederlandse arts voor de status "medisch kwetsbare consument". Die eis is onuitvoerbaar voor een grensarbeider. Na maanden geeft de leverancier toe dat de eis onterecht was en verwijst door naar de netbeheerder.

35 Stedin

Regionale netbeheerder voor gas en elektriciteit in Zeeland.

Rol in dit dossier: Verantwoordelijk voor de fysieke leverings- en afsluitgarantie. Er bestaat geen automatische datadoorgifte tussen Vattenfall en Stedin: de patiënt moet de volledige medische bewijslast opnieuw opbouwen bij deze nieuwe private partij.

36 Gemeente Hulst (inclusief Stichting Hulst voor Elkaar)

Nederlandse grensgemeente en haar uitvoeringsorganisatie voor het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet).

Rol in dit dossier: E-mails en AVG-inzageverzoeken botsen structureel op DNS-fouten. Hulpverzoeken worden na maanden ongelezen verwijderd. De gemeente weigert een administratieve overname van de Europese gehandicaptenparkeerkaart en eist een nieuwe lokale keuring.

37 Reizen door Zeeland

Regionale vervoerscentrale voor Wmo-vervoer.

Rol in dit dossier: Weigert ritten naar Belgische overheidsinstanties (bijv. FOD-keuring), maar accepteert ritten naar academische ziekenhuizen over de grens. Het systeem onderscheidt op bestemming, niet op afstand. De incassotermijn houdt geen rekening met het loonbetalingspatroon van grensarbeiders.

Toezicht**38 De Nationale Ombudsman (NL)**

Onafhankelijk Hoog College van Staat dat het handelen van Nederlandse overheidsinstanties toetst.

Rol in dit dossier: Registreert de klacht, meldt capaciteitsproblemen en weigert actieve tussenkomst zolang er bezwaar- of beroepsprocedures lopen. Sluit het dossier definitief en registreert het als passief signaal.

39 Zorginstituut Nederland (ZIN) — toezicht

Houdt systeemtoezicht op de rechtmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet.

Rol in dit dossier: De instantie die het RIV-register beheert, verklaart geen inzage te hebben in individuele persoonsgegevens en weigert het register te controleren. Driehoek CZ, CAK en ZIN blijft gesloten.

Politiek**40 Tweede Kamer — Vaste Commissie SZW**

De parlementaire commissie die de Nederlandse sociale zekerheid controleert.

Rol in dit dossier: Registreert de brandbrief formeel en parkeert het dossier voor een commissiedebat. Sluit individuele behandeling uitdrukkelijk uit.

41 Nederlandse Politieke Partijen

De volksvertegenwoordigende partijen in het Nederlandse parlement.

Rol in dit dossier: Regeringspartijen verwijzen naar de Nationale Ombudsman. Oppositiepartijen sturen het dossier naar beleidsmedewerkers. Geen enkele partij activeert een parlementair instrument.

Symboliek**42 Koninklijk Huis**

Het constitutionele ambt van het Nederlandse staatshoofd.

Rol in dit dossier: Kabinet bevestigt de onmogelijkheid tot interventie en biedt aan het verzoekschrift door te geleiden naar de bevoegde minister. De nationale escalatieladder is uitgeput zonder inhoudelijke oplossing.

EU-BUITENLAAG

Instellingen

43 Europese Commissie — DG EMPL

Het uitvoerend orgaan van de EU dat toeziet op de toepassing van het Unierecht.

Rol in dit dossier: Registreert de klacht, voegt meerdere klachten samen, maar heeft geen handhavingsbevoegdheid in individuele gevallen. Kan alleen een inbreukprocedure starten — een traject van jaren.

44 Europees Parlement — Commissie Verzoekschriften (PETI)

De commissie die petitie van EU-burgers behandelt.

Rol in dit dossier: Verklaart een petitie ontvankelijk, publiceert een samenvatting, stelt de petitie open voor medeondertekenaars. Kan echter geen nationale uitvoeringsbesluiten terugdraaien.

45 Europese Ombudsman

Onafhankelijke klachtenbehandelaar voor EU-instellingen.

Rol in dit dossier: Verklaart een klacht over SOLVIT niet-ontvankelijk: SOLVIT is een nationale dienst, geen EU-instelling. Het falen van SOLVIT valt in een jurisdictioneel vacuüm.

46 Europese Raad (EUCO)

Het hoogste politieke orgaan van de EU, gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders.

Rol in dit dossier: Bepaalt de strategische koers op de lange termijn, maar heeft geen contactmechanisme voor individuele burgers. Is te ver verwijderd van de uitvoeringspraktijk om een rol te spelen.

47 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Internationaal gerechtshof van de Raad van Europa.

Rol in dit dossier: Verklaart de klacht onontvankelijk omdat de nationale rechtsmiddelen niet volledig zijn uitgeput. Reduceert het transnationale probleem tot een geschil tegen de Belgische staat alleen.

48 Europese Arbeidsautoriteit (ELA)

Gespecialiseerd EU-agentschap voor eerlijke arbeidsmobiliteit en coördinatie van sociale zekerheid.

Rol in dit dossier: Bemiddelt uitsluitend op verzoek van nationale overheden zelf, niet op verzoek van individuele burgers. De gespecialiseerde nooduitgang blijft gesloten voor wie hem het hardst nodig heeft.

Bemiddeling

49 SOLVIT Nederland

Het Nederlandse nationale centrum van het Europese informele probleemoplossingsnetwerk.

Rol in dit dossier: Sluit beide dossiers met het oordeel dat de nationale referteperiodes correct zijn toegepast. Weigert het Vester-arrest te toetsen. Weigert doorverwijzing naar de ELA.

50 SOLVIT België

Het Belgische nationale SOLVIT-centrum.

Rol in dit dossier: Verklaart zich onbevoegd voor een inhoudelijke analyse en verwijst terug naar SOLVIT Nederland. Weigert eveneens doorverwijzing naar de ELA. Cirkelverwijzing tussen twee nationale SOLVIT-centra.

51 Benelux Unie

Intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg.

Rol in dit dossier: Bevestigt de problematiek na zorgvuldige lezing, maar behandelt geen individuele dossiers en heeft geen bevoegdheid om EU-regelgeving te wijzigen.

52 GrensInfoPunt (GIP)

Euregionale informatiedienst voor grensarbeiders.

Rol in dit dossier: Verstrekt accurate theoretische informatie, maar beschikt over nul uitvoerende macht. Weigert een gedocumenteerde systeemfout aan te melden als grensbelemmering, met een beroep op neutraliteit.

Maatschappelijke resonantie**53 Strategische Belangenbehartiging (PILP e.a.)**

Mensenrechtenorganisaties en rechtshulpinitiatieven.

Rol in dit dossier: Ontvangen het dossier, erkennen de waarde, gebruiken het als brandstof voor toekomstige procedures. Bieden geen acute curatieve oplossing voor het individuele dossier.

54 Academische Observatielaag (ITEM e.a.)

Wetenschappelijke kennisinstituten voor grensoverschrijdende samenwerking.

Rol in dit dossier: Publiceren doorlopend over grensoverschrijdend falen, maar reageren maandenlang niet op een actieve casus. Wanneer het dossier in het najaar van 2026 de academische drempel overschrijdt, opent het instituut een inhoudelijke bestudering.

55 Media en Publieke Intellectuelen

Onderzoeksjournalistiek en publieke opiniemakers.

Rol in dit dossier: Krijgen het dossier aangeboden. Resonantie is vluchtig: een artikel genereert kortstondige druk maar verandert de architectuur niet. Algoritmes lezen geen kranten.

56 OHCHR / Verenigde Naties

Het mensenrechtenorgaan van de VN, inclusief het CRPD-comité.

Rol in dit dossier: Stelt de internationale mensenrechtennormen waaraan België en Nederland zich hebben verbonden. Heeft geen toezichthoudende machtsmiddelen om een falende nationale uitvoeringsinstantie te corrigeren.

Deel I-C — De verhoudingen

De actoren op het speelbord zijn geen losse eenheden. Ze staan in vaste gezags- en dataverhoudingen die de ruimte bepalen waarbinnen het gezin moet opereren. De kern van het bevoegdheidsvacuüm is dat deze verhoudingen zo zijn ingericht dat geen enkele actor eindverantwoordelijkheid draagt voor het geheel.

Verhouding	Formeel gezag	Feitelijke praktijk	Gevolg voor het gezin
Toezichthouder ↔ uitvoerder BE RIZIV, CDZ → CM NL ZIN → CZ	Toezichthouders reguleren de uitvoerders en kunnen richtlijnen uitvaardigen.	Geen dwingend interventiemandaat in individuele dossiers. De uitvoerder beslist autonoom aan het loket.	Klachten bij de toezichthouder lossen een concrete blokkade niet op.
Federale ministeries ↔ federale ministeries BE FOD SZ → FOD Fin NL SVB → Toeslagen	Nevengeschikte diensten met eigen wettelijke mandaten.	Elke dienst beslist autonoom binnen zijn eigen wettelijke kader. Attesten van de ene binden de andere niet.	Medische erkenning leidt niet automatisch tot fiscale bescherming.
Data-keten CM → KSZ → Parentia / SVB	Wettelijke gegevensuitwisseling via de Kruispuntbank en het Europese EESSI-netwerk.	Parentia en SVB zijn blind afhankelijk van de broncode die CM invoert. Wanneer CM niet levert, valt de hele keten stil.	Gezinsbijslag en sociale toeslagen bevroren zonder dat de begunstigde iets kan forceren.

Verhouding	Formeel gezag	Feitelijke praktijk	Gevolg voor het gezin
EU-infrastructuur Kanaal 1 FOD Fin ↔ Belastingdienst NL	Gekoppeld via EU-richtlijnen (DAC) en het bilateraal belastingverdrag.	Volledig geautomatiseerde uitwisseling over wereldinkomen. Maximale transparantie voor heffing en terugvordering.	De EU weet alles over inkomsten, maar biedt geen vangnet bij het wegvallen ervan.
Verdragskanaal Kanaal 2 CM ↔ CZ / CAK	Gekoppeld via formulier S072 (Verordening 883/2004).	Smal, eenmalig kanaal. Wringt zodra zorg of status buiten het standaardformulier valt.	Voortdurende frictie over machtigingen, pakketgrenzen en eigen bijdragen.
Medisch vlak Kanaal 3 Vitaz · UZ Gent ↔ ZorgSaam · Pallion	Geen koppeling over de landsgrens.	Nationale EPD-systemen zijn hermetisch gesloten bij de staatsgrens.	Het gezin draagt zelf de dossiers. De patiënt wordt de enige kabel tussen twee systemen.
Politiek ↔ uitvoering Kamer BE & Tweede Kamer NL	Parlementen zijn de hoogste wetgever en controleren de regering.	Politiek grijpt niet in bij individuele uitvoeringsdossiers.	Structurele weeffouten in de wet blijven in de uitvoering bestaan.
EU ↔ lidstaten EU-buitenlaag	Unierecht heeft voorrang op nationaal recht (Verordening 883/2004).	De EU mist een eigen uitvoeringsloket. SOLVIT is vrijblijvend. ELA weigert burgers.	Cirkelverwijzing tussen Brussel en de nationale hoofdsteden.
Symboliek Koninklijk Paleis BE & Koninklijk Huis NL	Constitutioneel staatshoofd, geen uitvoerende macht.	Ceremoniële postbus. Verzoekschriften	Eindhalte stuurt brieven terug naar

Verhouding	Formeel gezag	Feitelijke praktijk	Gevolg voor het gezin
		worden doorgeleid naar de minister.	de startpositie in Laag 1.

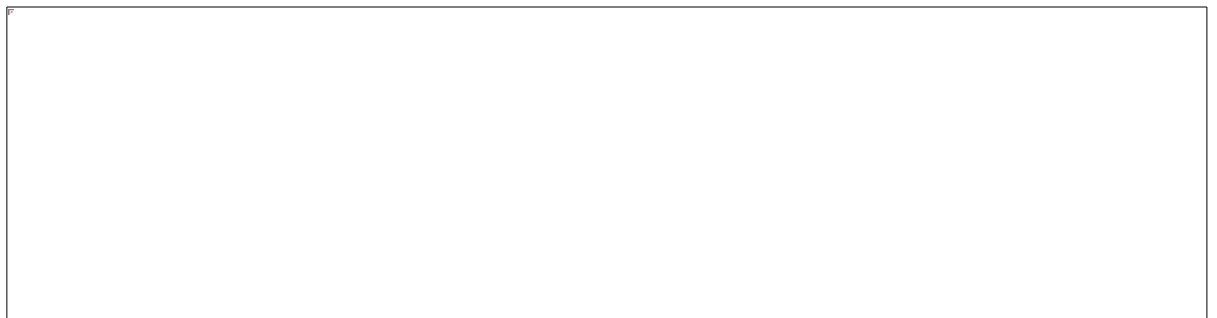
Alle organisaties die in dit hoofdstuk worden genoemd zijn rechtspersonen; hun namen zijn publiek en worden vermeld in Document B. Natuurlijke personen worden uitsluitend aangeduid met hun functie of met een symbool (σ , φ , kleine σ). Dit is zowel een methodologische keuze als een verplichting onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De auteur van dit dossier is de patiënt over wie het gaat; zijn eigen medische en administratieve gegevens mag hij publiceren.

De cascade

Blok II toont straks de potjes, het mechanisme en de beslissing. Dit hoofdstuk toont wat er gebeurt wanneer het mechanisme en de beslissing samenkomen op één gezin, in één tijdlijn, met één zichtbaar gevolg: een lege bankrekening.

Frame 1 — De trigger

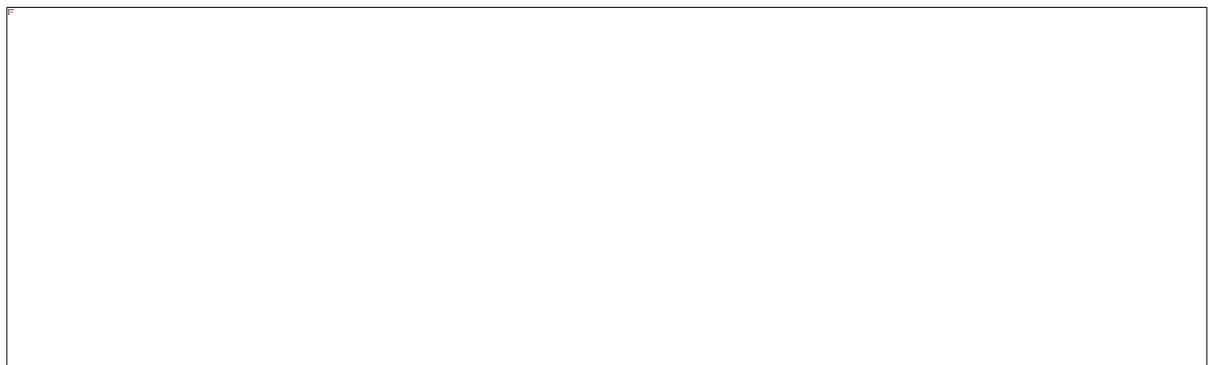
11 APRIL 2025 · WEEK 1



Het lichaam valt binnen. Medisch verslag en factuur splitsen zich: het verslag blijft in het ziekenhuis, de factuur gaat naar het ziekenfonds. Het remgeld gaat rechtstreeks van de bankrekening.

Frame 2 — Wat blijft stromen

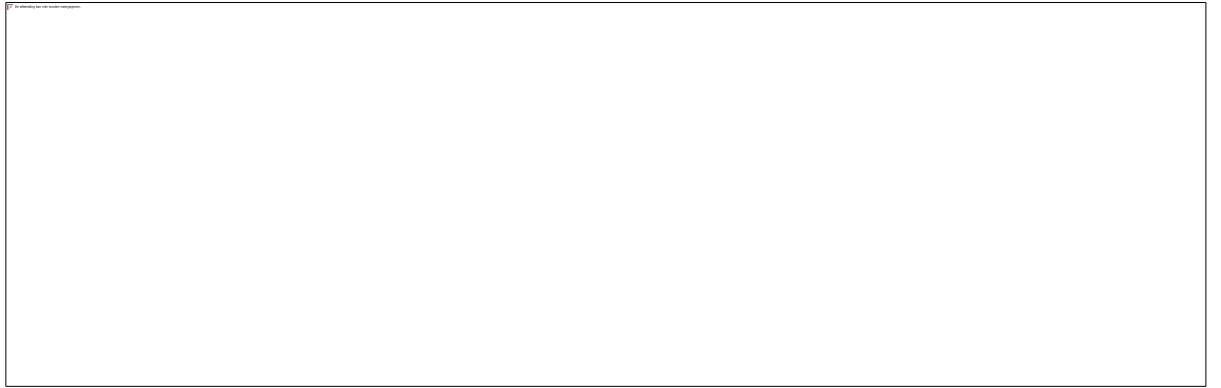
DOORLOPEND · VANAF DAG 1



Eén lijn blijft onafgebroken stromen: de moeder. Alles wat de vader aanbrengt, stopt.

Frame 3 — Wat weglekt

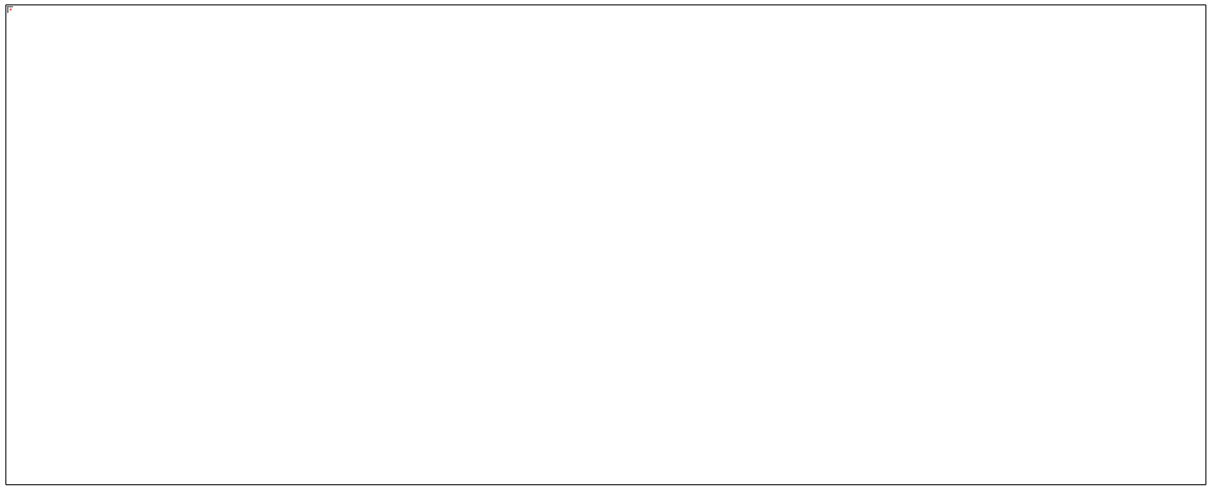
APRIL 2025 · DOORLOPEND



Terwijl het loon van de moeder binnenkomt, lekt het er aan de andere kant uit. Klein en voorspelbaar, of groot en plots. Het reservoir loopt leeg.

Frame 4 — Wat niet binnenkomt

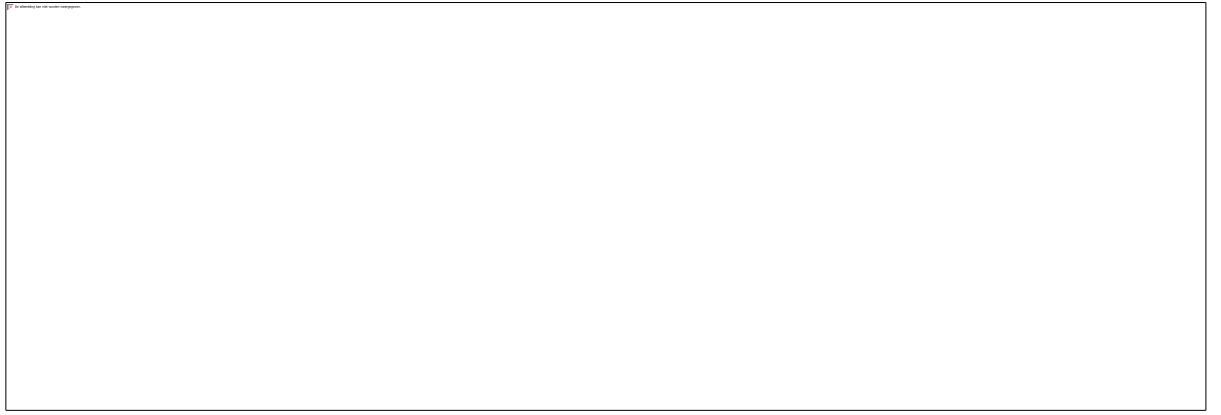
MEI 2025 — SEPTEMBER 2026 · GEBLOKKEERD



Vijf kanalen zouden moeten stromen om het wegvallen van het loon op te vangen. Vier blokkeren. Eén klein kanaal — kinderbijslag — houdt het gezin net boven nul.

Frame 5 — Het resultaat

NAJAAR 2026 · ACHTTIEN MAANDEN LATER



Achttien maanden later staat de rekening onder nul. De commerciële bank biedt een oplossing met sancties. Het incassobureau is ingeschakeld. En het systeem dat dit had moeten opvangen, levert nog steeds niets.

De cascade is geen keten van fouten. Het is één mechanisme dat in vijfvoud reageert op één gebeurtenis. Elke schakel heeft een eigen wet, een eigen loket, een eigen logica. Geen enkele schakel ziet de volgende. En de bankrekening is de enige plek waar alle schakels samenkomen — als resultaat, niet als oorzaak.

De feiten zijn gebaseerd op Document B. Bedragen zijn terug te vinden in de feitelijke entries per organisatie. Natuurlijke personen worden aangeduid met symbolen (σ , φ); organisaties met hun publieke naam.

II. België

De potjes en de koppelverkoop

Een gezin dat door ziekte zijn inkomen verliest, kan in België en Nederland een reeks tegemoetkomingen aanvragen. Deze zijn verspreid over twee landen, twee fiscale stelsels, twee socialezekerheidsstelsels en twee uitkeringslogica's. Dit hoofdstuk inventariseert eerst welke potjes er zijn. Daarna toont het waarom de meeste potjes gesloten blijven — niet door één oorzaak, maar door een mechaniek die in beide landen terugkomt.

Deel II-A — De potjes

Het gezin heeft in theorie recht op of kan in theorie aanspraak maken op de volgende tegemoetkomingen. De status per potje is gebaseerd op Document B.

Belgische potjes

Potje	Beheerder	Voorwaarde	Status
Ziekte-uitkering (arbeidsongeschiktheid, eerste jaar)	CM	Arbeidsongeschikt verklaard + wachttijd vervuld	Geblokkeerd — wachttijd 180 dagen niet toegepast met Europese samentelling
Invaliditeitsuitkering (na 1 jaar arbeidsongeschiktheid)	CM	Automatische overgang na 365 dagen arbeidsongeschiktheid	Geblokkeerd — fictieve einddatum voorkomt overgang
IVT (inkomensvervangende tegemoetkoming)	FOD Sociale Zekerheid / DG HAN	Erkende handicap + verminderd verdienvermogen + woonplaats België	Geblokkeerd — woonplaatsseis, geen Belgisch domicilie

Potje	Beheerder	Voorwaarde	Status
Verhoogde belastingvrije som	FOD Financiën	Erkenning zware handicap (9 punten)	Geblokkeerd via DG HAN, geactiveerd via fiscale bypass (zie Hoofdstuk II — De Belgische fiscale route)
Kinderbijslag / Groeipakket	Parentia	Kind ten laste + werklandbeginsel (moeder werkt in België)	Werkt — hoofdbetaler op naam moeder, aangevuld door SVB
Sociale toeslag (binnen Groeipakket)	Parentia	Gezinsinkomen onder drempel + 6 opeenvolgende maanden	Geblokkeerd — Parentia toetst aan theoretisch verdienvermogen, niet aan werkelijk inkomen
MAF (maximumfactuur)	CM	Remgeld boven plafond — verhoogd plafond bij erkenning handicap	Gedeeltelijk — gewone MAF actief, verhoogde MAF geblokkeerd door weigering invaliditeit
Fiscale aftrek medische kosten	FOD Financiën	Bewijs van medische uitgaven via jaarlijkse aangifte	Gedeeltelijk — aftrekbaar maar beperkte impact zolang ander inkomen laag blijft
Tegemoetkoming hulpmiddelen	CM (via RIZIV-conventie)	Medische voorschriften en goedkeuring adviserend arts	Werkt — orthopedische schoenen goedgekeurd,

Potje	Beheerder	Voorwaarde	Status
			diabetesconventie actief
Diabetische voetkliniek UZ Gent	CM (conventie)	Conventie met academisch ziekenhuis	Werkt — goedgekeurd 19-06-2026 tot 27-05-2027
Europese parkeerkaart	FOD Sociale Zekerheid	Erkenning handicap	Toegekend — 03-08-2026, onbepaalde duur
OV-verminderingskaart	FOD Sociale Zekerheid	Erkenning handicap + specifieke mobiliteitsdrempel	Geweigerd — 21-08-2026, niet aan medische voorwaarden voldaan
Rijgeschiktheidsattest	FOD Mobiliteit / oogarts	Visus boven wettelijke drempel	Afgewezen — visus onder drempel, blijvend

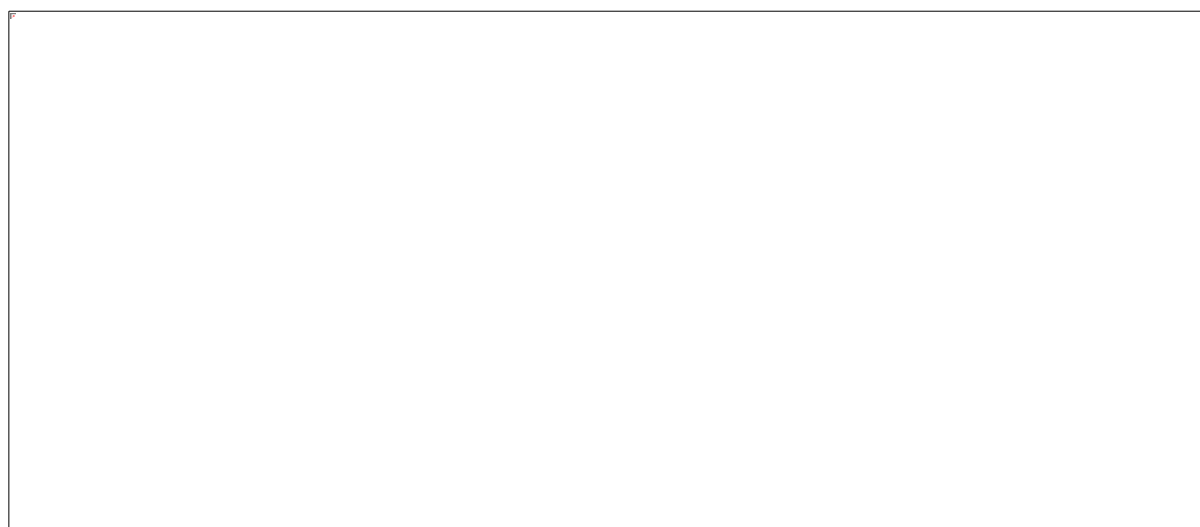
Nederlandse potjes

Potje	Beheerder	Voorwaarde	Status
WIA-uitkering (arbeidsongeschiktheid)	UWV	104 weken wachttijd + verzekering op peildatum	Geblokkeerd — peildatum foutief, Vester-arrest niet toegepast

Potje	Beheerder	Voorwaarde	Status
Bijstandsuitkering (Participatiewet)	Gemeente Hulst	Onvoldoende inkomen + vermogen onder grens	Geblokkeerd — hulpvraag na 73 dagen ongelezen verwijderd
Bijzondere bijstand	Gemeente Hulst	Bijzondere kosten + inkomen onder grens	Geblokkeerd — geen inhoudelijke beoordeling
Zorgtoeslag	Dienst Toeslagen	Verzekerd in Nederland + inkomen onder grens	Geblokkeerd — RIV- register bevat geen verdragspolis
Huurtoeslag	Dienst Toeslagen	Huur boven grens + inkomen onder grens	Deels — toegekend, bedrag herzien o.b.v. onvolledig inkomen
Kindgebonden budget	Dienst Toeslagen	Kind + inkomen onder grens	Deels — toegekend na SVB-koppeling
Kinderbijslag	SVB	Kind ten laste + woonlandbeginsel	Toegekend — klein bedrag, actief sinds 20- 04-2026

Grensoverschrijdende aanspraken

Aanspraak	Grondslag	Voorwaarde	Status
Samentelling verzekeringstijdvakken	Verordening 883/2004 art. 6	Verzekeringstijdvakken in meerdere EU-lidstaten	Niet toegepast — CM en UWV passen nationale referteperiodes toe
Pro-rata berekening	Verordening 883/2004 art. 52	Recht op uitkering onder samentelling	Niet toegepast — voorwaarde: erkenning van recht op uitkering
Vester-arrest toepassing	HvJ C-134/18	Inkomenshaat bij opeenvolgende verzekeringen in twee lidstaten	Niet toegepast — UWV weigert, CM weigert



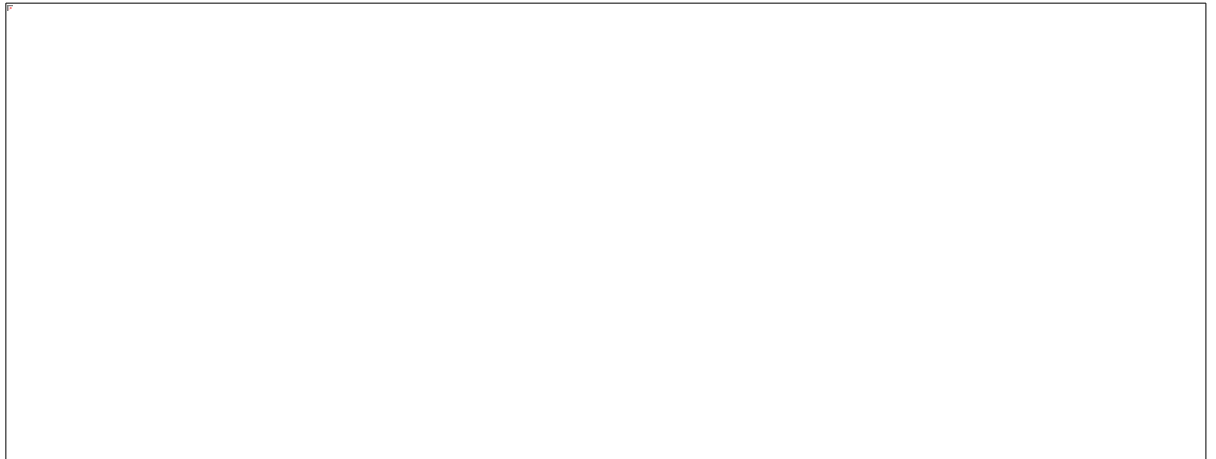
Figuur II.1 — De inventaris. Rond het gezin liggen de potjes waarop aanspraak bestaat of zou kunnen bestaan. Groen = werkt. Oranje = gedeeltelijk of met omweg. Rood = geblokkeerd of niet aangevraagd. Links de Belgische potjes, rechts de Nederlandse. De groene potjes zijn klein of indirect. De grote inkomenspotjes zijn allemaal rood.

Deel II-B — De koppelverkoop

De potjes zijn niet onafhankelijk van elkaar. In beide landen bestaat een **koppelverkoop**: een medische vaststelling leidt tot twee mogelijke gevolgen — een uitkering en een fiscaal voordeel — maar het fiscale voordeel wordt pas

toegekend nadat de uitkeringsroute is erkend. Juridisch zijn het twee afzonderlijke routes. Administratief worden ze aan elkaar geketend.

Hoe de koppelverkoop werkt



Figuur II.2 — De koppelverkoop. Eén medische vaststelling, twee routes. De fiscale route wordt niet zelfstandig beoordeeld, maar geketend aan de uitkeringsroute. In beide landen toegepast, met een eigen administratieve variant.

Waarom dit voor een grensarbeider fataal is

Een nationale burger heeft één systeem. Als de koppelverkoop knelt, kan hij bij één loket procederen. Een grensarbeider heeft twee nationale systemen die hem niet als één persoon zien.

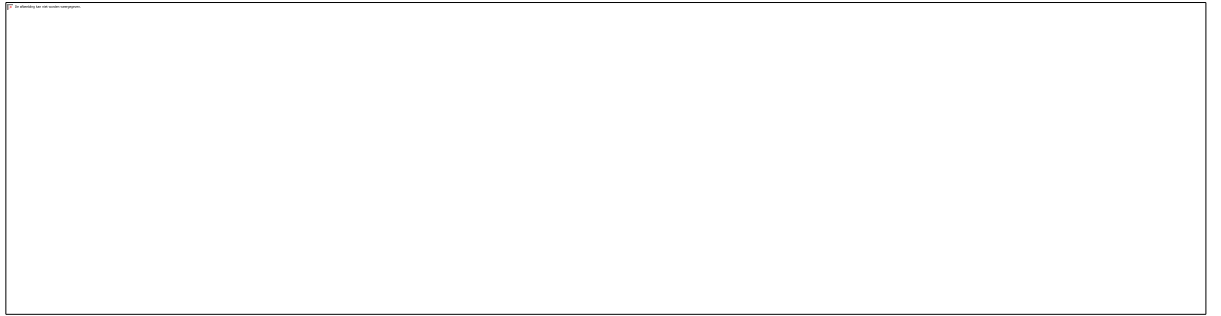
In het woonland (Nederland): *u woont hier, dus wij zijn niet bevoegd voor de uitkering, want u werkte in België.* In het werkland (België): *u werkt hier, maar u woont in Nederland, dus wij hoeven de fiscale voordelen niet toe te kennen.* Elk systeem past zijn eigen koppelverkoop toe, en geen enkel systeem lost die op door de medische vaststelling los te koppelen.

Het EESSI-netwerk en Verordening 883/2004 voorzien in samentelling van tijdvakken (artikel 6) en pro-rata berekening (artikel 52). Maar ze voorzien niet in het *loskoppelen* van de medische vaststelling van de uitkeringsvoorwaarden. Die loskoppeling is een nationale bevoegdheid, en geen van beide staten past hem toe voor grensarbeiders.

Deel II-C — De vier catch-22's

De koppelverkoop leidt in de praktijk tot een reeks cirkelredeneringen. Hieronder de vier meest voorkomende.

Catch-22 nr. 1 — De wachttijd die niet telt



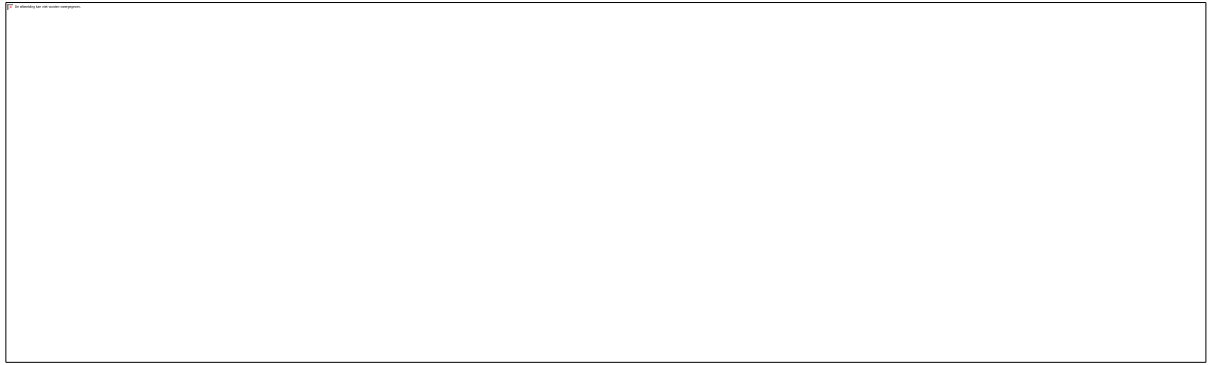
CM weigert omdat de nationale wachttijd niet is vervuld. UWV wacht op een Belgische beslissing voordat het Vester-arrest wordt toegepast. De burger zit tussen twee instanties die elk een eigen voorwaarde stellen die door de andere instantie onvervulbaar is gemaakt.

Catch-22 nr. 2 — De 8 versus 9 punten



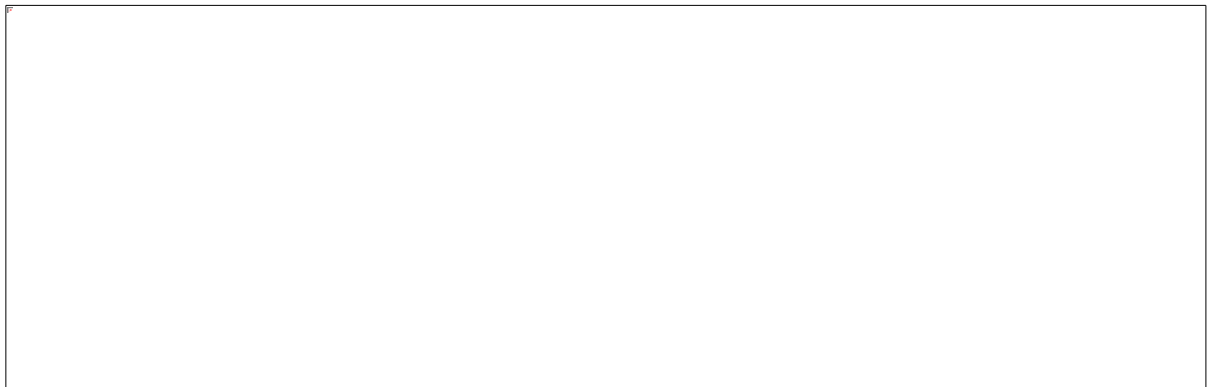
Een federale instantie kent een formeel erkende handicap toe. Een andere federale instantie eist een strengere drempel voor het fiscale gevolg. De burger moet het dossier heropenen bij de eerste instantie om een punt méér te halen — voor een fysieke realiteit die door vijf onafhankelijke zorgverleners al is vastgesteld.

Catch-22 nr. 3 — De data die niet stroomt



De CM registreert de ziektestatus niet in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Parentia, SVB en de Nederlandse Toeslagen lezen allemaal via diezelfde KSZ of via een afgeleide daarvan. Eén bronblokkade bij één instantie bevriest zes andere uitbetalingen.

Catch-22 nr. 4 — De MAF die stijgt noch daalt



Het ziekenfonds beheert zowel de maximumfactuur (MAF) als de invaliditeitserkenning. Wie erkend is als invalide krijgt een lager eigen-risicoplafond — minder remgeld, meer terugbetaling. Omdat hetzelfde ziekenfonds de erkenning weigert, blijft het gezin op het gewone plafond. De patiënt betaalt dus méér remgeld dan een invalide met dezelfde fysieke toestand. Dezelfde instantie heeft de medische waarheid vastgesteld via de goedkeuring van hulpmiddelen, maar weigert die waarheid te gebruiken om het financiële vangnet te verhogen.

Wat dit hoofdstuk vaststelt

Het gezin heeft recht op een breed scala aan tegemoetkomingen. In theorie dekt het netwerk van de twee verzorgingsstaten samen bijna elk aspect van de medische en financiële situatie. In de praktijk blijft meer dan de helft van de potjes gesloten. Niet omdat de voorwaarden onervulbaar zijn, maar omdat de wegen ernaartoe zo zijn ingericht dat ze elkaar blokkeren.

De koppelverkoop tussen de uitkeringsroute en de fiscale route is het meest voorkomende mechanisme. De catch-22's zijn de uitkomst daarvan: cirkelredeneringen tussen twee nationale systemen die elkaar niet lezen, en

tussen federale instanties binnen hetzelfde systeem die elkaars drempels niet erkennen.

Het volgende hoofdstuk zoomt in op de actoren die deze catch-22's in stand houden — niet als personen, maar als functies binnen een architectuur.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden uitsluitend aangeduid met hun functie of met een symbool (σ , φ). Dit is zowel een methodologische keuze als een verplichting onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De potjes-inventaris is gebaseerd op Document B, dat de feitelijke aanvragen, statussen en weigeringen per organisatie vastlegt.

Vaststelling en beslissing

Vijf zorgverleners onderzochten het lichaam. Twee administratieve artsen beslisten erover. Dit hoofdstuk toont dat beide instanties — het Belgische ziekenfonds en de Belgische federale overheidsdienst — hetzelfde mechanisme toepassen, elk met een eigen variant.

De vijf stemmen



Vijf zorgverleners, werkzaam in twee landen, onderzochten het lichaam. Alle vijf stelden dezelfde blijvende beperking vast.

Twee beslissers, één mechanisme



Figuur III.1 — Twee varianten, één mechanisme. Het ziekenfonds (variant A) laat een eigen arts beslissen zonder het lichaam te zien. De federale overheidsdienst (variant B) laat een eigen arts beslissen op basis van een meting die één punt onder de fiscale drempel valt. In beide gevallen weegt de administratieve drempel zwaarder dan de medische vaststelling.

Het gemeenschappelijke patroon

In beide gevallen is de beslissende arts **op de payroll van de instantie**. In beide gevallen wordt een administratieve drempel toegepast die niet in de behandelende wereld bestaat. In beide gevallen wegen vijf onafhankelijke medische vaststellingen minder zwaar dan één administratieve beslissing.

Dat is geen persoonlijke fout van een individuele arts. Het is de architectuur: de controlerend arts is geen betere arts, geen langere opleiding, geen diepere kennis. Hij is de *poortwachter* van een administratieve drempel. De poort is gesloten, niet omdat het lichaam niet kapot is — dat is vijf keer bewezen — maar omdat het algoritme achter de poort zegt: *de uitkering loopt niet, dus de erkenning loopt niet, dus de fiscale route loopt niet*.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden uitsluitend aangeduid met hun functie. De feiten zijn gebaseerd op Document B.

De Parentia-trap

Een instantie die de medische werkelijkheid aanvaardt, maar vervolgens struikelt over haar eigen inkomensmodel. Drie niveaus, één uitkomst. En het patroon keert terug bij een andere instantie.

Niveau 1 — De KSZ-blokkade

SEPTEMBER 2025 — APRIL 2026



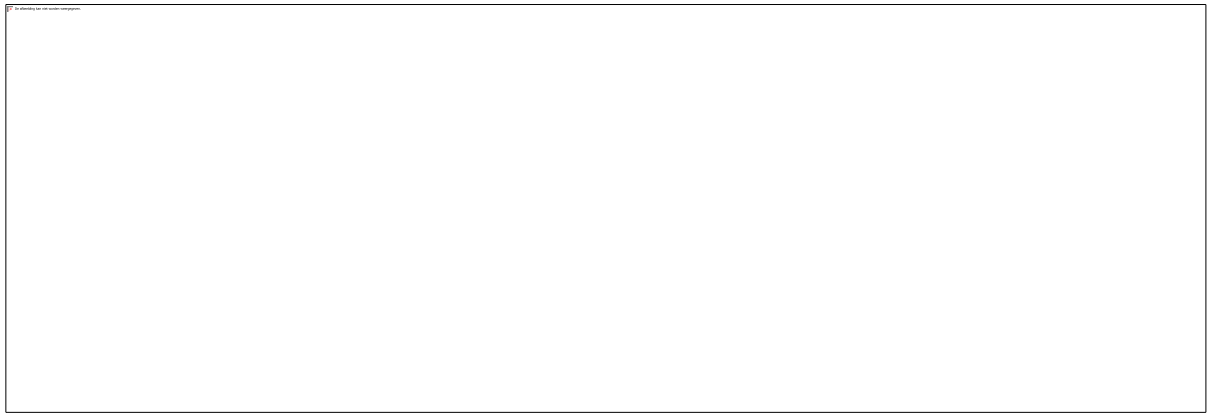
Niveau 2 — De bypass wordt aanvaard

APRIL — SEPTEMBER 2026



Niveau 3 — De inkomensweigering

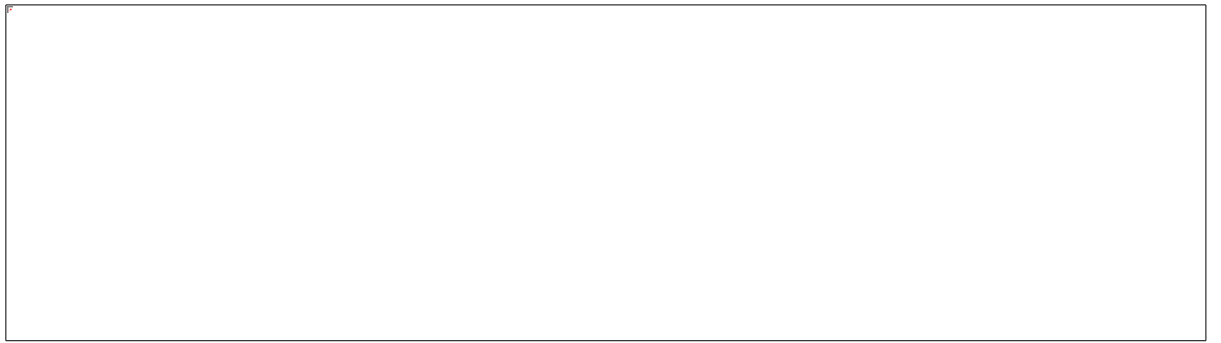
SEPTEMBER 2026



De medische weg is vrijgemaakt. Het bewijs is aanvaard. Dan blijkt het inkomensmodel de werkelijke situatie niet te lezen. De rekening klopt, het gezin valt eruit.

Het patroon keert terug

GEMEENTE HULST · 2026



Wat bij Parentia gebeurde, herhaalt zich bij de gemeente. Elke instantie heeft een eigen medische poort en een eigen tweede drempel. De burger loopt dezelfde trap opnieuw.

De Parentia-trap bestaat uit drie niveaus. Eerst wordt de medische weg geblokkeerd door een dataprobleem bij een andere instantie. Dan wordt de burger gedwongen een bypass te gebruiken — hetzelfde handmatige bewijs dat ook bij de fiscus werkte. Wanneer het medische bewijs is aanvaard, blijkt het inkomensmodel de werkelijke situatie niet te lezen. En wanneer de burger bij de volgende instantie aanklopt, begint de trap opnieuw.

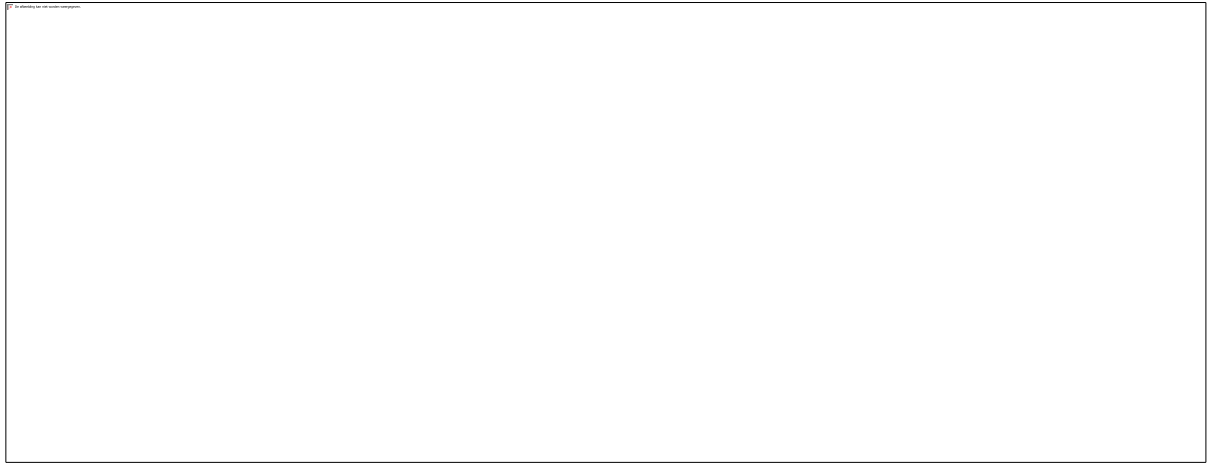
Feiten gebaseerd op Document B. Natuurlijke personen aangeduid met symbolen; organisaties met hun publieke naam.

De Belgische fiscale route

Tot nu toe toonde dit dossier vooral wat misloopt. Dit hoofdstuk toont het tegenbeeld: de Belgische fiscale route werkt, en levert het gezin jaarlijks een substantieel voordeel op. Vier aftrekposten en verminderingen, waarvan één via een bypass tot stand is gekomen. Die bypass is inmiddels tweemaal bevestigd — eenmaal door de indiening van de aangifte zelf, en eenmaal door een onafhankelijke schriftelijke bevestiging van de fiscus dat de gekozen route juridisch klopt.

Deel A — Wat er werkt

Fiscaal voordeel	Grondslag	Status in dit dossier
Verhoogde belastingvrije som (code invaliditeit)	Art. 131 en 135 WIB 92 · blijvend invalide ≥66% · verdienvermogen onder een derde	Geactiveerd via bypass, tweemaal bevestigd. Voordeel: € 2.669,97 in de gezamenlijke aangifte 2026.
Huwelijksquotiënt	Art. 87 WIB 92 · toerekening van een deel van het beroepsinkomen aan de partner met laagste inkomen	Automatisch toegepast bij de gezamenlijke aangifte. Verlaagt de belastingdruk op het gezinsinkomen.
Belastingvermindering kinderopvang	Art. 14535 WIB 92 · kosten voor opvang van kinderen onder 14 jaar	Attest opvang tijdens de vakantie handmatig toegevoegd aan de aangifte 2026.
Fiscale aftrek medische kosten	Art. 140-145 WIB 92 · medische kosten boven een percentage van het inkomen	Deels aftrekbaar. Beperkte impact zolang het inkomen laag blijft.



Figuur VI.1 — De vier werkende fiscale stromen. Drie groene stromen: verhoogde belastingvrije som, huwelijksquotiënt en kinderopvang. Eén oranje stroom: de medische kosten (drempel). Samen bepalen ze het fiscale voordeel in de jaarlijkse Belgische aangifte.

Deel B — De bypass voor de verhoogde belastingvrije som

Het probleem

Drie blokkades op de gewone weg:

- De ziekte-uitkering wordt geweigerd, dus geen erkenning van arbeidsongeschiktheid.
- De Kruispuntbank wordt niet bijgewerkt, dus andere instanties zien geen ziektestatus.
- De federale handicapdienst kent 8 punten toe. De fiscale drempel ligt op 9.

De oplossing



Figuur VI.2 — De fiscale bypass. Drie blokkades op de gewone weg. De belastingdienst is juridisch losgekoppeld van de uitkeringsroute en mag een eigen medisch bewijs aanvaarden. Eén document van de huisarts, opgesteld in de taal van de fiscus, activeert de verhoogde belastingvrije som zonder de centrale databank te wijzigen.

Deel C — De dubbele bevestiging

De bypass rust op één aanname: dat de fiscus een medisch attest van de huisarts aanvaardt zonder tussenkomst van de FOD Sociale Zekerheid. Die aanname is in dit dossier op twee onafhankelijke manieren bevestigd.

Eerste bevestiging — de indiening zelf

Op 25 september 2026 is de definitieve aangifte Belasting Niet-Inwoners (aanslagjaar 2026, inkomstenjaar 2025) ingediend door de fiscale dienst van het ACV. In de aangifte zijn opgenomen:

- De code invaliditeit voor de partner ten laste, op basis van het toegevoegde medisch getuigschrift van de huisarts.
- 1 kind ten laste.
- 2 attesten voor opvangkosten, handmatig toegevoegd.
- Bevestiging van € 0,00 aan Nederlandse inkomsten of uitkeringen.

Het resultaat: **€ 2.669,97 in het voordeel van het gezin**. De aangifte is op 25 september 2026 ingediend met een berekend saldo; definitieve verwerking en het aanslagbiljet van de FOD Financiën worden afgewacht.

Tweede bevestiging — de onafhankelijke toets

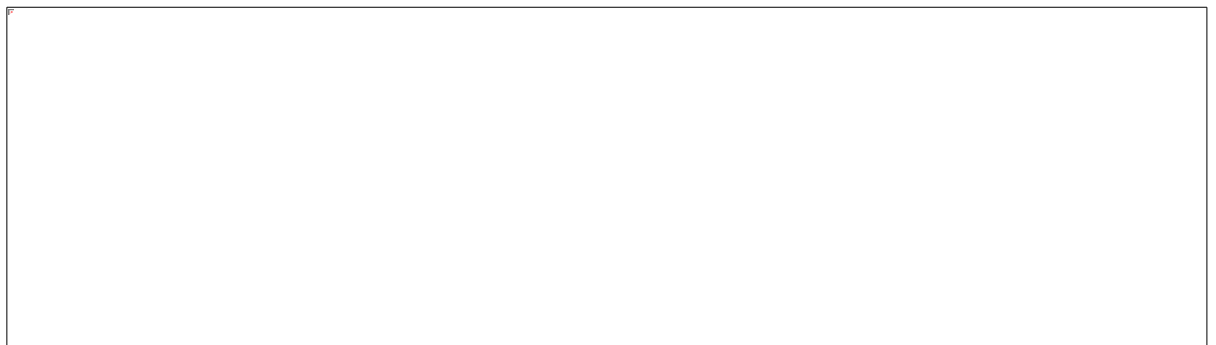
Parallel aan de indiening heeft een onafhankelijk onderzoeker grensarbeid — werkzaam aan een academische instelling en niet bij het dossier betrokken — bij de FOD Financiën een anonieme navraag gedaan. De vraag was of het

spontaan toevoegen van medische verklaringen bij de aangifte een geldige route is om de fiscale handicapstatus naar Belgisch recht aan te tonen.

De FOD Financiën, Team Beheer en Dienstverlening Belasting Niet-Inwoners (PG15 Ledeberg), heeft dit schriftelijk bevestigd. In twee opeenvolgende antwoorden stelt de fiscus dat:

- Bij afwezigheid van een vervangingsinkomen boven € 13.460 een fiscaal verschil ontstaat.
- Het nuttig is om spontaan de medische verklaringen bij de aangifte te voegen.
- De administratie daaruit kan afleiden dat de betrokkene naar Belgisch recht fiscaal als gehandicapt moet worden aangemerkt.

Wat dit oplevert, is dat de bypass niet alleen in de praktijk werkt, maar dat de fiscus zelf bevestigt dat de gekozen route juridisch klopt. Er is geen sprake meer van een gok of een gunst. Het is een formele bevestiging dat de weg die het gezin heeft gevonden, de juiste weg is.



Figuur VI.3 — De dubbele bevestiging. Dezelfde bypass-route is tweemaal bevestigd: eenmaal in de praktijk (de definitief ingediende aangifte met berekend voordeel), eenmaal in theorie (de schriftelijke bevestiging van de fiscus aan een onafhankelijke onderzoeker).

Deel D — AGODI: het bewegende doelwit en de uiteindelijke afronding

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) is het Vlaamse agentschap dat de loonadministratie van onderwijspersoneel verzorgt. In dit dossier is AGODI de werkgeversschakel van de moeder. Wanneer de federale fiscale voordelen worden geactiveerd, moet AGODI die doorvertalen naar de loonadministratie. En daar gaat het aanvankelijk mis.

De eerste weigering — 25 maart 2026

AGODI weigert de retroactieve wijziging van de bedrijfsvoorheffing inzake de lerarenvrijstelling onder het dubbelbelastingverdrag. De reden: de fiscale fiches uit het verleden zijn al afgeleverd.

De medische interpretatie — 24 augustus 2026

AGODI weigert de aanpassing op basis van het federale attest van 8 punten. De loonadministratie eigent zich een medisch-fiscale beoordeling toe: het attest zou uitsluitend geldig zijn voor een parkeerkaart, en er zijn normaal 9 punten vereist voor verminderde bedrijfsvoorheffing.

De volledige draai — 8 september 2026

Wanneer het sluitende medische getuigschrift (blijvend invalide $\geq 66\%$, verdienvermogen verminderd tot een derde) wordt ingediend, draait AGODI volledig. De instantie stelt plots dat zij geen bewijsstukken hoeven te ontvangen, dat de school uitsluitend een elektronische aanpassing moet sturen, en dat de belastingen uiteindelijk de afrekening maken.

De definitieve afronding — 25 september 2026

Het schoolsecretariaat heeft op 23 september 2026 het officiële bericht "wijziging fiscale toestand mindervalide partner" geregistreerd in het personeelssysteem Informat (berichtnummer 4, [stamboeknummer partner]). Met dit elektronische signaal wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026 vastgelegd dat de partner ten laste geen beroepsinkomsten heeft en formeel als mindervalide staat geregistreerd. De administratieve weg is daarmee volledig afgelegd.



Deel E — Wat dit hoofdstuk vaststelt

De Belgische fiscale route werkt — volledig. Vier aftrekposten, één bypass, een gezamenlijke aangifte met een substantieel voordeel. De bypass is tweemaal bevestigd: eenmaal in de praktijk, eenmaal door de fiscus zelf. En de laatste instantie in de keten (AGODI) heeft uiteindelijk het elektronische signaal

afgegeven waarmee de fiscale status met terugwerkende kracht is geregistreerd.

Wat dit hoofdstuk laat zien, is dat er binnen hetzelfde systeem dat de grensarbeider op andere terreinen structureel uitsluit, wel degelijk wegen zijn die werken. De fiscale route is er één. Ze is niet afhankelijk van de ziekenfondsregistratie, niet van de handicapdienst, niet van de Europese coördinatie. Ze loopt rechtstreeks van huisarts naar fiscus.

En wat even belangrijk is: de route is door de fiscus zelf bevestigd, en door een onafhankelijke onderzoeker getoetst. De uitkomst is niet het gevolg van een gunst. Het is het gevolg van een correcte toepassing van de wet, door een burger die de weg heeft gevonden om de geblokkeerde kanalen te omzeilen.

Voor wie in dezelfde situatie zit: vraag uw huisarts om een attest op te stellen dat de fiscale taal spreekt (artikel 131 en 135 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen). De federale handicapdienst is voor de fiscale route niet vereist. De ziekenfondsregistratie is niet vereist. Het attest gaat rechtstreeks naar de belastingaangifte.

Een fiscaal adviseur (in België via een vakbond of boekhouder) kan dit attest aan de aangifte toevoegen. De code invaliditeit wordt in de aangifte ingevuld en de verhoogde belastingvrije som wordt automatisch toegepast.

Vergeet niet ook de andere aftrekposten te controleren: huwelijksquotiënt, kinderopvang. Deze worden niet altijd automatisch toegepast.

De bedragen zijn gebaseerd op de belastingaangifte 2026 en kunnen per dossier variëren. De wetteksten zijn artikel 87, 131, 135, 140-145 en 14535 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool. Dit hoofdstuk is geen fiscaal advies.

De heropening

Wie een beslissing van de federale handicapdienst ontvangt en het er niet mee eens is, leest op de brief dat hij naar de arbeidsrechtbank kan. Wat de brief niet vermeldt: er zijn vier andere wegen, goedkoper en sneller, die de burger zelf kan bewandelen.

Wat de brief zegt

Wat de website zegt

Op de website van de federale handicapdienst staan vier wegen die de burger zelf kan bewandelen — zonder advocaat, zonder rechtbank. Ze heten een **heropening**. Ze zijn schriftelijk aan te vragen via het contactformulier of per brief.

Figuur VII.1 — De vier wegen van de heropening. Ze staan op de website van de federale handicapdienst, niet in de brief. Ze zijn schriftelijk aan te vragen, zonder advocaat, zonder rechtbank.

Wat dit oplevert

Een heropening is geen beroep bij de rechter. Het is een verzoek aan dezelfde instantie om de beslissing opnieuw te bekijken — met nieuwe argumenten, nieuwe bewijzen, of een verduidelijking waarom de eerdere beslissing niet klopt. De behandelend arts kan daarbij helpen: hij of zij kan schriftelijk uitleggen waarom de beslissing van de handicapdienst niet juist is.

In tegenstelling tot een rechtszaak kost een heropening geen advocaat en geen griffierechten. Het is een brief of een online formulier. En de beslissing komt opnieuw van dezelfde instantie, maar nu met de argumenten van de behandelend arts erbij.

Voor wie in dezelfde situatie zit: kreeg u een beslissing van de federale handicapdienst waar u het niet mee eens bent? Kijk op de website *handicap.belgium.be* onder "Een heropening aanvragen". Er zijn vier situaties beschreven. Kies de situatie die bij u past, dien de aanvraag schriftelijk in binnen drie maanden, en vraag uw huisarts om een begeleidende brief. Dit is geen rechtszaak — het is een verzoek tot herziening.

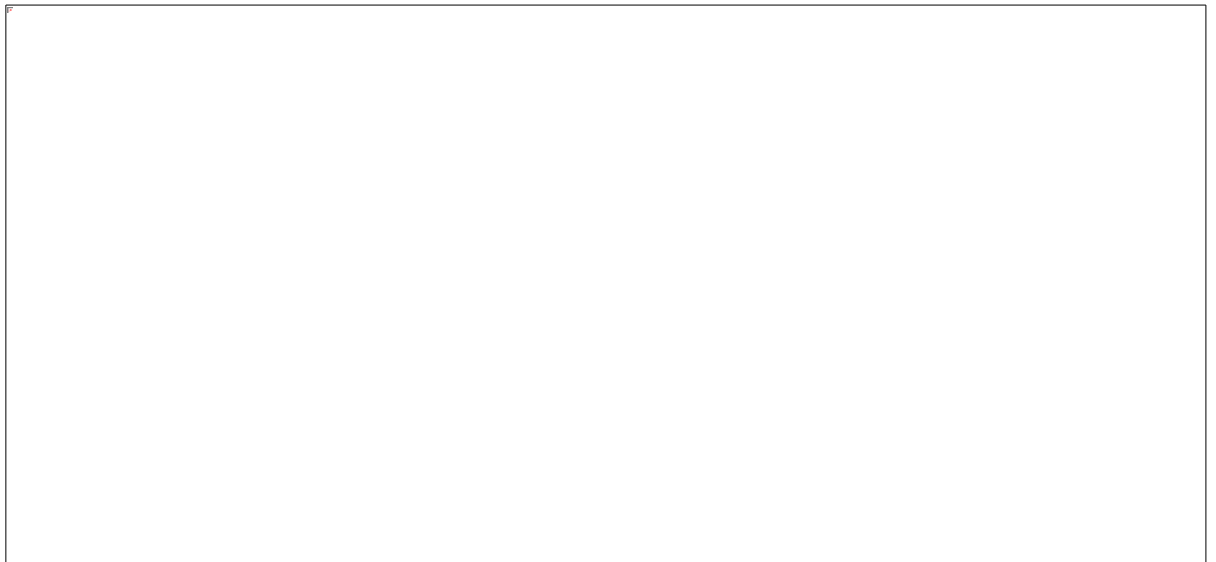
Let op: de wettelijke termijn om naar de arbeidsrechtbank te gaan blijft drie maanden. Vraag bij twijfel juridisch advies voordat u die termijn laat verstrijken.

*De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op de officiële pagina "Een heropening aanvragen" van de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap), laatst bijgewerkt op 15 september 2025. De wettelijke basis en de procedure staan op *handicap.belgium.be*. Dit hoofdstuk is geen juridisch advies; raadpleeg bij twijfel een gespecialiseerde dienst of advocaat.*

De CM en de geldstromen

Het ziekenfonds is geen bank met één rekening. Het is een instelling met drie gescheiden geldstromen: de verplichte ziekteverzekering, het pakket CM-diensten en -voordelen, en de facultatieve verzekeringen. De eerste stroom komt van de overheid via de RSZ. De tweede van het lidgeld. De derde van aparte premies. En elk van die stromen voedt een ander loket. Dit hoofdstuk toont waar het geld vandaan komt, waarom de ene tak wel werkt en de andere niet, en wie uiteindelijk kan ingrijpen wanneer de CM weigert.

Deel A — De drie geldstromen



Figuur XIV.1 — De drie geldstromen. De verplichte ziekteverzekering wordt gefinancierd uit RSZ-bijdragen en belastingen, beheerd door het RIZIV, en uitgevoerd door de ziekenfondsen. De CM-diensten en -voordelen worden gefinancierd uit het lidgeld. De facultatieve verzekeringen uit aparte premies. Elk van de drie stromen voedt een ander loket.

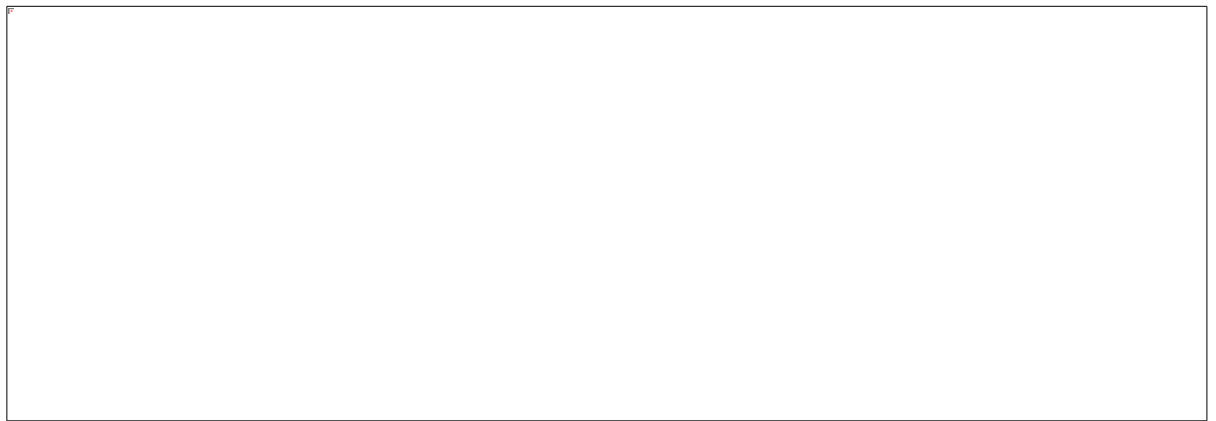
Deel B — De RSZ-bijdrage en de bestemming

De verplichte ziekteverzekering wordt niet rechtstreeks door de CM betaald. De werkgever houdt een deel van het loon in en stort dat aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De RSZ verdeelt het geld over de sociale zekerheidstakken. Voor de ziekteverzekering zijn er twee aparte takken:

- **Geneeskundige verzorging** — de terugbetaling van medische prestaties, geneesmiddelen, hulpmiddelen en conventies. Bijdragevoet werknemer: ongeveer 3,55% van het brutoloon.

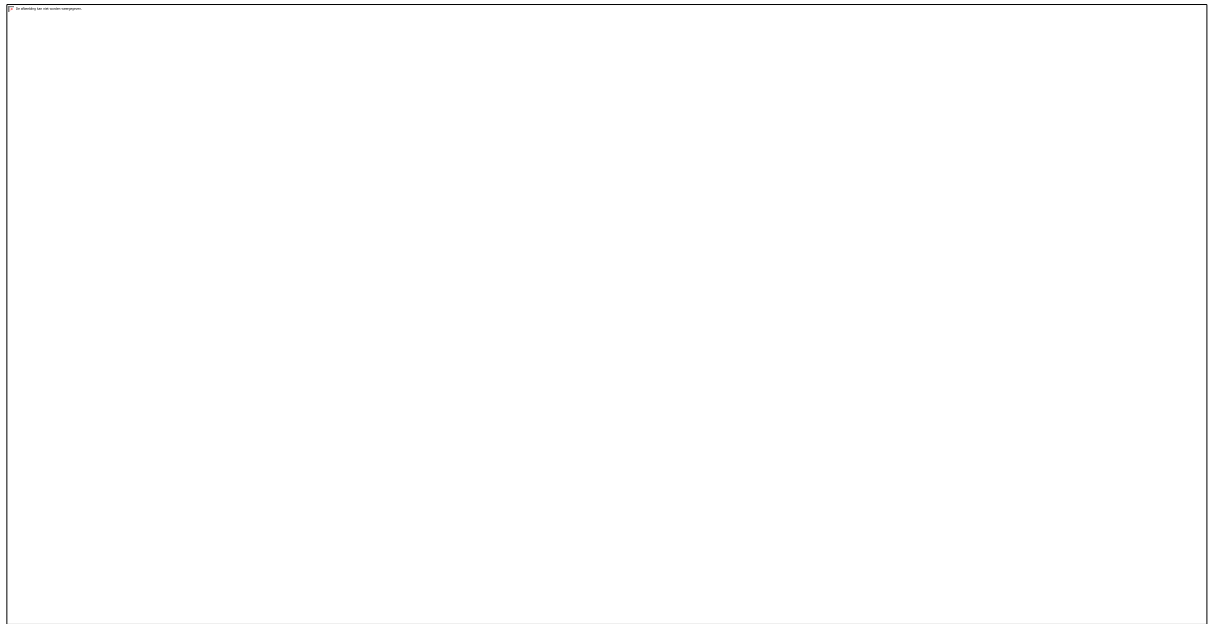
- **Uitkeringen** — de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Bijdragevoet werknemer: ongeveer 1,15% van het brutoloon.

Het RIZIV ontvangt het totaalbudget en verdeelt het over de ziekenfondsen. Elk ziekenfonds krijgt een budget op basis van het aantal leden en hun profiel. Het ziekenfonds betaalt daaruit de prestaties aan zijn leden. Voor de administratieve kosten ontvangt het ziekenfonds een aparte vergoeding.



Figuur XIV.2 — De weg van het loon naar de zorg. De werkgever houdt de RSZ-bijdrage in op het loon. De RSZ stort aan het RIZIV. Het RIZIV verdeelt over de ziekenfondsen. Het ziekenfonds betaalt uit de twee takken: geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Deel C — Waarom hulpmiddelen wel en uitkeringen niet



Figuur XIV.3 — Twee takken, twee logica's. De tak geneeskundige verzorging werkt met objectieve, meetbare prestaties. De tak uitkeringen werkt met subjectieve beoordelingen en nationale voorwaarden. Dezelfde instelling, dezelfde RSZ-bijdrage, maar een fundamenteel verschillende logica — en dus een fundamenteel verschillend resultaat.

Deel D — De CDZ als toezichthouder

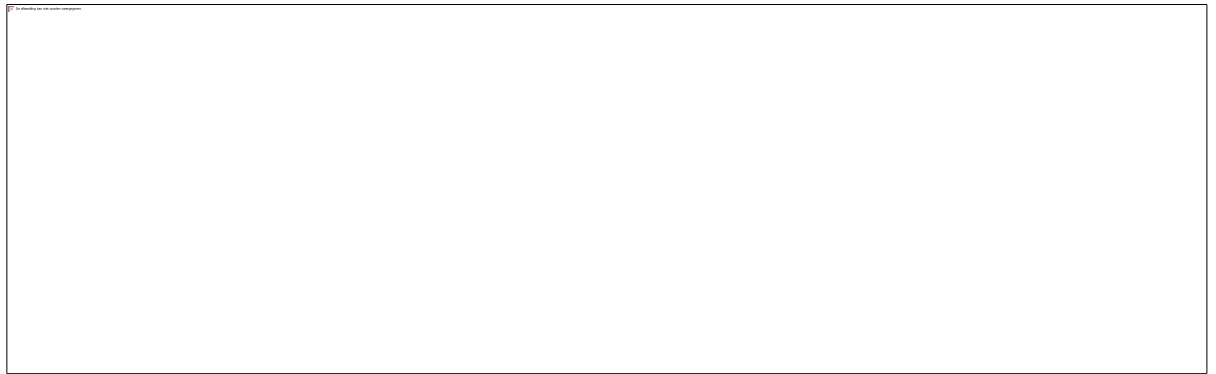
Op de CM als geheel — zowel de verplichte verzekering als de aanvullende diensten en de facultatieve verzekeringen — houdt de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) toezicht. De CDZ controleert de boekhouding, de financiële regels en de correcte toepassing van de wettelijke bepalingen. Ze kan adviezen formuleren aan de minister en statutaire wijzigingen goedkeuren.

Wat de CDZ niet doet: individuele geschillen beslechten. De CDZ is een administratieve toezichthouder, geen geschillenbeslechter. Ze kan de structurele werking van het ziekenfonds onderzoeken, maar geen beslissing in een individueel dossier herzien. Ze is geen beroepsinstantie.

Deel E — Het Arbeidsauditoraat: wie controleert de controleur?

Wanneer een uitvoeringsinstantie de wet structureel naast zich neerlegt, is er in België een justitiële instantie die in theorie kan ingrijpen: het Arbeidsauditoraat, het openbaar ministerie bij de arbeidsrechtbanken. Het is bevoegd voor de handhaving van de sociale zekerheidswetgeving en kan optreden wanneer een instelling de wet niet naleeft.

In dit dossier is op 10 september 2026 een formele melding gedaan aan het Arbeidsauditoraat Gent. De melding betrof structurele procedurefouten bij de CM, schending van de Europese coördinatieverordening, en het niet-naleven van RIZIV-onderichtingen. De integrale tijdlijn en het fiscaal-medisch getuigschrift werden als bewijsstukken bijgevoegd.



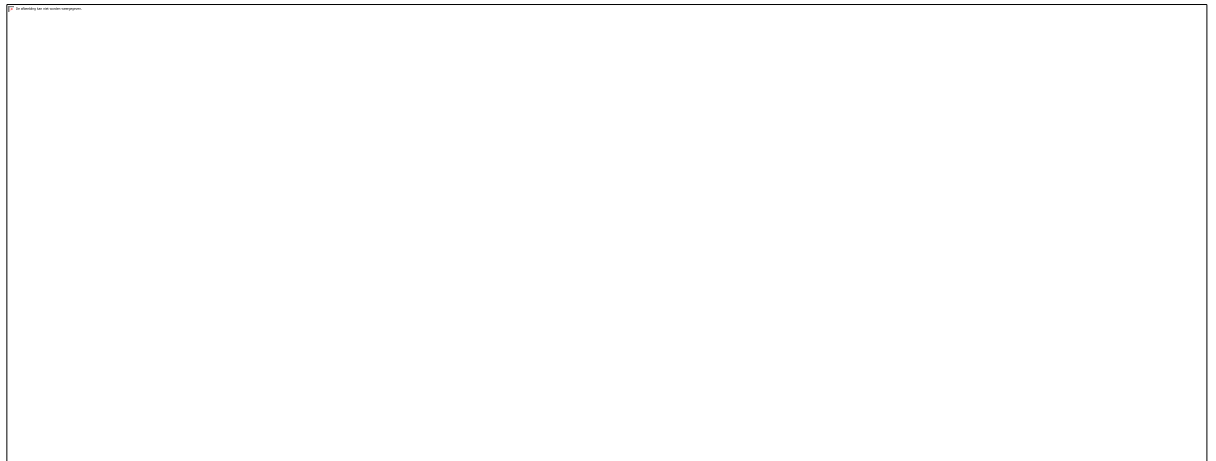
Figuur XIV.4 — Het Arbeidsauditoraat. De melding bereikt het Arbeidsauditoraat op 10 september 2026. De reactie komt één dag later: de instantie verklaart zich onbevoegd en kwalificeert de structurele blokkade als een burgerlijk geschil. De burger wordt doorverwezen naar de arbeidsrechtbank, de langzaamste weg.

Wat het Arbeidsauditoraat daarmee doet, is hetzelfde als wat de CDZ doet: het verantwoordelijkheidsvraagstuk doorschuiven. De instantie die zou moeten ingrijpen bij schending van de sociale wetgeving, kwalificeert het geschil als een privéaangelegenheid. En de burger blijft achter met een instantie minder om aan te kloppen.

Deel F — De Orde der Artsen: tuchtrecht tegen de adviserend arts

De Orde der Artsen is de wettelijke instantie die waakt over de medische deontologie en het tuchtrecht uitoefent op individuele artsen. Ze kan klachten onderzoeken, tuchtsancties opleggen — van waarschuwing tot schrapping uit het artsenregister — maar heeft geen bevoegdheid over administratieve beslissingen van instellingen of over algoritmische processen binnen een ziekenfonds.

In dit dossier is op 19 september 2026 een klacht ingediend bij de Provinciale Raad van Antwerpen tegen het functioneren van de adviserend arts van de CM. De klacht betreft het genereren van tegengestelde beslissingen onder een visueel identieke handtekening, zonder traceerbare toegang tot het actuele medische dossier. De vraag is of deze praktijk deontologisch verenigbaar is met de onafhankelijke uitoefening van de geneeskunde.



Figuur XIV.5 — De Orde der Artsen. De tuchtrechtelijke weg kan de individuele arts treffen, maar niet de architectuur die de beslissing voortbrengt. Zelfs een gegronde klacht verandert niets aan de uitkomst voor de patiënt, want het ziekenfonds vervangt de arts en het algoritme blijft ongewijzigd.

Deel G — Wat dit hoofdstuk vaststelt

De vraag waarom hulpmiddelen wel en uitkeringen niet worden betaald, heeft een structureel antwoord. De CM voert twee wettelijk gescheiden taken uit binnen de verplichte ziekteverzekering. De ene taak werkt met meetbare prestaties en vaste tarieven. De andere werkt met subjectieve beoordelingen en nationale voorwaarden.

Binnen dezelfde instelling bestaan dus twee verschillende regimes. Voor de geneeskundige verzorging hoeft de CM geen mens te beoordelen — ze betaalt een factuur. Voor de uitkeringen moet ze wél beoordelen of iemand arbeidsongeschikt is, en die beoordeling is onderworpen aan voorwaarden die de wet oplegt. Voor een grensarbeider zijn die voorwaarden problematisch, omdat ze zijn gebaseerd op nationale referteperiodes en verblijfsvoorwaarden.

En wanneer de CM weigert, blijken de twee toezichthoudende instanties — de CDZ en het Arbeidsauditoraat — zich niet bevoegd te achten voor individuele dossiers. De Orde der Artsen kan alleen de individuele arts treffen, niet het systeem dat de beslissing stuurt. De conclusie is geen beschuldiging van kwade wil. Het is de constatering dat het systeem de verantwoordelijkheid voor het geheel nergens belegt. Elke instantie doet haar eigen stukje. En geen enkele instantie draagt het geheel.

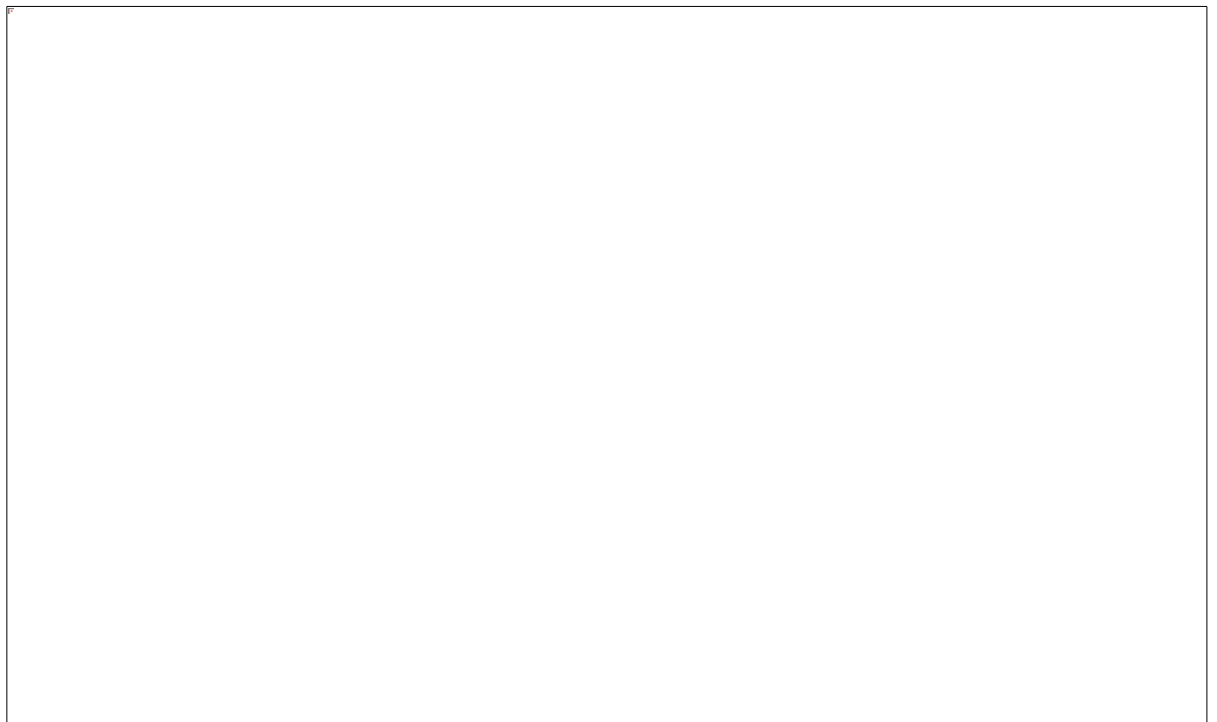
Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool (σ ; $\varnothing$). De informatie over de financiering is gebaseerd op de officiële communicatie van de CM, het RIZIV en de CDZ. De procedurele informatie over het Arbeidsauditoraat en de Orde der Artsen is gebaseerd op Document B en openbare bronnen. Dit hoofdstuk is geen juridisch of financieel advies.

III. Nederland

Het UWV en de bezwaarmolen

Het UWV beoordeelt of iemand arbeidsongeschikt is en of er recht bestaat op een uitkering. Wat volgt is geen weigering. Het is een reeks weigeringen. Elke weigering heeft een eigen reden, een eigen procedure, en een eigen uitkomst. Geen enkele weigering wordt inhoudelijk behandeld. En de RVA, de Belgische tegenhanger, hanteert op zijn beurt dezelfde tactiek in de tegenovergestelde richting.

Deel A — Zes rondes bij het UWV



Figuur IX.1 — De zes rondes. Vijf aanvragen, twee bezwaren, één herziening. Elke ronde eindigt met een formele afwijzing. In de hele keten wordt geen enkele keer de medische situatie inhoudelijk getoetst, ondanks vijf onafhankelijke medische vaststellingen en honderden pagina's bewijslast.

Deel B — De RVA en het C4-formulier

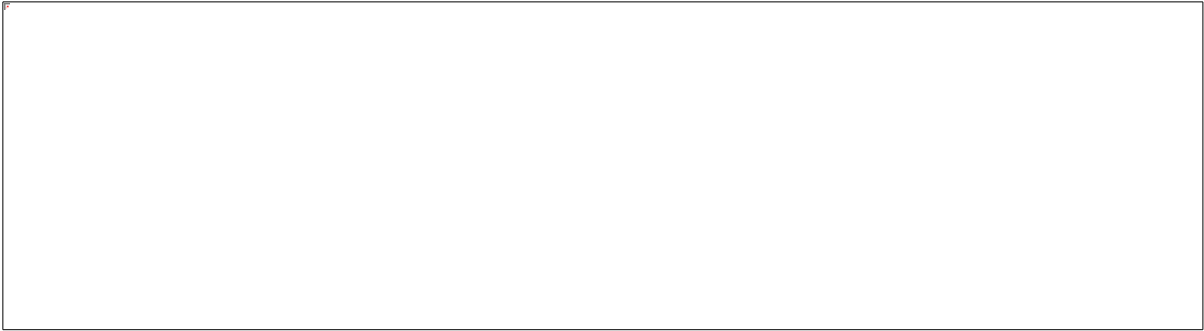
Het UWV is niet de enige instantie die een loopbaanbewijs blokkeert. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) hanteert op de Belgische zijde een vergelijkbare tactiek, maar dan voor de onderwijsloopbaan.

Het probleem met de onderwijsloopbaan

De partner werkt als vastbenoemde leerkracht in het Vlaamse onderwijs. Voor de aanvraag van het Europese loopbaanbewijs (PD U1) moet de RVA een formulier invullen dat de volledige onderwijsloopbaan documenteert. Maar de RVA blokkeert de aanvraag met de eis om een **C4-formulier**.

Wat is het C4-formulier? Het is een ontslagdocument uit de privésector. Het wordt gebruikt wanneer een werknemer in de privésector uit dienst gaat. Voor vastbenoemden in het onderwijs bestaat dit formulier juridisch niet. Er is geen ontslag, geen privéwerkgever, geen C4.

De RVA past dus de logica van de privésector toe op een loopbaan die volledig buiten dat kader valt. De instantie perst een publieke loopbaan in een private mal.



De RVA eist een C4-formulier voor een loopbaan die juridisch geen C4 kent. De aanvraag wordt geblokkeerd. De burger moet zelf een alternatief bewijs aanleveren via het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), dat de officiële Berekening Geldelijke Anciënniteit aflevert.

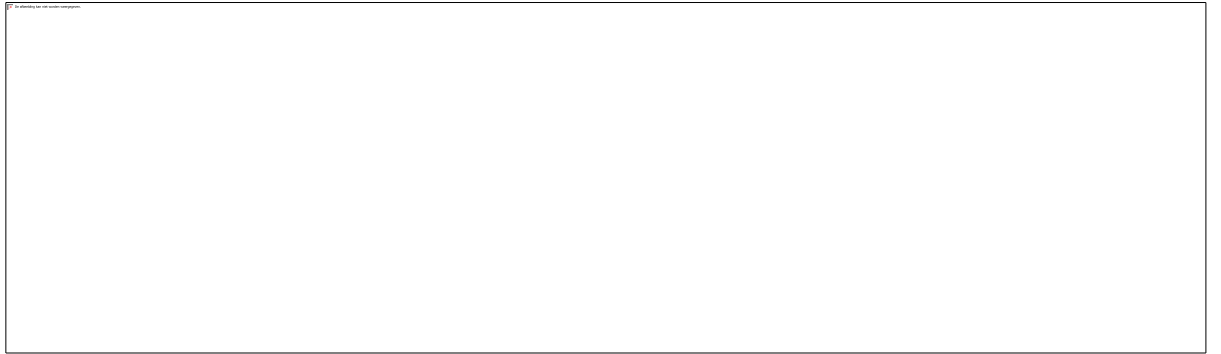
De handmatige aanlevering

De patiënt lost het op met een handmatige aanlevering van het AGODI-bewijs. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten levert een officieel document waaruit de volledige onderwijsloopbaan blijkt. Dat document wordt aan de RVA bezorgd, waarna het tweede PD U1-attest wordt afgeleverd.

Wat dit oplevert, is een derde laag van manuele tussenkomst. De patiënt werkt niet alleen als data-hub tussen twee landen, maar ook als data-hub tussen twee instanties binnen hetzelfde land: tussen de federale RVA en het Vlaamse AGODI. Twee overheidsniveaus die over dezelfde loopbaan beschikken, wisselen die gegevens niet automatisch uit.

Deel C — De weigering om buitenlandse data te synchroniseren

Na de afgifte van het tweede PD U1-attest dient de patiënt een formeel verzoek in om de Nederlandse loopbaangegevens te synchroniseren met de Belgische MyCareer-omgeving. De RVA weigert.



UWV levert de gegevens, RVA weigert ze te verwerken. De patiënt omzeilt de RVA via een andere federale instantie. Twee overheidsinstanties binnen hetzelfde land kunnen elkaars gegevens niet uitwisselen zonder dat de burger zelf als data-hub fungeert.

Deel D — Het patroon: procedureel afwijzen

Wat het UWV consequent doet, is niet weigeren. Het is **procedureel afwijzen**. Dat is een fundamenteel verschil.

Bij een inhoudelijke weigering zou het UWV moeten stellen: *de medische situatie is niet erg genoeg*. Dat zou betekenen dat een arts het lichaam heeft gezien, de amputaties heeft vastgesteld, de visus heeft getest, en op basis daarvan tot de conclusie is gekomen dat er geen recht bestaat.

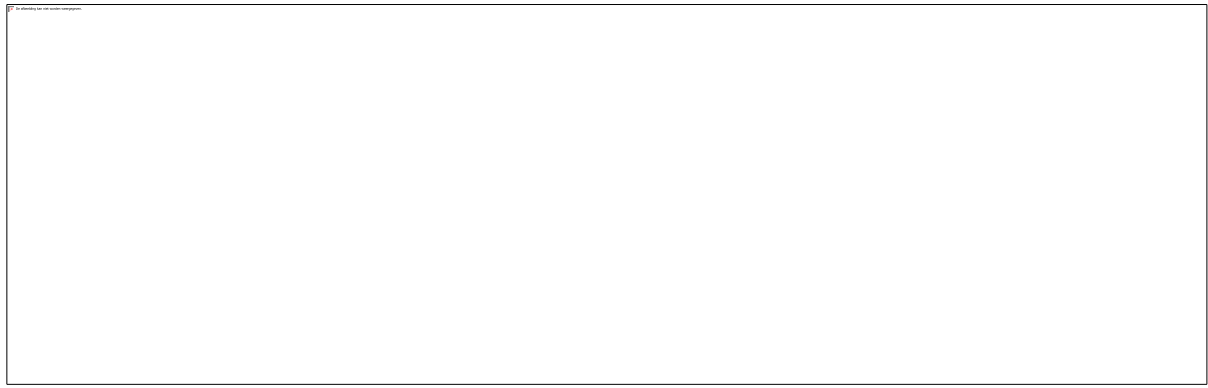
Bij een procedurele afwijzing stelt het UWV: *de aanvraag voldoet niet aan de vormvoorwaarde*. Geen vinkje. Geen juiste peildatum. Geen verzekeringsgrond. Geen Belgische beslissing. Geen C4-formulier.

De procedurele afwijzing heeft drie voordelen voor de instantie:

- **Geen medische beoordeling nodig.** De beoordeling wordt overgeslagen of uitgesteld.
- **Geen betwistbare beslissing.** Formele argumenten zijn moeilijk aan te vechten via de rechter.
- **Automatische doorschuiving naar de burger.** De burger moet eerst een andere beslissing forceren voordat de instantie iets doet.

Het UWV en de RVA hanteren hier hetzelfde patroon, maar in tegenovergestelde richting. Het UWV weigert de Belgische beslissing te lezen. De RVA weigert de Nederlandse beslissing te lezen. Beide instanties wachten op de andere, en geen van beide neemt de verantwoordelijkheid.

Deel E — De afwijzingsredenen op een rij



Figuur IX.4 — Zes afwijzingen, zes redenen. Alle redenen zijn procedureel. Geen enkele reden is medisch. De medische situatie wordt in de hele keten niet inhoudelijk getoetst.

Deel F — De twee bezwaren in detail

Bezwaar 1 — De Caren-aanvulling

04-06-2026

Op 1 juni 2026 dient de patiënt drie aanvullende bewijsstukken in voor het eerste bezwaar: de Caren-rapportage van de Nederlandse thuiszorg (126 klinische entrees die de hospitalisatieperiode 11 april tot 9 mei 2025 bevestigen), een oogheeskundig verslag van het academisch ziekenhuis, en een endocrinologisch verslag.

Drie dagen later verklaart het UWV het bezwaar ongegrond. Zes weken vóór de door het UWV zelf aangekondigde deadline van 15 juli 2026. De Caren-rapportage — het Nederlandse bewijs dat de peildatum bevestigt — wordt niet inhoudelijk behandeld.

Bezwaar 2 — De Vester-weigering

08-07-2026

Het tweede bezwaar betreft de WIA-afwijzing van 14 april 2026. De patiënt voert het Vester-arrest aan: bij opeenvolgende verzekeringen in twee lidstaten mag een lidstaat de wachttijd niet zo toepassen dat er een inkomenshiaat ontstaat. Het UWV wijst dit expliciet af met de stelling dat het inkomenshiaat niet kan worden vastgesteld zonder een formele beslissing uit België.

Omdat België eveneens weigert, sluit het UWV het dossier met de boodschap dat de burger eerst de Belgische beslissing moet forceren. De verantwoordelijkheid voor het doorbreken van de patstelling wordt teruggeschoven naar de burger.

Deel G — Wat dit hoofdstuk vaststelt

Het UWV en de RVA hanteren hetzelfde patroon in tegenovergestelde richting. Beide instanties wijzen procedureel af. Beide instanties weigeren de gegevens van de andere kant te lezen. Beide instanties schuiven de verantwoordelijkheid terug naar de burger.

De burger zit vast tussen twee instanties die elk een eigen voorwaarde stellen die door de andere instantie onvervulbaar is gemaakt. En in de hele keten wordt de medische situatie niet één keer inhoudelijk getoetst.

Voor wie in dezelfde situatie zit: bij een afwijzing door het UWV of de RVA is het belangrijk te controleren of de afwijzing inhoudelijk is of procedureel. Een procedurele afwijzing kan vaak worden aangevochten door de vormvoorwaarde te vervullen — maar als die voorwaarde in de praktijk onvervulbaar is (zoals een C4-formulier dat niet bestaat), kan een *herzieningsverzoek* op grond van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (NL) of een formeel bezwaarschrift (BE) de juiste weg zijn.

Voor loopbaandocumentatie: vraag bij het AGODI een officiële Berekening Geldelijke Anciënniteit aan als alternatief bewijs voor de RVA. Voor Nederlandse gegevens: injecteer de PD U1 handmatig via het MyCareer-portaal van de FOD Sociale Zekerheid.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool (♂, ♀). De feiten zijn gebaseerd op Document B. Dit hoofdstuk is geen juridisch advies.

CZ — de twee gezichten van de poortwachter

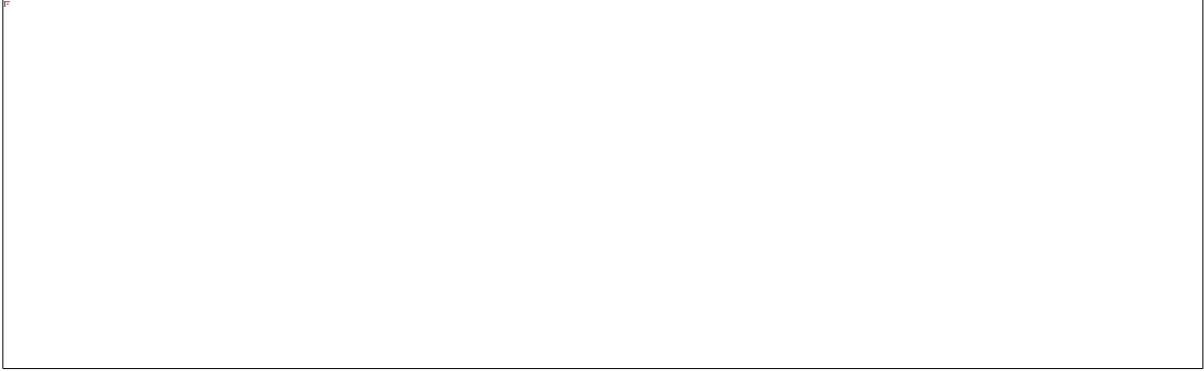
CZ voert voor een inwoner van Nederland met een baan in België de verdragspolis uit. CZ vergoedt de zorg, maar weigert de registratie die tot zorgtoeslag leidt. CZ weigert ook het ziekenvervoer, met een eis die in het behandelende land niet bestaat. In beide gevallen: het protocol van de instantie gaat boven de medische realiteit. En in beide gevallen: de instanties die de keten zouden moeten sluiten, sluiten hem niet.

Verhaal 1 — De verdragspolis en de zorgtoeslag

Wat de verdragspolis is

Een verdragspolis is een Europees instrument. De werknemer woont in Nederland, werkt in België. Volgens de Europese coördinatieregels is het werkland bevoegd voor de sociale zekerheid. De werknemer betaalt zijn sociale premies in België, aan het Belgische ziekenfonds.

Maar hij heeft ook recht op zorg in zijn woonland. Daarvoor dient de verdragspolis: CZ treedt op als Nederlandse uitvoerder van de polis, vergoedt de Nederlandse zorgkosten, en verrekent die met België.



The diagram area is currently blank, intended for a visual representation of the process described in the text below.

De premie gaat naar het werkland (België, via CM). CZ vergoedt de Nederlandse zorgkosten maar ontvangt geen premie. De registratie in het RIV-register kost CZ moeite zonder dat er inkomsten tegenover staan.

De redenering van CZ

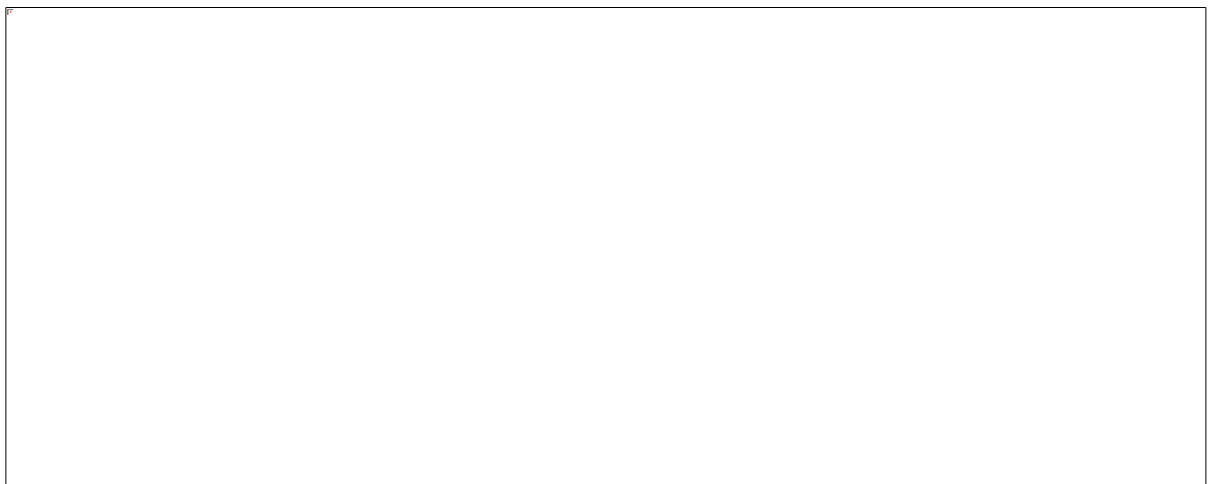
1. De verdragspolis is geen Nederlandse zorgverzekering in de zin van de Wet op de zorgtoeslag.
2. De premie voor de verdragspolis wordt betaald in het werkland (België), niet in Nederland.

3. Wie in België verzekerd is voor geneeskundige verzorging, is geen verzekerde in de zin van de Nederlandse Wet op de zorgtoeslag.
4. Er bestaat daarom geen recht op zorgtoeslag.

Het gevolg: de houder van een verdragspolis is in Nederland verzekerd voor zorg, maar niet verzekerd voor de toeslag. De Dienst Toeslagen leest uitsluitend het RIV-register. Wat daar niet in staat, bestaat niet.

Verhaal 1bis — De keten van de blokkade: CZ, CAK, ZIN

De weigering van CZ om de verdragspolis te registreren is niet de enige schakel. Het RIV-register — het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet — wordt beheerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). En het Zorginstituut Nederland (ZIN) houdt toezicht op de uitvoering. In dit dossier weigeren alle drie de betrokken instanties het probleem op te lossen.



Figuur X.2 — De gesloten driehoek. CZ weigert de registratie. Het CAK beheert het register maar weigert de synchronisatie. Het ZIN houdt toezicht maar weigert inzage in individuele dossiers. Elke instantie wijst naar de andere. De burger zit vast in een cirkel die door niemand wordt doorbroken.

De redenering van het CAK

Het CAK beheert het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RIV) en voert de verdragsregelingen uit. Wanneer de patiënt in april 2026 formeel eist dat de actieve en betaalde verdragspolis in het register wordt bijgeschreven, legt het CAK een fundamentele architectuurfout in de eigen systemen bloot.

De instantie weigert de polis te registreren met een procedureel argument. Het CAK stelt dat zij uitsluitend de "gewone" grensarbeider registreren: de persoon die in Nederland werkt en in het buitenland woont. Voor de omgekeerde situatie — wonen in Nederland, werken in het buitenland — is er simpelweg geen categorie in het systeem geprogrammeerd.

Het systeem kent het formulierveld niet. En in plaats van het veld toe te voegen, sluit het CAK het dossier.

De redenering van ZIN

Het Zorginstituut Nederland beheert en superviseert het RIV-register. Wanneer de patiënt het instituut in april 2026 verzoekt de uitsluiting in het register te onderzoeken en te corrigeren, verklaart het instituut geen inzage te hebben in individuele persoonsgegevens. Het weigert het register te controleren en verwijst terug naar CZ en het CAK.

De instantie die het register beheert, kan niet in het register kijken. Dat is de kern van de gesloten driehoek: elke instantie heeft een stukje bevoegdheid, en geen enkele instantie heeft het geheel.

Verhaal 2 — Het ziekenvervoer

De patiënt kan door amputaties en visusverlies niet meer zelfstandig autorijden. Zijn behandelaars zijn in België. Hij woont in Nederland. Voor die verplaatsingen heeft hij aangepast vervoer nodig — zittend ziekenvervoer. Dat is in Nederland een vergoeding die via de zorgverzekeraar loopt. Bij een verdragspolis is dat CZ.

Wat CZ eist

Op 18 maart 2026 dient de patiënt een aanvraag in voor machtiging zittend ziekenvervoer naar het Belgische ziekenhuis. CZ stuurt op 25 maart een informatieverzoek: er is een **perimetrie** nodig — een gezichtsveldonderzoek.

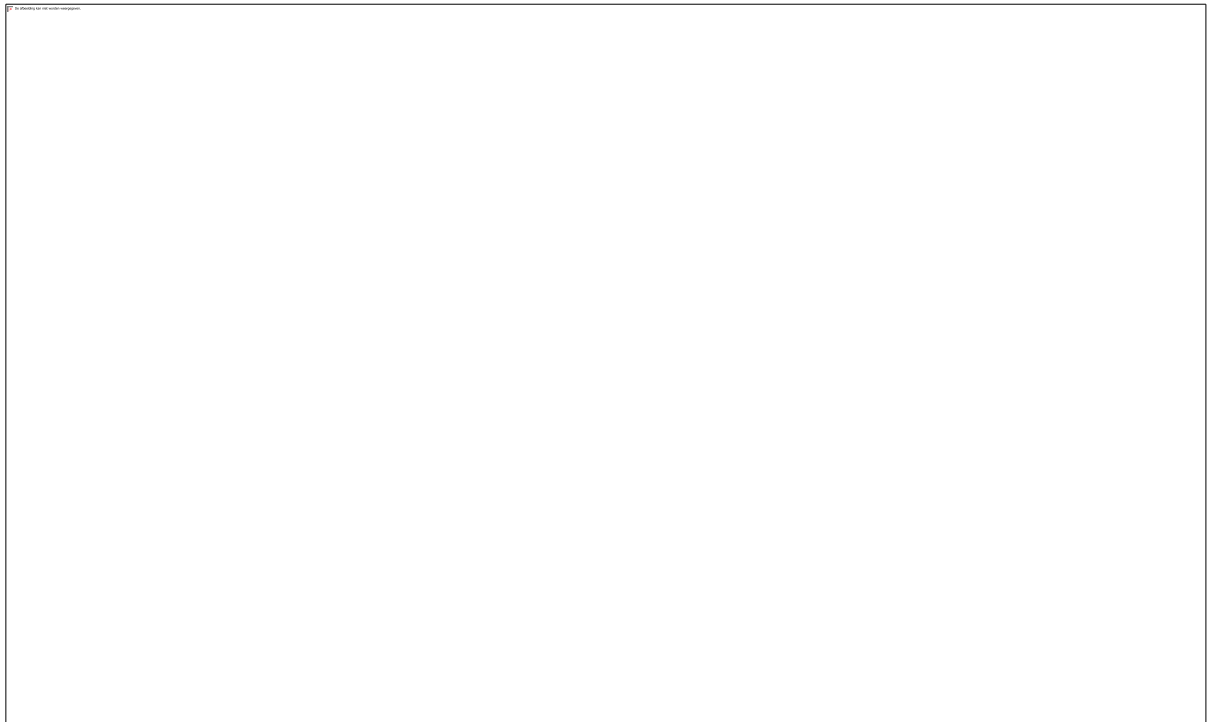
Wat is de perimetrie? Een oogheelkundig onderzoek waarbij de volledige omtrek van het gezichtsveld wordt gemeten. Het is een standaardonderzoek in de Nederlandse oogheelkunde. Het is géén standaardonderzoek in het Belgische protocol voor deze specifieke aandoening — diabetische retinopathie met maculair oedeem. Het Belgische ziekenhuis voert het niet uit bij deze patiënt, want het staat niet in het behandelprotocol.

Het gevolg: de patiënt kan het bewijs niet leveren, want het onderzoek bestaat niet in het land waar hij behandeld wordt.



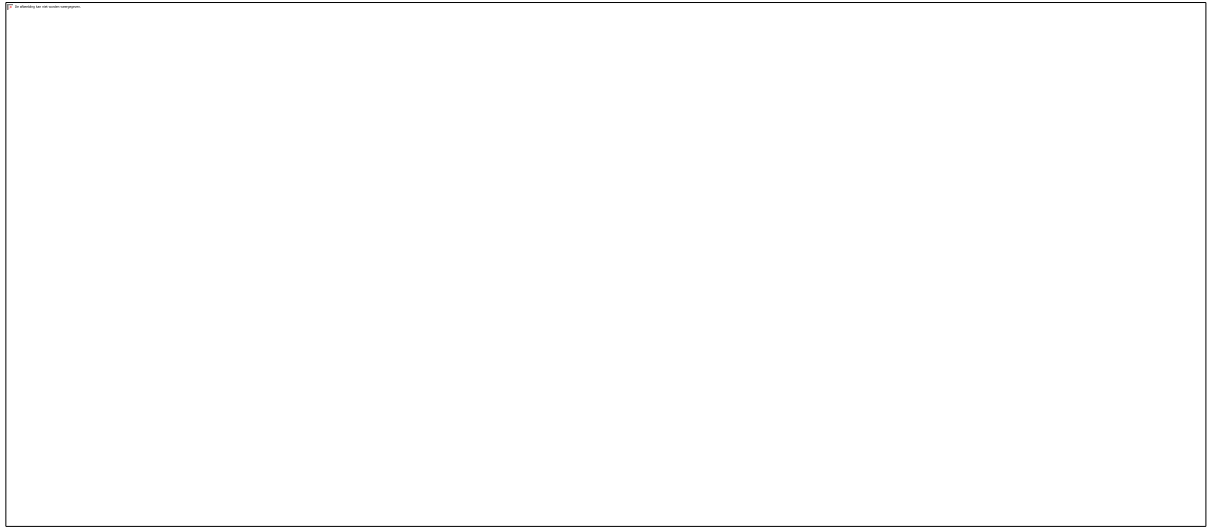
CZ eist een onderzoek dat in het behandelende land niet standaard wordt uitgevoerd. De patiënt kan het bewijs niet leveren, niet omdat hij niet wil, maar omdat het onderzoek niet bestaat in het protocol van zijn behandelaar.

De procedurele dans



Figuur X.4 — De dans. Vijf rondes, drie afwijzingen, één escalatie. Elke keer een nieuwe procedurele eis. Elke keer ingewilligd. En elke keer verschuift de drempel. De patiënt levert het bewijs, het protocol accepteert het niet.

Deel C — De parallel: CZ en CM



Figuur X.5 — De parallel. CM en CZ hanteren dezelfde logica: het medische bewijs wordt erkend waar het binnen het eigen protocol past, en geweigerd waar het protocol een vormvoorwaarde stelt die de patiënt niet kan vervullen. Het protocol is de waarheid, niet het lichaam.

Deel D — Wat dit oplevert

De patiënt heeft in beide verhalen het maximale bewijs geleverd dat hij kan leveren. In het eerste verhaal: een actieve verdragspolis, betaalde premie, uitvoerende instantie in België. In het tweede verhaal: een volledig medisch dossier met amputaties, visuswaarden, en een academisch rapport van een universitair ziekenhuis.

In beide gevallen wijst CZ af op een procedurele grond. De verdragspolis is geen Nederlandse verzekering. De perimetrie ontbreekt. De kilometerberekening klopt niet. De oude brief telt meer dan het nieuwe rapport.

De kern is niet dat CZ fouten maakt. De kern is dat het CZ-protocol boven de medische werkelijkheid staat. En omdat de wet CZ de ruimte geeft om het protocol te volgen, is er geen schending. Alleen een uitkomst die het gezin niet kan dragen. En de driehoek CZ-CAK-ZIN sluit zich rond het gezin zonder één opening.

Voor wie in dezelfde situatie zit: bij CZ-afwijzingen wegens protocolredenen zijn er vier routes:

1. Formeel bezwaar bij CZ zelf, met de nadruk op de onmogelijkheid om het gevraagde bewijs te leveren (protocolonverenigbaarheid). Voeg een verklaring van de behandelend arts toe dat het gevraagde onderzoek niet bestaat in het behandelprotocol.
2. Escalatie naar het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) bij de SVB. Het BBZ kan druk uitoefenen, maar heeft geen dwingende bevoegdheid.

3. Voor de zorgtoeslag: formeel bezwaar bij de Dienst Toeslagen op basis van de CZ-declaratieoverzichten waaruit blijkt dat u het Nederlandse eigen risico hebt betaald.
4. Inzageverzoek op grond van artikel 15 AVG bij CZ, CAK en ZIN, gericht op de EESSI-logbestanden en de RIV-registratiepogingen. Dit maakt de communicatie meetbaar en kan alsnog een handmatige correctie forceren.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool (σ). De feiten zijn gebaseerd op Document B. Dit hoofdstuk is geen juridisch advies.

De gemeente Hulst-trap

De gemeente is in Nederland de eerste hulplijn voor wie in financiële nood raakt. Voor een grensarbeider in Zeeuws-Vlaanderen zou de gemeente Hulst de logische plek zijn om bijstand, bijzondere bijstand of maatschappelijke ondersteuning te vragen. De praktijk is anders. De gemeente ontvangt de noodkreet, maar geeft geen geld. Ze biedt hardware en hulp. En ze gebruikt rekenmodellen die de werkelijke situatie niet lezen. Inmiddels is er wel een formeel bezwaarschrift in behandeling — maar de beslissing daarop is opnieuw verdaagd.

Deel A — De gemeente als eerste hulplijn die niet helpt

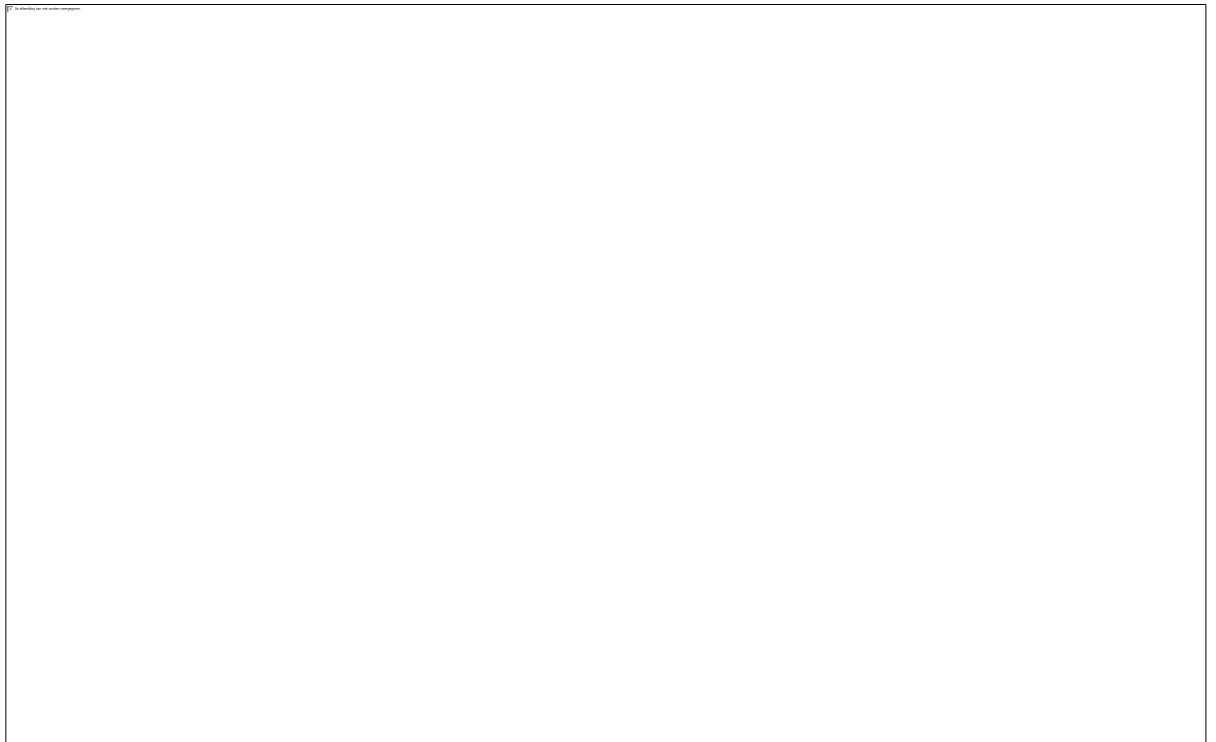
Wat de gemeente had kunnen doen

In het Nederlandse sociale stelsel heeft de gemeente drie instrumenten om inkomensnood op te vangen:

- **Bijstand** (Participatiewet) — een maandelijkse uitkering voor wie geen of weinig inkomen heeft.
- **Bijzondere bijstand** — een eenmalige tegemoetkoming voor onvoorziene noodzakelijke kosten.
- **Wmo-ondersteuning** — maatschappelijke ondersteuning, waaronder huishoudelijke hulp en vervoer.

Deze drie zijn bedoeld om in te grijpen wanneer het inkomen wegvalt of onvoldoende is. Voor een grensarbeider met een medische crisis en een volledig geblokkeerde inkomensstroom is dat exact de situatie waarvoor ze bestaan.

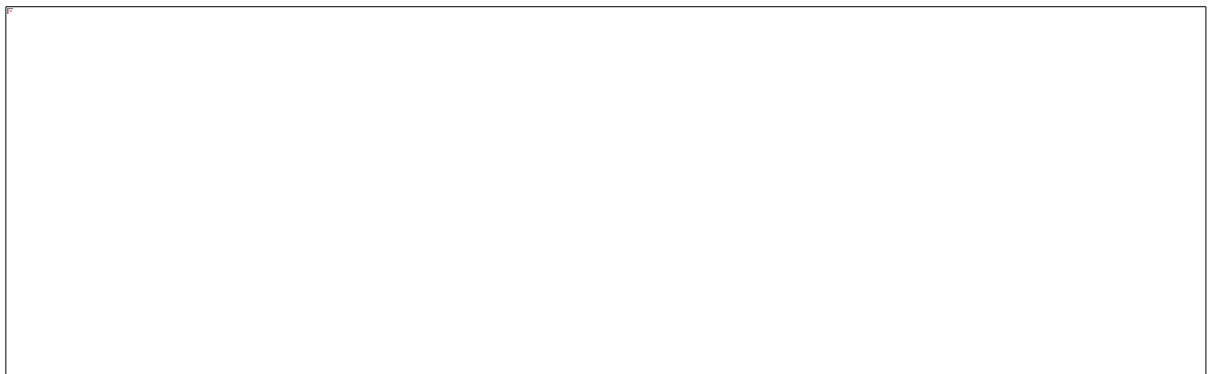
Wat de gemeente deed



Figuur XI.1 — De eerste hulplijn die niet helpt. De gemeente ontvangt zes keer een formele melding, verspreid over elf maanden. Elke keer volgt een procedurele reactie of helemaal geen reactie. Bijstand en bijzondere bijstand worden niet beoordeeld. Het enige formele spoor dat nu loopt is het bezwaarschrift van 22 juli 2026 — en de beslissing daarop is verdaagd.

Deel B — Het lopende bezwaarschrift

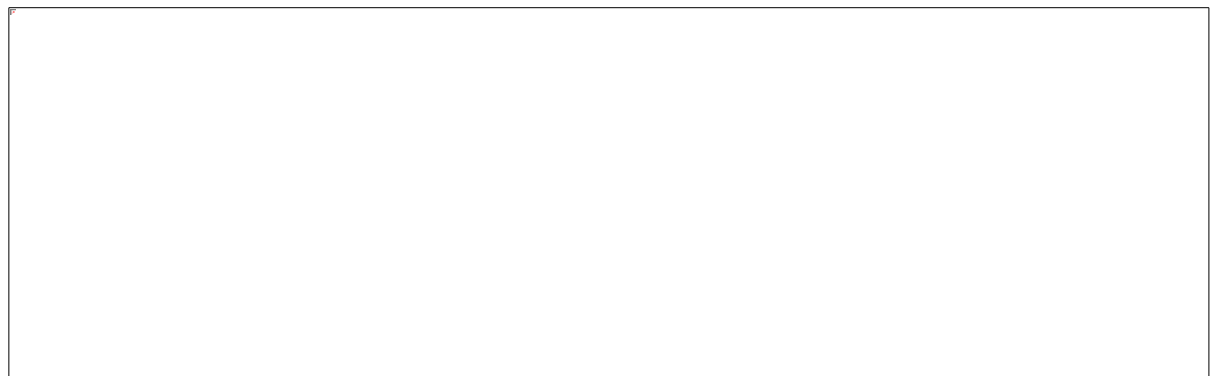
Wat overblijft als formeel spoor is het bezwaarschrift dat op 22 juli 2026 is ingediend tegen de beschikking van 22 juni 2026 inzake de bijzondere bijstand. Het is het eerste moment waarop de gemeente de aanvraag formeel moet beoordelen. De gemeente heeft daarop gereageerd met een verdaging van de beslistermijn.



Figuur XI.2 — Het lopende bezwaarschrift. Het bezwaarschrift tegen de beschikking inzake bijzondere bijstand is ingediend op 22 juli 2026. De gemeente heeft de ontvangst bevestigd op 21 september 2026 en de beslistermijn met zes weken verdaagd. De aanvrager heeft geen mondelinge toelichting gevraagd, omdat de gronden al voldoende zijn uiteengezet.

Deel C — De rekenmodellen die de werkelijkheid niet lezen

Waarom de gemeente, net als Parentia, geen geld vrijmaakt, heeft te maken met het rekenmodel. Bijstand en bijzondere bijstand worden getoetst aan een inkomensgrens. Dat is in principe logisch. Maar het model leest de werkelijke situatie niet.



Het rekenmodel werkt met fiscale gegevens uit het verleden. Het ziet niet dat het werkelijke inkomen tot nul is gedaald, dat de medische kosten zijn opgelopen, en dat het huishouden onder de armoedegrens leeft. Precies hetzelfde patroon als bij Parentia.

Deel D — De mobiliteitsfratsen

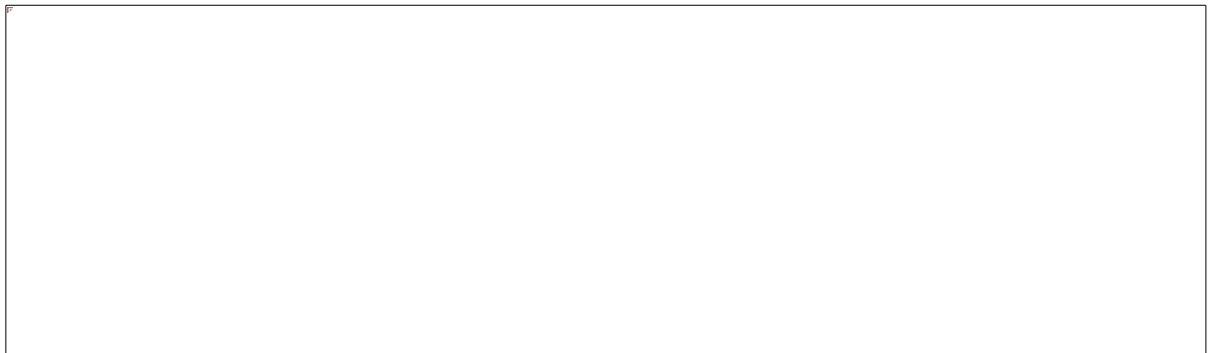
De gemeente biedt wel iets aan: mobiliteit. Twee regelingen: de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en de Wmo-pas voor aangepast vervoer. Beide werken — deels. En beide komen met hun eigen bijdrage.

De gehandicaptenparkeerkaart



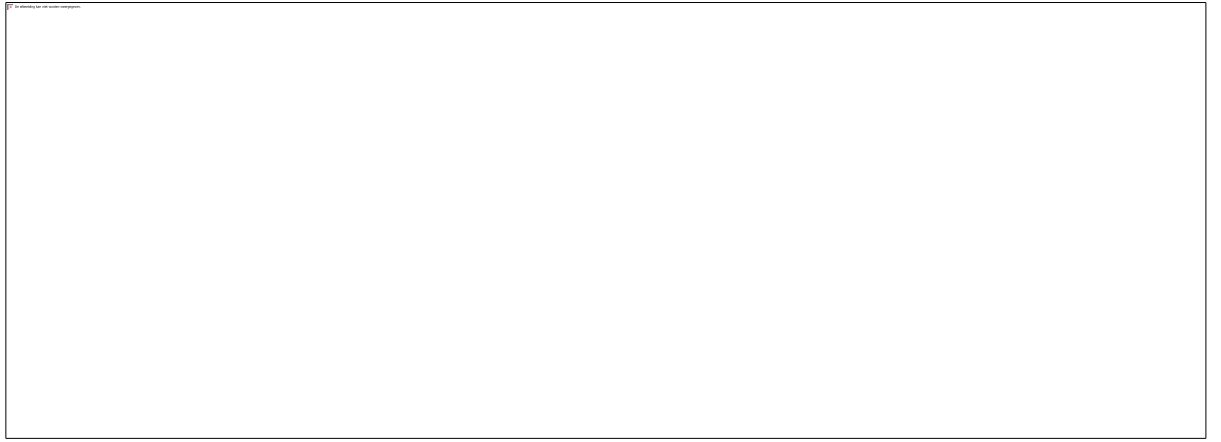
De patiënt heeft een Europese parkeerkaart van de Belgische federale overheid. De gemeente Hulst weigert die over te nemen en eist een nieuwe lokale keuring, met bijhorende legeskosten. Wat opvalt: de patiënt moest op 17-09-2026 nogmaals het medische dossier indienen, terwijl het al op 07-03-2026 en 20-08-2026 was aangeleverd.

De Wmo-pas en de eigen bijdrage



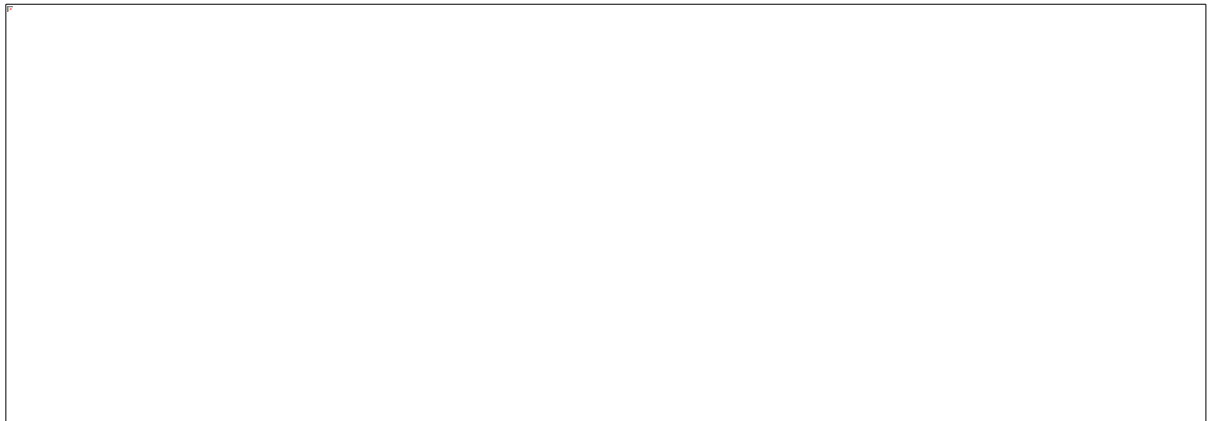
De Wmo-pas maakt de patiënt mobiel. Maar de eigen bijdrage valt in een periode zonder inkomen. En wie niet op tijd betaalt, verliest de pas.

Deel E — De grenslimieten van het Wmo-vervoer



Het systeem laat ritten toe naar academische ziekenhuizen over de grens, maar weigert ritten naar Belgische overheidsinstanties op exact dezelfde afstand. Ook een begeleidingsvraag bij visusverlies wordt niet geregistreerd.

Deel F — Het patroon herhaalt zich



Figuur XI.5 — Drie instanties, één patroon. Parentia, gemeente Hulst en CZ passen alle drie hetzelfde mechanisme toe: de medische werkelijkheid wordt erkend waar die binnen het protocol past, en geweigerd waar het protocol een vormvoorwaarde stelt die de burger niet kan vervullen.

Wat de gemeente had moeten zijn

De gemeente is in theorie de eerste lijn. De gemeente kent de inwoners, ziet de lokale situatie, heeft de instrumenten om snel in te grijpen. In dit dossier deed de gemeente dat niet. Ze ontving de noodkreet zes keer en produceerde zes procedurele reacties. Geen enkele keer werd de financiële situatie inhoudelijk beoordeeld.

En de kern is dit: **de flow zou in theorie genoeg moeten zijn.** De Belgische ziekte-uitkering, de Nederlandse WIA, de toeslagen, de gezinsbijslag — samen zouden ze het huishouden boven water moeten houden. Het probleem is niet

dat het geld er niet is. Het probleem is dat niemand het gat dicht dat tussen de potjes is ontstaan. De medische kosten zijn de trigger, maar de administratieve stilstand is de oorzaak van de verarming.

Het enige formele spoor dat nu loopt, is het bezwaarschrift van 22 juli 2026. Daarop is de beslistermijn verdaagd met zes weken. De aanvrager heeft geen mondelinge toelichting gevraagd, omdat de gronden al voldoende zijn uiteengezet. De beslissing volgt later. En tot die tijd blijft de financiële situatie ongewijzigd.

Voor wie in dezelfde situatie zit: de gemeente is wettelijk verplicht om bijstand en bijzondere bijstand te beoordelen. Een afwijzing wegens vormvoorwaarde of wegens een inkomensmodel dat de werkelijke situatie niet leest, kan worden aangevochten. Vier stappen:

1. Dien een formeel verzoek in om bijzondere bijstand, onder vermelding van de concrete noodsituatie (medische kosten, schulden, geblokkeerde uitkeringen).
2. Als de gemeente niet reageert binnen de wettelijke termijn (8 weken), dien een bezwaarschrift in wegens niet-tijdige beslissing.
3. Vraag om een persoonlijk gesprek met een consulent schuldhelpverlening of een sociaal raadsman.
4. Als de gemeente blijft weigeren: formeel bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders en zo nodig beroep bij de bestuursrechter. Weet dat de gemeente de beslistermijn wettelijk mag verdagen met zes weken (art. 7:10 lid 3 Awb) — dat is wat hier is gebeurd.

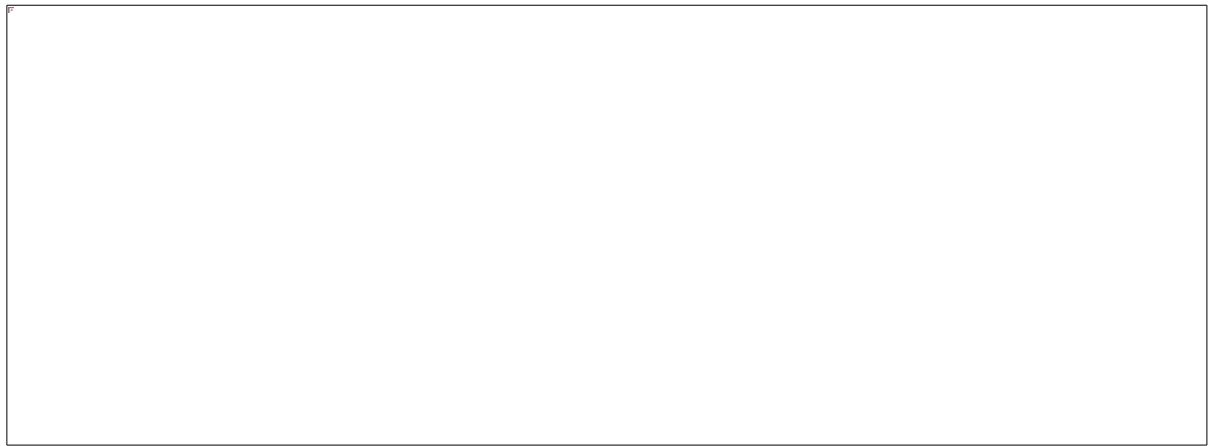
Voor de Wmo-pas en de GPK: een Europese parkeerkaart is een erkend EU-document. De gemeente mag de overname niet zomaar weigeren. Een formeel bezwaarschrift op grond van wederzijdse erkenning kan helpen.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool (σ). De feiten zijn gebaseerd op Document B. Dit hoofdstuk is geen juridisch advies.

Belastingdienst en toeslagen

De Dienst Toeslagen keert drie inkomensafhankelijke tegemoetkomingen uit: zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. Voor dit gezin loopt één volledig vast, één gedeeltelijk, en één werkt. En de belastingaangifte zelf confronteert de burger met een opdracht die hij niet kan uitvoeren: een wereldinkomen invoeren dat hij niet kent, met de verantwoordelijkheid voor de juistheid bij hemzelf.

Deel A — De drie toeslagen



Figuur XIII.1 — Drie toeslagen. De zorgtoeslag blijft op nul omdat CZ de verdragspolis niet als Nederlandse verzekering registreert. De huurtoeslag werkt gedeeltelijk, maar het toetsingsinkomen wijkt af door het buitenlandse inkomen. Het kindgebonden budget werkte pas na de SVB-koppeling — en werd met terugwerkende kracht uitbetaald.

Deel B — De mechaniek die erachter zit

Wat de toeslagen-uitkomsten niet laten zien, is wat de burger moet doen om tot die uitkomsten te komen. En wat er misgaat wanneer hij het niet doet of niet kán doen.

Het wereldinkomen dat de burger moet invoeren

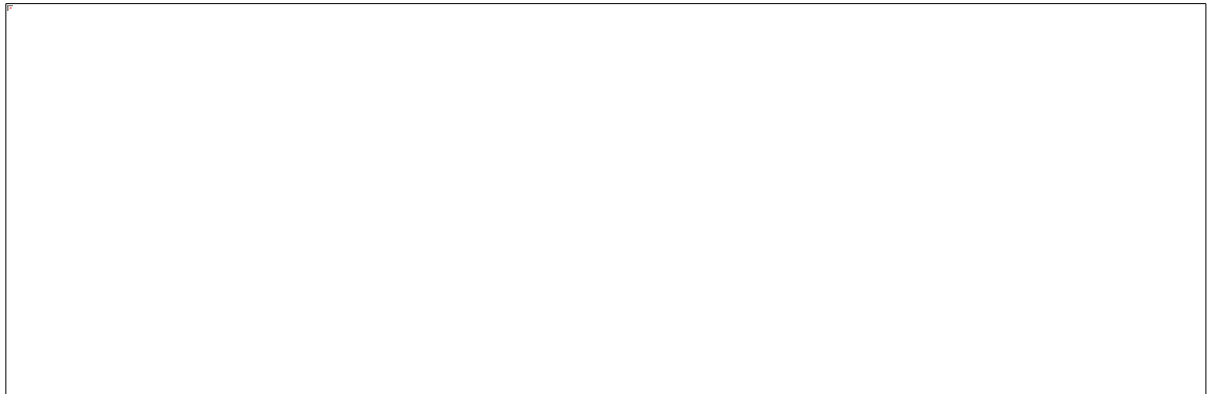
De Nederlandse Belastingdienst vraagt bij de aangifte inkomstenbelasting om het **wereldinkomen**: alle inkomen dat de burger waar ook ter wereld heeft verworven. Voor een grensarbeider betekent dat: het Belgische loon, de Belgische uitkeringen, de Belgische voordelen, alles.

Maar die gegevens krijgt de burger niet automatisch aangeleverd. De Belgische fiscus stuurt ze niet naar de Nederlandse fiscus. De DAC-infrastructuur (Directive on Administrative Cooperation) is bedoeld voor automatische uitwisseling van inkomensgegevens — maar de uitwisseling is niet realtime en niet altijd volledig. De burger moet de bedragen zelf invoeren op basis van zijn

eigen loonstroken, uitkeringsbeschikkingen en wat hij denkt dat zijn Belgische inkomen is.

De Belastingdienst legt de verantwoordelijkheid expliciet bij de burger. Wat de burger invoert, wordt als waar aangenomen. Klopt het niet, dan volgt later correctie. En bij een correctie kan een toeslag worden teruggevorderd.

Het gemeenschappelijk inkomen versus het wereldinkomen

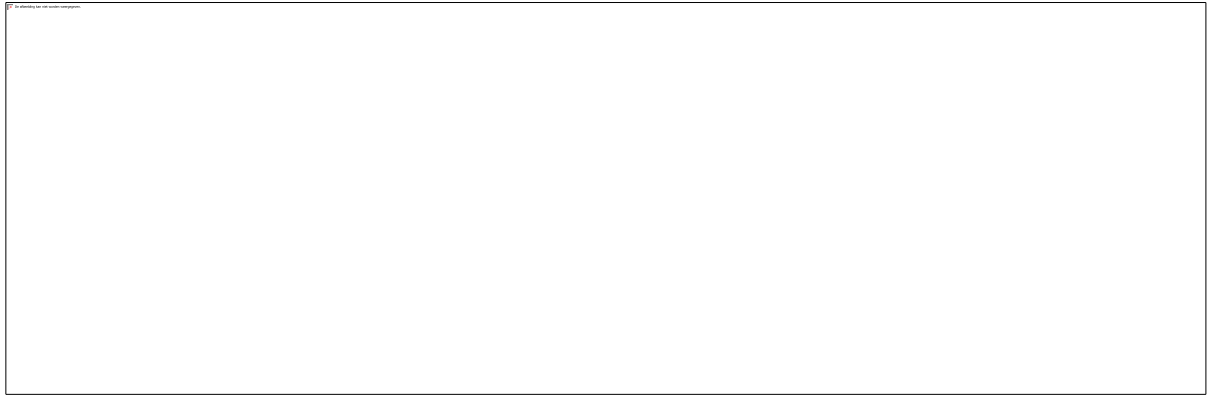


Figuur XIII.2 — Wereldinkomen versus gemeenschappelijk inkomen. Het Belgische inkomen wordt via het belastingverdrag in België belast en in Nederland vrijgesteld. Maar voor de toeslagen telt het volledig mee als wereldinkomen. Een euro in België is niet hetzelfde als een euro in Nederland — andere koopkracht, andere sociale zekerheid, andere kostenstructuur. In het toeslagenmodel wordt dat verschil niet gemaakt.

Deel C — De medische kosten die nul werden

Wat de patiënt vervolgens probeert, is de medische kosten in te voeren als **persoonsgebonden aftrek**. Medische kosten boven een drempel zijn in Nederland aftrekbaar van het inkomen. Dat verlaagt het toetsingsinkomen — en dat verlaagt de grondslag voor de toeslagen.

De strategie is logisch: door het aftrekken van de medische kosten wordt het toetsingsinkomen lager, en de toeslagen worden hoger. Het is een indirecte manier om het gezin te compenseren voor de kosten die het systeem niet vergoedt.



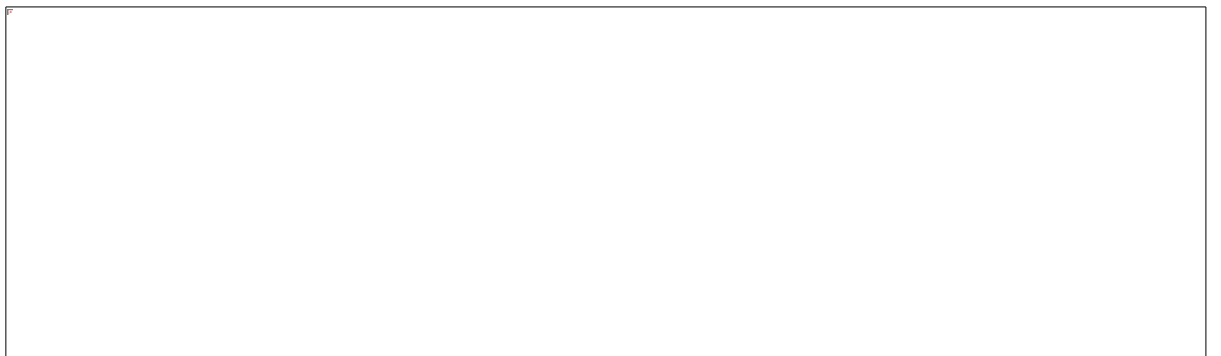
Figuur XIII.3 — De medische kosten. De patiënt voert de medische kosten in. Het rekenmodel past de aftrekdrempel toe. De uitkomst is nul. Het toetsingsinkomen daalt niet, de toeslagen blijven gelijk, en de werkelijke kosten blijven op het gezin drukken.

Deel D — De verantwoordelijkheid bij de burger

Wat de Belastingdienst consequent communiceert, is dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangifte bij de burger ligt. De burger moet:

- Het wereldinkomen invoeren, inclusief buitenlandse componenten die hij niet automatisch krijgt aangeleverd.
- De juistheid verantwoorden van bedragen die hij zelf heeft geschat.
- De gevolgen dragen van fouten, inclusief terugvorderingen van toeslagen.
- Zelf controleren of de automatische uitwisseling tussen België en Nederland heeft gewerkt.
- Zelf de DAC-logbestanden opvragen om te controleren wat er is uitgewisseld.

En als de automatische uitwisseling niet heeft gewerkt — als België de gegevens niet heeft gestuurd, of als Nederland ze niet heeft verwerkt — is dat geen reden om de aangifte uit te stellen. De burger moet het zelf oplossen.



De Belastingdienst legt de verantwoordelijkheid voor de juistheid bij de burger. De burger kan echter niet altijd de juiste gegevens achterhalen, want de automatische uitwisseling tussen België en Nederland is niet volledig. Het systeem schuift het risico van een administratieve fout af op wie er het minst aan kan doen.

Deel E — Wat dit oplevert

Drie toeslagen, drie uitkomsten. Eén volledig geblokkeerd, één gedeeltelijk, één werkend. En de belastingaangifte zelf vraagt de burger om een inkomen in te voeren dat hij niet kan berekenen, met de verantwoordelijkheid voor de juistheid bij hemzelf, en met de gevolgen van een herberekening die automatisch volgt zodra de Belastingdienst de werkelijke cijfers heeft.

Wat hier zichtbaar wordt, is een patroon dat terugkeert in het hele dossier. Het systeem heeft de instrumenten, de wetten en de intenties om de burger te ondersteunen. Maar het systeem leest de werkelijkheid niet zoals de burger die ervaart. De toeslagen worden berekend uit een toetsingsinkomen dat een euro uit België als een Nederlandse euro behandelt. De medische kosten worden ingevoerd maar leveren geen aftrek op. En de burger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van een inkomen dat hij niet kent.

Voor wie in dezelfde situatie zit: bij grensoverschrijdende inkomens en toeslagen zijn drie dingen van belang:

1. Vraag bij de Belgische fiscus een overzicht van het jaarinkomen en voer dat in bij de Nederlandse aangifte. Bewaar alles.
2. Vraag om uitstel als de gegevens nog niet compleet zijn — dat verlengt de termijn, maar niet de verantwoordelijkheid.
3. Als de toeslagen worden herberekend of teruggevorderd: dien een bezwaarschrift in op basis van de werkelijke cijfers, met bewijs. Formuleer het bezwaar op basis van het feit dat het toetsingsinkomen niet correct is vastgesteld.

Voor de zorgtoeslag specifiek: de blokkade zit bij CZ (RIV-registratie), niet bij de Dienst Toeslagen. Een handmatige correctie via de CZ-declaraties en het bewijs van betaald eigen risico is de route om de blokkade te doorbreken.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool (♂, ♀). De feiten zijn gebaseerd op Document B. Dit hoofdstuk is geen fiscaal of juridisch advies. Voor de exacte bedragen en voorwaarden: raadpleeg de Belastingdienst of een fiscaal adviseur.

IV. Heen en weer

Het manuele U1-probleem

Het PD U1 is het Europese bewijs van iemands arbeidsverleden. Een grensarbeider heeft het in twee richtingen nodig: om zijn Belgische jaren in Nederland te laten gelden, en om zijn Nederlandse jaren in België te laten gelden. In beide richtingen is de overdracht manueel. En de ESSPASS lost dat in 2030 niet op, want de burger blijft de schakel.

De twee richtingen



Figuur VIII.1 — Twee richtingen. Richting 1 werkt: RVA levert het PD U1 voor de Belgische loopbaan aan UWV. Richting 2 blokkeert: UWV levert het PD U1 voor de Nederlandse loopbaan, maar RVA weigert buitenlandse loopbaandata in zijn systeem te integreren. In beide richtingen draagt de burger zelf het document van de ene instantie naar de andere.

Richting 1 — België naar Nederland

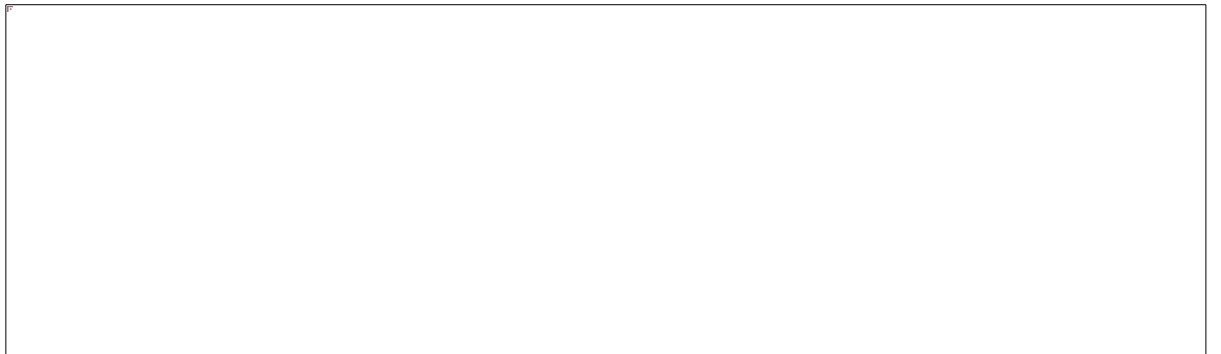
De burger heeft 21 jaar in België gewerkt. Om aanspraak te maken op Nederlandse uitkeringen moet die Belgische loopbaan aantoonbaar zijn in het Nederlandse systeem. De RVA levert daarvoor het PD U1 aan UWV.

A screenshot of a document, likely a form or a list, showing a table with columns for 'Periode' and 'Status'. The table contains several rows, some of which are highlighted in yellow. The text is too small to read, but the structure is clear.

RVA levert drie PD U1-formulieren. Bij vergelijking blijken vijf periodes te ontbreken — studentenarbeid uit 1999, gaten in 2001–2002, en transitieperiodes. De burger vraagt zelf de aanvullende attesten aan. Pas na manuele aanvulling is het dossier compleet. De administratie werkt, maar uitsluitend omdat de burger de gaten zelf detecteert en dicht.

Richting 2 — Nederland naar België

De burger heeft ook 8 maanden in Nederland gewerkt. Om aanspraak te maken op Belgische rechten moet die Nederlandse loopbaan aantoonbaar zijn in het Belgische systeem. UWV levert daarvoor het PD U1. Maar de RVA weigert om buitenlandse loopbaangegevens in zijn systeem te integreren.

A screenshot of a document, likely a form or a list, showing a table with columns for 'Periode' and 'Status'. The table contains several rows, some of which are highlighted in yellow. The text is too small to read, but the structure is clear.

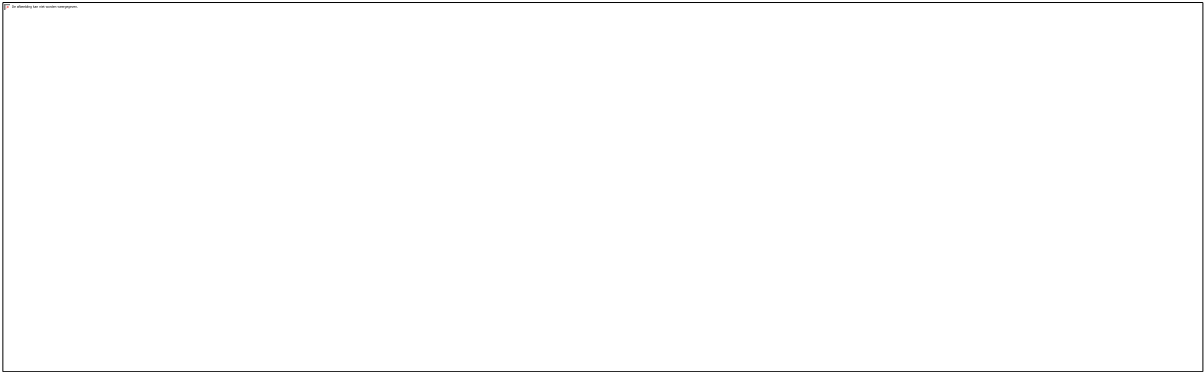
UWV levert een PD U1 voor de 8 Nederlandse maanden. RVA weigert deze data in zijn systeem te integreren: de instantie beschouwt zichzelf als zender, niet als ontvanger. De enige uitweg is dat de burger de Nederlandse loopbaandata handmatig injecteert in het portaal van een andere Belgische federale instantie (FOD Sociale Zekerheid), die de gegevens vervolgens in MyCareer plaatst.

Het patroon

Aspect	Richting 1 — BE → NL	Richting 2 — NL → BE
Uitgevende instantie	RVA (Antwerpen)	UWV
Ontvangende instantie	UWV	RVA
Duur loopbaan	21 jaar 2 maanden	8 maanden
Aanvraag	Handmatig, per e-mail of formulier	Handmatig, per formulier
Levering	Werkt, met ontbrekende periodes	Werkt, maar ontvanger weigert
Overdracht	Burger dient zelf in bij UWV	Burger injecteert zelf bij FOD SZ
Blokkade	5 periodes ontbreken, burger vult zelf aan	RVA weigert import van buitenlandse data
Bypass	Extra attesten opvragen bij werkgevers	Handmatige injectie via FOD SZ-portaal

In beide richtingen is de burger de enige actor die het document fysiek of digitaal overdraagt. De RVA en het UWV sturen wel, maar ontvangen elkaar niet. Er is geen automatische systeem-tot-systeem-koppeling. In richting 1 vult de burger de gaten zelf aan. In richting 2 omzeilt hij de weigerende RVA via een andere federale instantie.

ESSPASS in 2030 — wat verandert er niet



Figuur VIII.2 — ESSPASS in 2030. De wallet digitaliseert de drager. De verificatie wordt sneller. Maar de handeling van de burger blijft: hij vraagt het document aan en deelt het met de verifierende instantie. De lidstaten koppelen hun systemen niet automatisch aan elkaar. De RVA zal in 2030 nog steeds weigeren buitenlandse loopbaandata te integreren, en de burger zal nog steeds dezelfde bypass moeten gebruiken.

Wat de ESSPASS wel en niet oplost

Aspect	Nu (2026)	ESSPASS (2030)
Drager	Papier	EUDI Wallet
Aanvraag	Handmatig, 75% geen online aanvraag	Handmatig via wallet
Uitgifte	Handmatig, dagen tot weken	Automatisch uit de bron, seconden
Overdracht	Handmatig, post of e-mail	Handmatig via wallet
Verificatie	Handmatig door ambtenaar	Real-time QR-scan

Aspect	Nu (2026)	ESSPASS (2030)
Fraude-detectie	Beperkt	Cryptografisch sterk
Synchronisatie tussen lidstaten	Geen	Geen

De ESSPASS lost de *papieren vertraging* op. Het lost de *handmatige synchronisatie* niet op. De burger blijft de actor die het document aanvraagt en deelt. Wat in 2026 een fysieke handeling was, wordt in 2030 een digitale handeling. De rol van de burger verandert niet.

Waarom dit een brug is naar het Nederlandse deel

In België zijn de belangrijkste administratieve blokkades voor dit dossier inmiddels in kaart gebracht en deels doorbroken via de fiscale bypass. Wat rest in België zijn uitvoeringskwesties — de heropening, de tuchtklacht, het arbeidsauditoraat. Structureel nieuwe blokkades duiken niet meer op.

Dat is anders aan Nederlandse zijde. Daar wachten de WIA, de SVB, de Belastingdienst, de gemeente Hulst, het CAK, de RIV-registers en het hele Nederlandse uitvoeringsapparaat nog op een eigen analyse. En precies daar ligt een structureel verschil met België dat nog niet in beeld is gebracht.

Het manuele U1-probleem is de laatste Belgische blokkade in dit dossier. En tegelijk is het de opening naar het Nederlandse deel — want richting 2 (Nederland naar België) is de eerste stap die de Nederlandse instanties ook raakt. Wat in dit hoofdstuk nog in de marge van een loopbaanbewijs zit, wordt in de volgende hoofdstukken het hoofdpodium: WIA, SVB, toeslagen, zorgtoeslag, gemeentelijke uitvoering.

Voor wie in dezelfde situatie zit: het PD U1 is een recht, geen gunst. U kunt het in beide richtingen opvragen — bij de RVA voor Belgische loopbaanjaren, bij het UWV voor Nederlandse loopbaanjaren. Als een van beide instanties weigert om buitenlandse data te importeren, is de bypass via de FOD Sociale Zekerheid (MyCareer-portaal) de enige weg. Vraag bij uw vakbond of bij de sociale dienst naar de juiste procedure. De ESSPASS in 2030 zal de aanvraag eenvoudiger maken, maar niet de blokkade bij de ontvangende instantie opheffen.

De informatie over het PD U1 is gebaseerd op Document B en op de officiële procedures van de RVA en het UWV. De ESSPASS-informatie is gebaseerd op openbare bronnen van de

Europese Commissie en het Europees Parlement over de ESSPASS-verordening, de EUDI Wallet en de gefaseerde implementatie van het Labour Mobility Package. Dit hoofdstuk is geen juridisch advies.

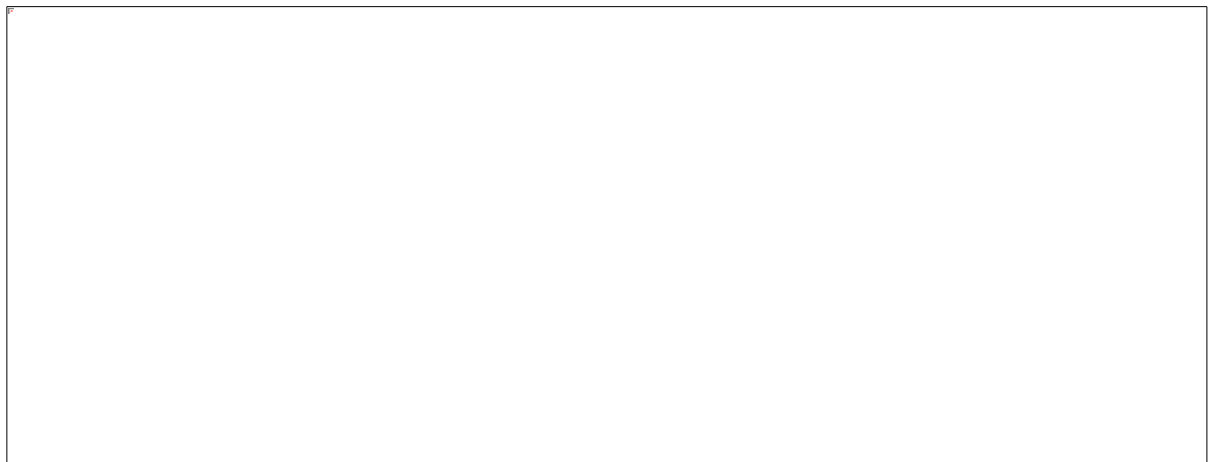
SVB en Parentia — het werkende voorbeeld

Niet alles wat tussen België en Nederland speelt, is een blokkade. Dit hoofdstuk toont één dossier waarin de Europese coördinatie daadwerkelijk werkt: de kinderbijslag voor een kind dat in Nederland woont en schoolgaat in Vlaanderen. Twee instanties, twee landen, één kind. Ze vinden elkaar. En dan komt er een herberekening.

Deel A — De splitsing

Voor een kind van ouders die in twee landen werken, verdeelt de Europese coördinatie de kinderbijslag. De regel is dat één land de hoofdbijdrage betaalt, en het andere land het verschil aanvult tot het niveau van het woonland. Voor dit gezin betekent dat:

- **België** is hoofdbetaler, want de moeder werkt in België. Parentia keert het Groeipakket uit.
- **Nederland** vult aan tot het Nederlandse niveau, want het kind woont in Nederland. De SVB keert het verschil uit.



Figuur XII.1 — De splitsing. Parentia betaalt de Belgische bijdrage op naam van de moeder (werklandbeginsel). De SVB vult aan tot het Nederlandse niveau op naam van de vader (woonlandbeginsel). Het kind ontvangt het volledige bedrag waarop een Nederlands kind recht heeft, verdeeld over twee landen.

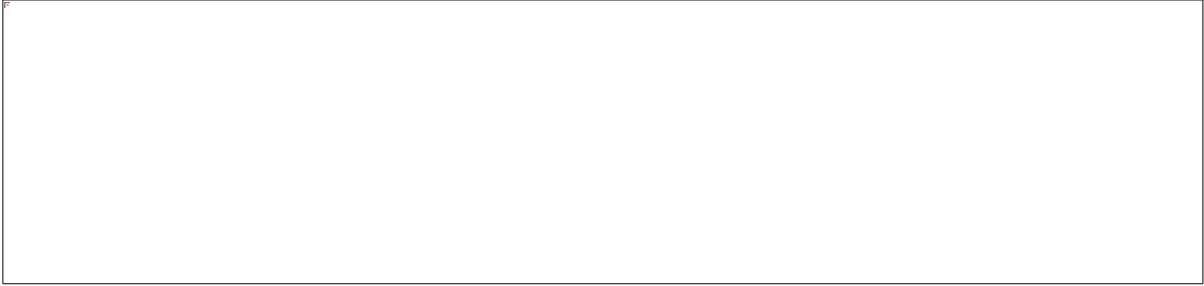
Deel B — Waarom dit werkt

Wat hier werkt, is precies wat elders in dit dossier misloopt. Twee nationale instanties, twee verschillende wetgevingen, twee talen, en één kind. Ze weten elkaar te vinden.

De Europese coördinatieverordening voorziet in een mechanisme dat *samenloop van gezinsbijslagen* wordt genoemd. Dat mechanisme bepaalt welk land de hoofdbijdrage betaalt en welk land aanvult. Parentia en de SVB passen

dit toe. Ze lezen elkaars statussen, erkennen elkaars beslissingen, en verrekenen de bedragen.

De sleutel: de aanvulling op naam van de vader. De moeder werkte in België, dus op haar naam kon de SVB geen aanvulling toekennen — België was daar al bevoegd. Maar de vader werkte niet buiten Nederland, en woonde in Nederland. Daarmee was hij de aangewezen persoon om het verschil te ontvangen. Een eenvoudige toepassing van de Europese regels.



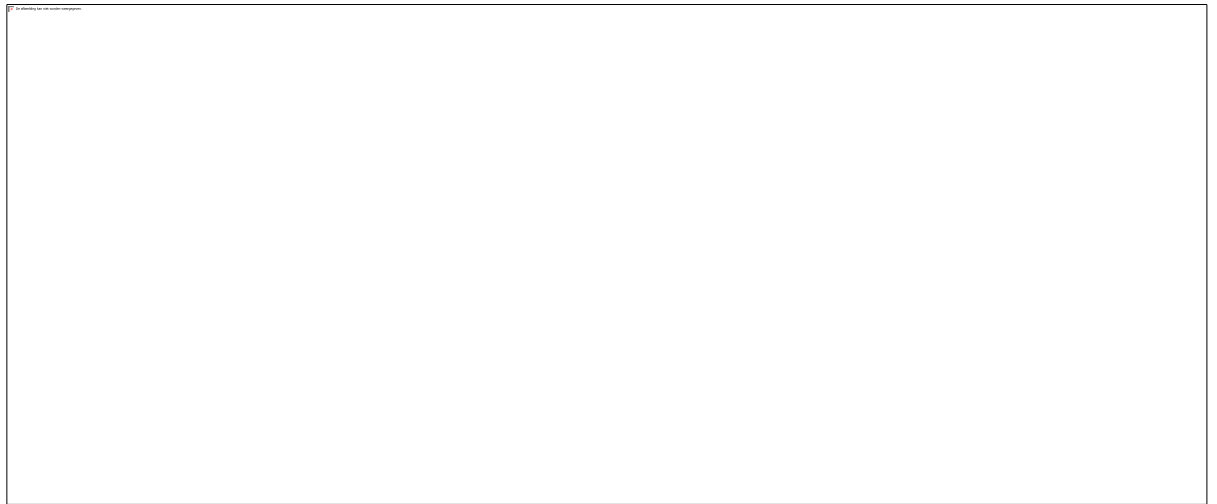
De Europese coördinatie van gezinsbijslagen werkt hier omdat beide landen elkaars systeem erkennen en de bedragen verrekenen. In de rest van dit dossier loopt het mis omdat er geen verrekening plaatsvindt — bij medische kosten, bij vervoer, bij toeslagen.

Deel C — De herberekening die het succes bedreigt

Nu komt het tweede deel van het verhaal. Zodra de retroactieve herclassificatie van de vader naar de status "ten laste invalide" wordt doorgevoerd, verandert de fiscale situatie van het gezin.

Wat er verandert: de moeder zal netto meer overhouden. Niet omdat ze meer bruto verdient, maar omdat het gezin recht krijgt op fiscale voordelen door de erkenning van de handicap van de vader.

En dan begint het cascade-effect.



Figuur XII.2 — De herberekening. De retroactieve statuswijziging naar "ten laste invalide" leidt tot fiscale voordelen voor het gezin. Het gezinsinkomen stijgt op papier. Parentia verlaagt de bijdrage. De SVB herberekent de aanvulling. Mogelijk met terugvordering. Wat vandaag werkt, kan morgen worden teruggedraaid door een automatische herberekening.

Deel D — Wat dit hoofdstuk toont

Dit is het enige hoofdstuk in Document C waarin een mechanisme volledig werkt. En dat maakt het juist interessant, om drie redenen:

Ten eerste. De Europese coördinatie werkt wel degelijk voor gezinsbijslagen, omdat de verordening een expliciet mechanisme voorschrijft (samenloop) en beide landen zich daaraan houden. Waar dat mechanisme ontbreekt — zoals bij medische statussen, bij zorgtoeslag, bij ziekenvervoer — werkt het niet.

Ten tweede. De aanvulling op naam van de vader laat zien dat dezelfde administratieve realiteit anders uitpakt afhankelijk van wie de aanvraag doet. Op naam van de moeder: geen aanvulling. Op naam van de vader: wel aanvulling. Eén gezin, twee uitkomsten, afhankelijk van de formele rol.

Ten derde. De retroactieve herclassificatie is een nieuw risico. Zodra de status van de vader verandert, worden de bedragen opnieuw berekend. Wat nu een werkend systeem is, kan volgend jaar een schuld produceren. Niet door een fout, maar door een herberekening.

Deze drie punten maken dit hoofdstuk de perfecte tegenhanger van de Parentia-trap (Blok II) en de Gemeente Hulst-trap (Blok III). Dezelfde instanties, andere uitkomst. Wat dit dossier laat zien, is dat het systeem soms werkt — maar nooit gegarandeerd. Succes is een uitzondering, geen regel.

Voor wie in dezelfde situatie zit: de SVB is bevoegd voor de aanvulling op de kinderbijslag wanneer u in Nederland woont en niet in het buitenland werkt. Werkende partner? Dan ontvangt u doorgaans geen aanvulling op uw eigen naam — vraag de SVB

naar de juiste toewijzing.

Let op bij retroactieve wijzigingen: zodra een van beide partners een andere fiscale status krijgt, herberekenen zowel Parentia als de SVB de bedragen. Dit kan leiden tot terugvorderingen. Bewaar alle beschikkingen en controleer jaarlijks de herberekeningen.

De feiten zijn gebaseerd op Document B. De retroactieve herberekening is een voorspelling op basis van het patroon van herberekeningen in het dossier; de definitieve bedragen en de uitkomst zijn nog niet vastgesteld. Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool (σ , φ).

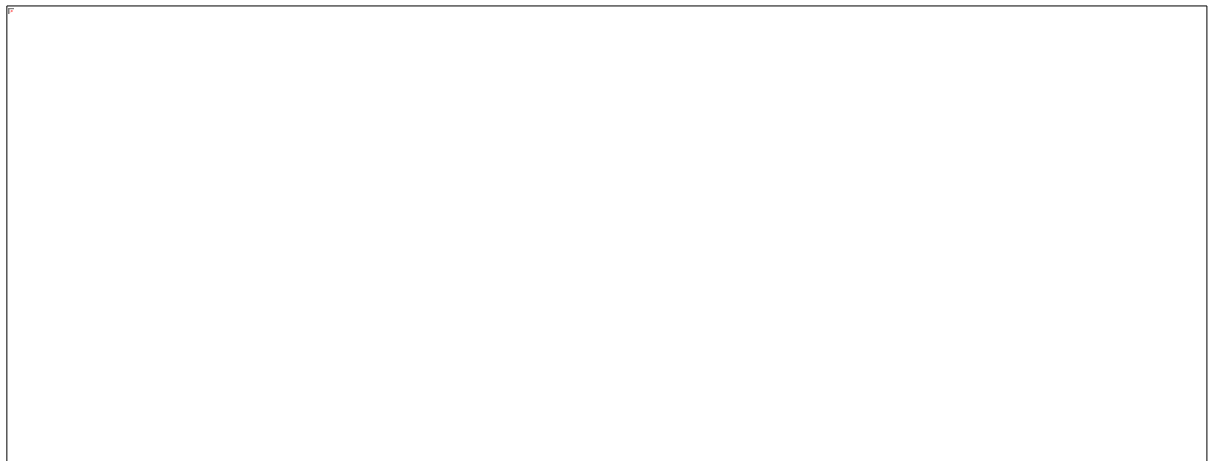
Het lichaam zonder achterwacht

Een grensarbeider woont in Nederland en wordt behandeld in België. Zijn volledige medische dossier zit in Belgische datasilo's. Wat gebeurt er als er in zijn eigen woonland iets misloopt? Een spoedgeval, een val, een acute complicatie? Wie is dan de dokter die hem kent? Het antwoord is: niemand. De wet verbiedt het.

Deel A — De wettelijke onmogelijkheid

In Nederland mag een patiënt maar bij één huisartsenpraktijk ingeschreven staan. Wie zich aanmeldt bij een nieuwe praktijk, wordt automatisch uitgeschreven bij de oude. Dat is een landelijk systeem dat dubbele inschrijvingen voorkomt. Voor een gewone Nederlander is dat logisch. Voor een grensarbeider die zijn hele medische leven in het buitenland heeft, is het een probleem.

De reden waarom dubbele inschrijving verboden is: de Nederlandse Zorgverzekeringswet en de administratieve reglementen van de huisartsenzorg verbieden een dubbele inschrijving over de landsgrenzen heen. Een huisarts mag een burger alleen inschrijven als hij ook daadwerkelijk de primaire en actieve medische verantwoordelijkheid draagt. Een inschrijving zonder actieve behandeling is juridisch niet mogelijk.



Figuur XIX.1 — De wettelijke onmogelijkheid. De patiënt heeft zijn volledige medische dossier in België. In Nederland kan hij zich niet medisch laten inschrijven, want de wet verbiedt dubbele inschrijvingen. Hij woont in een land waar geen enkele dokter zijn dossier kent.

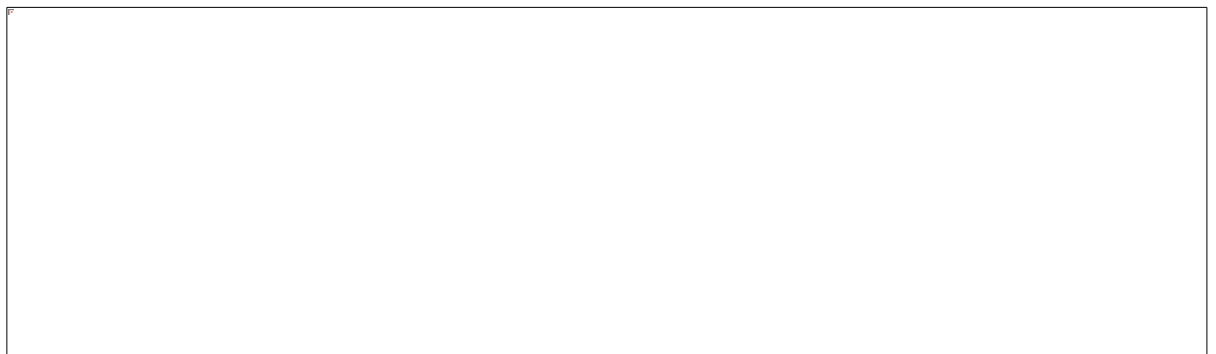
Deel B — De gevolgen in de praktijk

Wat gebeurt er als er in het woonland een medisch probleem optreedt?

- Een val thuis, een acute complicatie van de diabetes, een infectie aan de amputatiewonde — de huisarts van de wachtdienst kent het dossier niet.
- De behandelaar moet op basis van beperkte informatie beslissen, zonder de amputatiegeschiedenis, zonder de medicatielijst, zonder de specifieke wondzorgbehoeften.
- De patiënt moet zelf de context uitleggen — in een noodsituatie, mogelijk niet in staat om dat te doen.
- Bij een spoedopname in een Nederlandse kliniek: geen dossier, geen medicatiehistoriek, geen wondzorgprotocol.

In het dossier is dit expliciet geprobeerd op te lossen via een zuiver informatieve inschrijving bij een Nederlandse huisartsenpraktijk. Geen actieve behandeling, alleen de dossierkennis op Nederlands grondgebied, zodat een wachtdienst of een spoedarts zou kunnen zien wat er speelt.

Die aanvraag is afgewezen. De praktijk erkende telefonisch dat dit in een ideale wereld de juiste oplossing zou zijn, maar dat de wet het niet toestaat. Een inschrijving zonder actieve behandelrelatie is juridisch niet mogelijk. De brief bevestigde de systeemblokkade zonder ruimte voor heroverweging.



Figuur XIX.2 — Wat de praktijk antwoordde. De huisartsenpraktijk erkende dat een informatieve inschrijving in theorie de ideale oplossing zou zijn, maar dat de wet een dubbele inschrijving over de grens verbiedt. De praktijk kan geen patiënt inschrijven zonder actieve behandelrelatie.

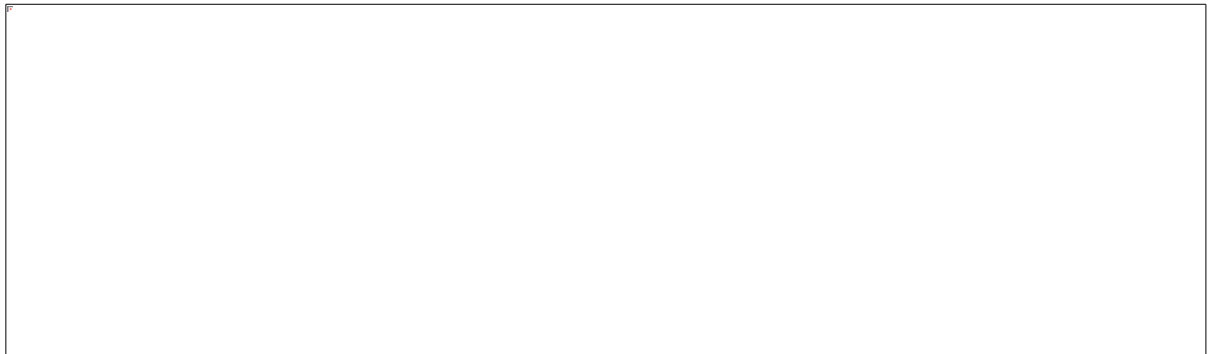
Deel C — De wet die het gezin beschermt en verlamt

De regel dat een patiënt maar bij één huisartsenpraktijk mag staan, is bedoeld om kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen. Voor gewone burgers werkt die regel. Voor grensarbeiders die hun volledige medische leven in een ander land hebben, creëert diezelfde regel een gat in de veiligheid.

De Europese Unie erkent het recht op vrij verkeer. Ze erkent ook het recht op medische zorg in het buitenland. Maar ze voorziet niet in een oplossing voor de patiënt die zijn medische dossier in één lidstaat heeft en zijn lichaam in een andere lidstaat heeft. De wet beschermt de continuïteit binnen één land. Ze voorziet niet in continuïteit over de grens.

Wat het gezin overhoudt, is een pragmatische oplossing: de patiënt draagt zijn eigen medische geschiedenis fysiek of digitaal mee. Bij een bezoek aan een Nederlandse dokter in noodgeval moet hij zelf kunnen uitleggen wat er speelt. Bij een ziekenhuisopname in Nederland moet hij zelf de Belgische dossiers aanleveren. Hij is niet alleen de data-hub voor de administratie, maar ook voor zijn eigen acute medische veiligheid.

Deel D — De paradox



Figuur XIX.3 — De paradox. De wet beschermt de continuïteit van zorg binnen één land. Ze voorziet niet in continuïteit over de grens. Voor een gewone burger werkt de regel. Voor een grensarbeider creëert diezelfde regel een veiligheidsgat.

Wat dit hoofdstuk vaststelt

De patiënt woont in Nederland, maar zijn volledige medische geschiedenis zit in België. De Nederlandse wet verbiedt een dubbele inschrijving bij huisartsen. De patiënt kan zich dus niet medisch verankeren in het land waar hij woont. En in een noodsituatie is er geen dokter die zijn dossier kent.

De huisartsenpraktijk die hiervoor is benaderd, erkende dat dit in een ideale wereld de juiste oplossing zou zijn. De wet verbiedt het. De Europese Unie erkent vrij verkeer en erkent medische zorg over de grens, maar voorziet niet in medische continuïteit over de grens. Het gezin lost het op door de patiënt zelf zijn eigen dossier te laten dragen. Opnieuw: niet omdat het systeem het wil, maar omdat er geen alternatief is.

Voor wie in dezelfde situatie zit: drie dingen om te weten:

1. Een informatieve inschrijving bij een Nederlandse huisartsenpraktijk is wettelijk niet mogelijk. Vraag bij de Belgische huisarts een actueel medisch paspoort op papier (medicatielijst, diagnoses, behandelaars).

2. Draag dit paspoort fysiek bij u, ook in noodgevallen. Gebruik eventueel een noodkaart in uw portemonnee met de belangrijkste medische gegevens.
3. Bewaar een digitale versie van de belangrijkste rapporten op een USB-stick of in een beveiligde cloud, zodat u bij een ziekenhuisopname in Nederland direct kunt aanleveren.

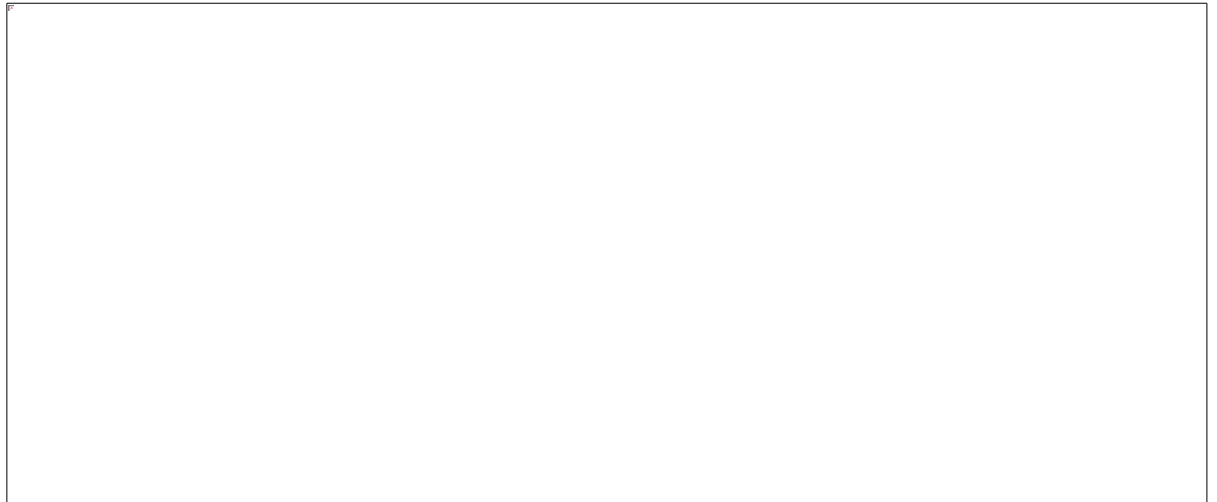
Voor structurele oplossingen op langere termijn: dit is een van de punten waar de Europese Unie nog geen oplossing voor heeft. Uw signaal draagt bij aan de druk om dit te veranderen.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool (σ). De feiten zijn gebaseerd op Document B. Dit hoofdstuk is geen juridisch of medisch advies.

De centrale pot

Alle vorige hoofdstukken beschreven instanties die weigeren, procedures die vastlopen en systemen die de werkelijke situatie niet lezen. Dit hoofdstuk toont het resultaat. Wanneer de uitkeringen niet komen, de toeslagen op nul blijven, de medische kosten blijven oplopen en niemand het gat dicht, dan blijft er nog één speler over: de private markt. De bank. De energieleverancier. De netbeheerder. En die werken niet met protocollen, maar met incassotermijnen.

Deel A — De rekening als reservoir



Figuur XX.1 — De rekening als reservoir. Wat niet binnenkomt aan uitkeringen en toeslagen, en wat wel weglekt aan medische kosten, creëert een tekort op de bankrekening. Dat tekort wordt opgevangen door commerciële partijen: de bank, de energieleverancier, het incassobureau. Tegen rente, tegen sancties, tegen strikte voorwaarden.

Deel B — De drie private poorten

ING — de bank als reddingsboei

Wanneer de overheidsbetalingen wegvallen en de medische kosten blijven oplopen, raakt de gezamenlijke bankrekening in het rood. De creditcard raakt vol. ING biedt een betalingsregeling aan: de volledige schuld wordt geparkeerd op een aparte rekening en afgelost in vierentwintig maanden.

Wat de bank oplegt: roodstand verboden gedurende drie maanden. Geen creditcard gedurende twaalf maanden. Maandelijkse aflossing van € 286,55. Wie zich niet houdt aan de voorwaarden, verliest de regeling.

De bank is hier geen kwaadwillende partij. Ze past commerciële logica toe. Maar de logica van de markt is niet de logica van het sociaal recht. De

overheidsinstanties die het gat hebben veroorzaakt, dragen geen verantwoordelijkheid voor de rente en de sancties die het gezin moet betalen.

Vattenfall — de energieleverancier

De energieleverancier ziet de betalingsachterstanden oplopen. Er worden betalingsregelingen afgesproken, verbroken, hersteld. De maandtermijnen worden verhoogd om een nabetaling te voorkomen. En wanneer de patiënt een beroep doet op de beschermingsstatus "medisch kwetsbare consument", eist Vattenfall een verklaring van een onafhankelijke Nederlandse arts.

Die eis is voor een grensarbeider onuitvoerbaar. De huisartsen weigeren, de GGD weigert, de private markt vraagt exorbitante tarieven voor een keuring op afstand. Het gezin stuurt een Belgische medische verklaring. Vattenfall weigert die te erkennen. Pas na maanden geeft de leverancier toe dat de eis onterecht was en dat de bevoegdheid bij de netbeheerder ligt.

Uiteindelijk wordt de openstaande vordering uit handen gegeven aan incassobureau Flanderijn. De totale schuld loopt op tot ruim € 2.300.

Stedin — de netbeheerder

Na de late doorverwijzing van Vattenfall belandt het dossier bij de netbeheerder. Stedin is wettelijk verantwoordelijk voor de fysieke levering. De patiënt moet de volledige medische bewijslast opnieuw indienen bij een nieuwe private partij. Geen enkele datadoorgifte, geen enkele herkenning van eerder aangeleverde documenten.

Stedin is de instantie die de stroomtoevoer kan garanderen, wat cruciaal is voor de gekoelde opslag van insuline. Maar ook hier geldt: de patiënt moet de hele bewijslast opnieuw opbouwen, zonder dat de eerdere aanvraag bij Vattenfall wordt erkend.

Deel C — De bank als de-facto schuldeiser van de verzorgingsstaat



Figuur XX.2 — Wie draagt de schuld? De overheid veroorzaakt het gat en draagt geen verantwoordelijkheid. De private markt vult het gat en incasseert de rente. Het gezin draagt de gevolgen: verlies van inkomen, verlies van toeslagen, oplopende rente, incassokosten, verdere verarming.

Wat dit hoofdstuk vaststelt

De keten van falende overheidsinstanties leidt uiteindelijk tot één centrale plek: de bankrekening. Wat daar niet binnenkomt, en wat er wel uit weglekt, bepaalt hoe diep het gezin zakt. En wat het gezin niet kan opvangen, wordt opgevangen door de commerciële markt — tegen rente, tegen sancties, tegen incassokosten.

De private partijen zijn hierin niet de boosdoeners. Ze passen commerciële logica toe. Wat dit hoofdstuk laat zien, is dat de overheid zich heeft teruggetrokken uit een deel van haar verantwoordelijkheid. Het gat dat ze laat vallen, wordt door de markt gedicht. Maar de markt dicht geen gaten uit solidariteit. De markt dicht gaten tegen een prijs.

En die prijs wordt betaald door het gezin dat al geen inkomen heeft. Door de ouders die al geen uitkering krijgen. Door de patiënt wiens amputaties door niemand worden gecompenseerd. Door het kind dat geen rol speelt in dit spel maar wel de gevolgen draagt.

Voor wie in dezelfde situatie zit: de commerciële keten heeft geen boodschap aan de oorzaak van de schuld. Wat helpt:

1. Verzamel bewijs van elke overheidsweigering die tot de schuld heeft geleid. Bewijs dat de schuld niet door uw eigen keuzes is ontstaan, maar door falende instanties.
2. Vraag bij de gemeente een bijzondere bijstand voor de ontstane schulden. Als de gemeente weigert, dient u formeel bezwaar in en verwijst u naar de causale keten.
3. Neem contact op met de schuldhulpverlening van uw gemeente (via het Loket Schuldhulpverlening). Vraag om een minnelijke schuldregeling waarin de oorzaak van de schuld wordt meegewogen.
4. Schakel een sociaal raadsman of juridisch adviseur in (via de vakbond of het Juridisch Loket) voor de onderhandeling met commerciële partijen.

De private markt is niet verplicht rekening te houden met de oorzaak. Maar een vastgestelde causale keten kan wel de onderhandelingspositie veranderen.

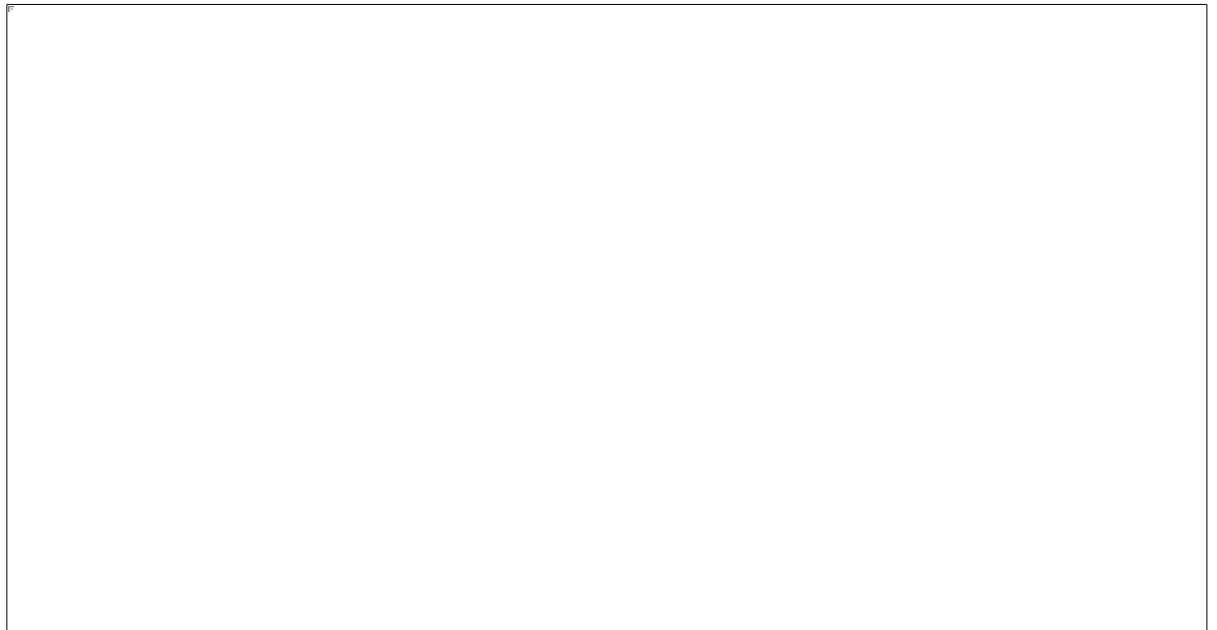
Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool (♂, ♀). De feiten en bedragen zijn gebaseerd op Document B. Dit hoofdstuk is geen juridisch of financieel advies.

V. Europa

De Europese laag

Wanneer de nationale wegen zijn uitgeput en de nationale politiek niet ingrijpt, blijft er nog één laag: Europa. In theorie zou Europa de oplossing moeten bieden voor een grensoverschrijdend probleem. In de praktijk blijkt dat de meeste Europese instanties geen mandaat hebben om een vastgelopen nationale keten te doorbreken. Maar er zijn in dit dossier twee uitzonderingen opgedoken. Twee openingen waar niemand op had gerekend.

Deel A — De Europese en internationale laag



Figuur XXII.1 — De Europese en internationale laag. Elk met een eigen mandaat, elk met een eigen beperking. Twee uitzonderingen springen eruit: het Europees Parlement, waar petitie 1034/2026 openbaar is gemaakt en openstaat voor medeondertekenaars, en de Commissie, die al sinds 2022 meerdere inbreukklachten tegen België en Vlaanderen onderzoekt.

Deel B — De cirkelverwijzing



Figuur XXII.2 — De cirkelverwijzing. De Europese instanties verwijzen naar elkaar. De Commissie wacht op de lidstaten. De lidstaten wachten op de Commissie. SOLVIT wacht op een duidelijke schending. De ELA wacht op een verzoek van de staten. Het Parlement kan geen nationale besluiten herzien. Het EHRM wacht op nationale rechtsgangen.

Deel C — De twee openingen

In deze ogenschijnlijk gesloten cirkel zijn in september 2026 twee openingen ontstaan waar niemand op had gerekend.

Opening 1 — PETI 1034/2026 open voor medeondertekenaars

Het Europees Parlement heeft petitie 1034/2026 in behandeling genomen. Op 25 september 2026 is de status gewijzigd naar "beschikbaar voor medeondertekenaars". Dat betekent dat de petitie een officiële parlementaire samenvatting heeft gekregen en openbaar is gemaakt op het petitieportaal van het Europees Parlement.

De samenvatting is gepubliceerd onder de beleidsterreinen Interne markt, Werkgelegenheid, Gezondheid, Sociale zaken en Grondrechten, met vermelding van België en Nederland als betrokken lidstaten. De petitie verankert het structurele verzuim van beide lidstaten inzake het Vester-arrest, de weigering tot samentelling van verzekeringsperioden, en de verblijfsvereisten. En vraagt de Europese Commissie om een inbreukprocedure te starten.

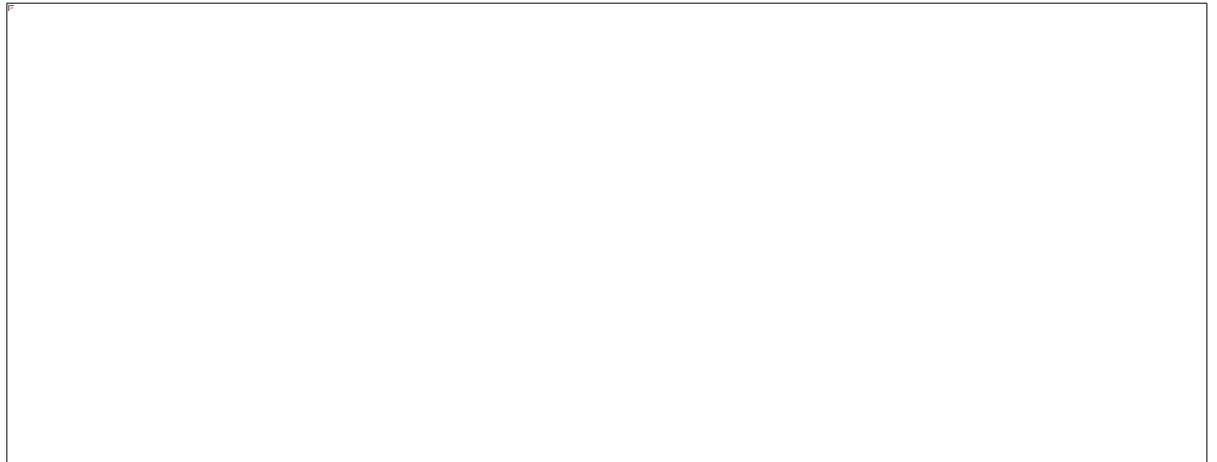
Wat dit betekent: de petitie is niet langer een privéklacht in een postbus. Het is een formeel parlementair dossier dat door elke EU-burger kan worden ondertekend. Dat verandert de politieke status van het dossier.

Opening 2 — De Commissie onderzoekt al sinds 2022

Op 25 september 2026 is een officieel schrijven van de Europese Commissie (DG EMPL) in het dossier gekomen. Wat daaruit blijkt, is dat de Commissie al sinds 2022 en 2023 meerdere inbreukklachten tegen België en Vlaanderen onderzoekt. Het gaat om klachten over de Vlaamse jobbonus, de

studiefinanciering, en het Groeipakket — alle drie onder Verordening 492/2011 over het vrije verkeer van werknemers.

De Commissie heeft in al die jaren geen definitief besluit genomen. Dat betekent niet dat de klachten zijn afgewezen. Het betekent dat ze open zijn. En dat de klacht van dit gezin aansluit bij een reeks klachten die de Commissie al aan het onderzoeken is.



Figuur XXII.3 — De twee openingen. Enerzijds is de petitie in het Europees Parlement openbaar en open voor medeondertekenaars. Anderzijds blijkt dat de Europese Commissie al sinds 2022 meerdere klachten tegen België en Vlaanderen onderzoekt zonder tot een besluit te komen. De klacht van dit gezin is geen geïsoleerd geval.

Deel D — De inbreukprocedure die niet komt

De Europese Commissie heeft één instrument dat bindend is: de inbreukprocedure. Wanneer een lidstaat het Unierecht structureel schendt, kan de Commissie een procedure starten die uiteindelijk leidt tot een uitspraak van het Hof van Justitie, en in theorie tot financiële sancties voor de lidstaat.

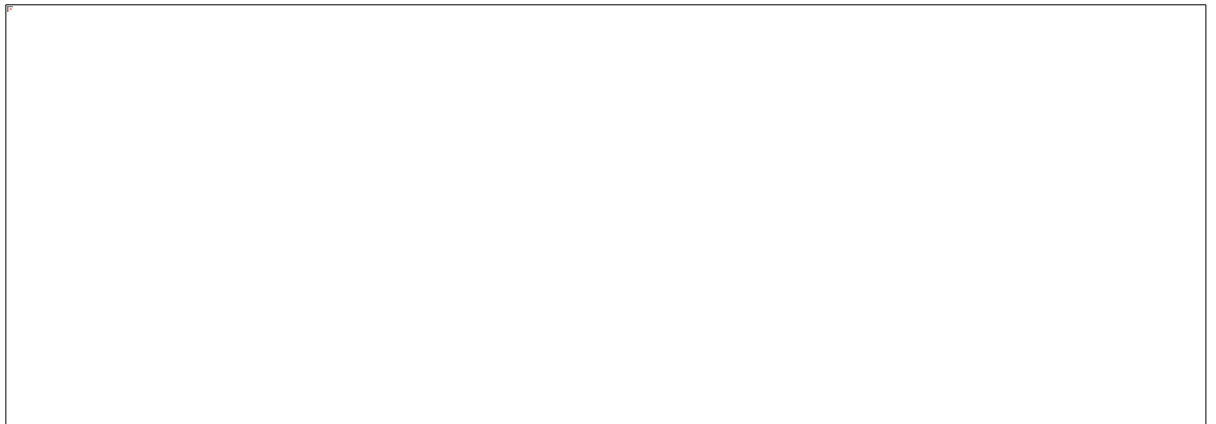
In de praktijk is dit een politiek besluit, geen juridisch automatisme. De Commissie weegt af of een inbreukprocedure politiek opportuun is. In dit dossier is de klacht geregistreerd onder CPLT(2026)01544 en samengevoegd met andere klachten onder Ares(2026)5891709. De Commissie heeft nog geen inbreukprocedure gestart.

De redenen waarom dat niet gebeurt, zijn structureel:

- De Commissie ontvangt duizenden klachten per jaar. Ze kan niet voor elke klacht een procedure starten.
- De coördinatie van sociale zekerheid is formeel een gedeelde bevoegdheid. Lidstaten hebben een ruime beoordelingsmarge.
- Een inbreukprocedure duurt gemiddeld vier tot zes jaar voordat een uitspraak volgt.
- Een uitspraak stelt de schending vast, maar dwingt niet altijd tot een oplossing voor het individuele dossier.

Wat dit betekent voor de burger: zelfs wanneer de Commissie zou ingrijpen, zou de procedure jaren duren. En zelfs wanneer het Hof zou uitspreken dat er een schending is, zou dat het individuele dossier niet meteen oplossen.

Deel E — De Europese tegenstrijdigheid



Figuur XXII.4 — De Europese tegenstrijdigheid. De EU coördineert de sociale zekerheid, maar harmoniseert niet. Zolang dat zo blijft, hangt elke oplossing af van de nationale overheden.

Wat dit hoofdstuk vaststelt

De Europese laag heeft de architectuur geschapen waarin grensoverschrijdende sociale zekerheid geregeld zou moeten zijn. Ze heeft de regels vastgesteld, de bemiddelingsnetwerken opgericht, de coördinatie-instellingen in het leven geroepen. En ze heeft het toezicht op de naleving van de regels aan zichzelf toevertrouwd.

Maar de Europese laag heeft nagelaten de architectuur ook af te dwingen. De meeste instanties kunnen alleen kijken, bemiddelen, rapporteren — zonder dwingende macht. En de weg naar de rechter is lang.

Twee dingen vallen op. De petitie in het Europees Parlement is openbaar geworden en staat open voor medeondertekenaars. Dat verandert de politieke status van het dossier: het is niet langer een privéklacht. En de Europese Commissie onderzoekt al sinds 2022 meerdere inbreukklachten tegen België en Vlaanderen. De klacht van dit gezin sluit aan bij een reeks die al loopt.

Wat overblijft, is een burger die op elk Europees loket heeft aangeklopt en op elk loket dezelfde boodschap krijgt: *wij zijn niet bevoegd voor uw individuele geval*. Maar waar de deuren gesloten bleven, zijn er twee op een kier gegaan. Voor een dossier dat tien jaar lang door niemand werd gehoord, is dat niet niets.

Voor wie in dezelfde situatie zit: de Europese weg is lang, maar niet zonder openingen.

1. *Dien een petitie in bij het Europees Parlement (PETI).* Eenmaal ontvankelijk en openbaar, wordt de petitie zichtbaar op het petitieportaal. U kunt andere burgers vragen om mede te ondertekenen. Dat verandert de politieke status.
2. *Registreer de klacht bij de Commissie (DG EMPL).* Elke klacht wordt geregistreerd. Meerdere klachten over hetzelfde thema kunnen worden samengevoegd tot een dossier.
3. *Wees voorzichtig met het EHRM.* Het Hof verklaart klachten onontvankelijk zolang nationale rechtsmiddelen niet zijn uitgeput. Eerst nationaal procederen.
4. *Gebruik de ELA niet rechtstreeks.* De ELA bemiddelt alleen op verzoek van lidstaten. Het gaat via SOLVIT, als dat orgaan tenminste wil doorverwijzen — wat in dit dossier niet gebeurde.

De Europese weg is er. Twee openingen zijn er ook. Het is aan de burger om ze te gebruiken.

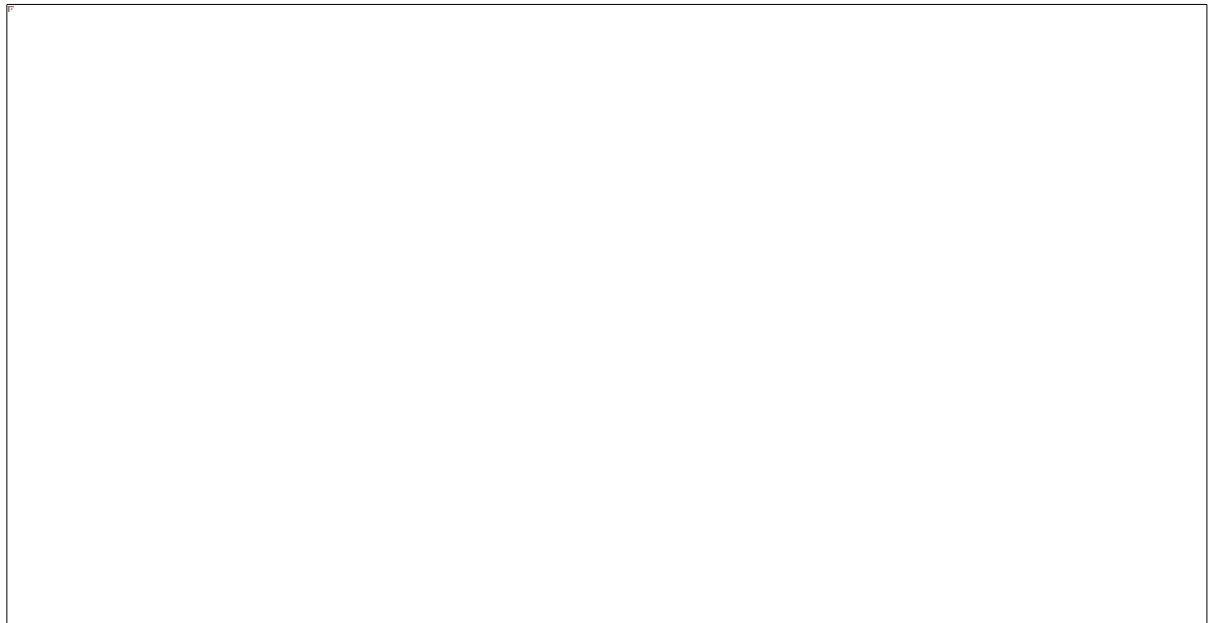
Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. De wettelijke basis van de verschillende procedures is gebaseerd op de Verdragen van de Europese Unie (art. 258 en 259 VWEU voor de inbreukprocedure), de reglementen van het Europees Parlement (PETI-procedure) en het Statuut van de Raad van Europa (EHRM). De informatie over de klachtprocedures is gebaseerd op Document B. Dit hoofdstuk is geen juridisch advies.

VI. Wie toekijkt

De controle- en bemiddelingslaag

Wanneer een uitvoeringsinstantie weigert, bestaat er een laag die geacht wordt in te grijpen: de ombudsmannen, de bemiddelingsdiensten, de Europese netwerken. In dit dossier is die laag aangesproken. Ze heeft geluisterd, onderzocht, en op elk niveau vastgesteld dat ze niet kan ingrijpen. Aan het einde blijkt dat de zwaarste bemiddelingsroute — de Europese Arbeidsautoriteit — niet eens toegankelijk is.

Deel A — De vier bemiddelaars



Figuur XV.1 — Vier bemiddelaars, vier beperkingen. De Federale Ombudsman kan tussenkomen in lopende zaken, maar niet dwingen. De Nationale Ombudsman kan niet tussenkomen zolang er een bestuursrechtelijke voorziening openstaat. SOLVIT kan niet dwingen en sluit bij lopende procedures. Het GIP kan alleen informeren en weigert een systeemfout te melden.

Deel B — Het verschil tussen de twee ombudsmannen

De Belgische en Nederlandse ombudsman lijken op elkaar, maar hun wettelijke kaders zijn fundamenteel verschillend.

Figuur XV.2 — De twee ombudsmannen. De Federale Ombudsman kan tussenkomen in lopende administratieve zaken. De Nationale Ombudsman is wettelijk uitgesloten van tussenkomst zolang er een bestuursrechtelijke voorziening openstaat.

Deel C — De cirkelverwijzing tussen de twee SOLVIT-centra

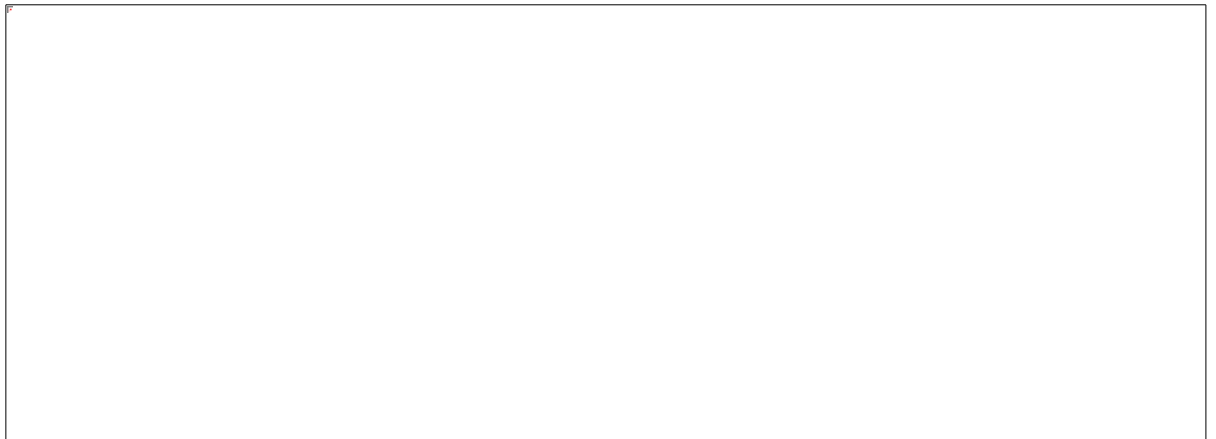
In de Europese architectuur is SOLVIT het orgaan dat moet bemiddelen wanneer nationale overheidsdiensten het EU-recht schenden. In dit dossier zijn twee SOLVIT-centra betrokken: SOLVIT Nederland en SOLVIT België. Wat volgt is een patroon van wederzijdse doorverwijzing — tot beide centra zich terugtrekken.

Figuur XV.3 — De cirkelverwijzing tussen SOLVIT NL en SOLVIT BE. Beide centra verwijzen naar elkaar. En wanneer de patiënt vraagt om doorverwijzing naar de Europese Arbeidsautoriteit, weigeren beide: SOLVIT NL omdat er geen schending is vastgesteld, SOLVIT BE omdat doorverwijzing niet tot de eigen opdracht zou behoren.

Deel D — De ELA: de weg die niet opengaat

Wanneer SOLVIT geen oplossing biedt, blijft er nog één Europees orgaan over dat speciaal in het leven is geroepen voor grensoverschrijdende geschillen: de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). De ELA is opgericht om eerlijke arbeidsmobiliteit te bevorderen en bemiddeling te faciliteren tussen lidstaten bij grensoverschrijdende problemen met sociale zekerheid.

In theorie zou de ELA de instantie moeten zijn die optreedt wanneer nationale overheden er samen niet uitkomen. In de praktijk blijkt de ELA voor een individuele burger niet toegankelijk.



Figuur XV.4 — De ELA als gesloten deur. De ELA bemiddelt alleen op verzoek van lidstaten. Rechtstreekse verzoeken van burgers worden niet ontvankelijk verklaard. En de doorgeefluiken die zouden moeten doorverwijzen (SOLVIT NL en BE) weigeren dat te doen. Het orgaan dat speciaal voor dit soort situaties is opgericht, blijft onbereikbaar voor wie het het hardst nodig heeft.

Deel E — Het patroon

Wat alle bemiddelaars gemeen hebben, is een fundamenteel kenmerk: ze kunnen onderzoeken, aanbevelen en rapporteren, maar niet **dwingen**. Geen enkele bemiddelaar kan een uitvoeringsinstantie verplichten een beslissing te herzien, een uitkering toe te kennen, of een registratie door te voeren.

Daar komt een tweede kenmerk bij: elke bemiddelaar heeft een eigen drempel voor **wanneer** hij mag tussenkomen. De Federale Ombudsman mag dat bij lopende zaken. De Nationale Ombudsman mag dat niet. SOLVIT mag dat niet bij lopende rechtszaken. Het GIP mag dat nooit. De ELA mag dat alleen op verzoek van lidstaten. Het EHRM mag dat alleen na uitputting van alle nationale middelen.

En in dit dossier blijkt dat de zwaarste bemiddelingsroute — de Europese Arbeidsautoriteit — niet alleen beperkt is, maar volledig gesloten. De ELA is ontworpen voor situaties zoals deze, maar is voor een individuele burger niet toegankelijk. En de enige doorgeefluiken die toegang zouden kunnen verlenen (SOLVIT NL en BE) weigeren dat te doen.

Wat overblijft is dat de bemiddelingslaag functioneert als een reeks filters. Elke klacht wordt geregistreerd, onderzocht, en doorverwezen naar een andere

instantie die ook niet kan ingrijpen. En wanneer de laatste instantie bereikt wordt, blijkt ook die een gesloten deur te hebben.

Voor wie in dezelfde situatie zit:

1. *De Federale Ombudsman (BE)* is de enige bemiddelaar die in lopende zaken kan tussenkomen zonder dat er eerst een rechtszaak nodig is. Dien daar een klacht in als u vastloopt bij een federale overheidsdienst.
2. *De Nationale Ombudsman (NL)* kan pas iets doen als alle bestuursrechtelijke procedures zijn afgerond. Begin dus niet bij de Ombudsman, maar bij de instantie zelf en daarna bij de rechter.
3. *SOLVIT* is nuttig voor informatie en voor het documenteren van een structureel probleem. In dit dossier weigerden beide centra echter de zaak door te verwijzen naar de ELA. Verwacht dus geen doorbraak via dit kanaal.
4. *De ELA* is rechtstreeks niet toegankelijk voor burgers. Alleen via SOLVIT-centra. En die weigeren in dit dossier consequent.

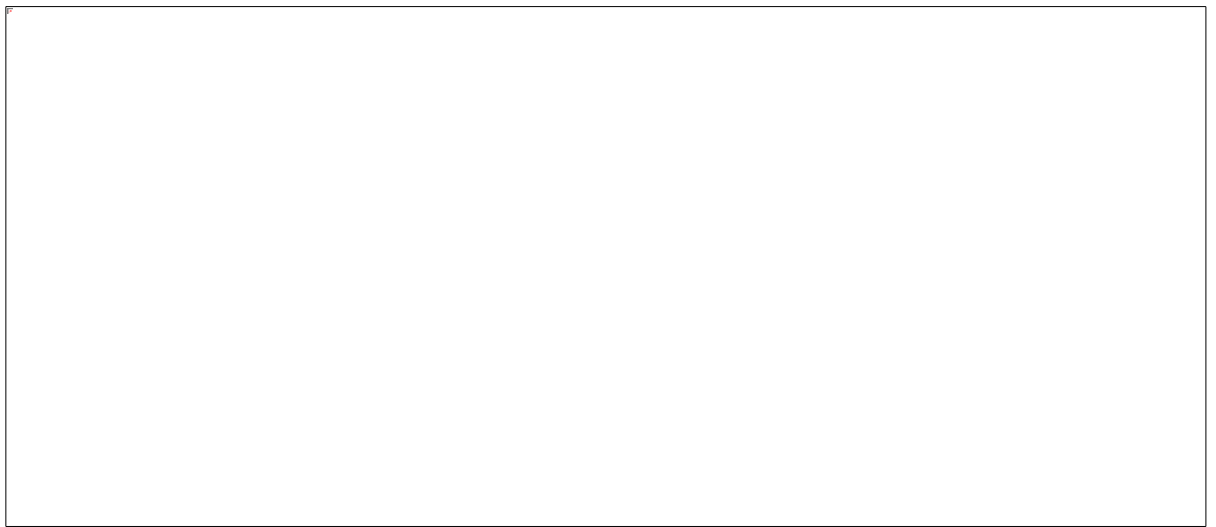
De bemiddelingslaag is een aanvulling op de juridische weg, geen vervanging. En soms is zelfs de aanvulling gesloten.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie. De feiten zijn gebaseerd op Document B. De wettelijke kaders zijn gebaseerd op de officiële communicatie van de betrokken instanties. Dit hoofdstuk is geen juridisch advies.

De rechtbanken

Wanneer geen enkele instantie nog ingrijpt, blijft de rechter over. In theorie is dat de plek waar een beslissing kan worden afgedwongen. In de praktijk blijkt de toegang tot die rechter zelf een drempel te zijn — en die drempel is precies het probleem dat de rechter moest oplossen.

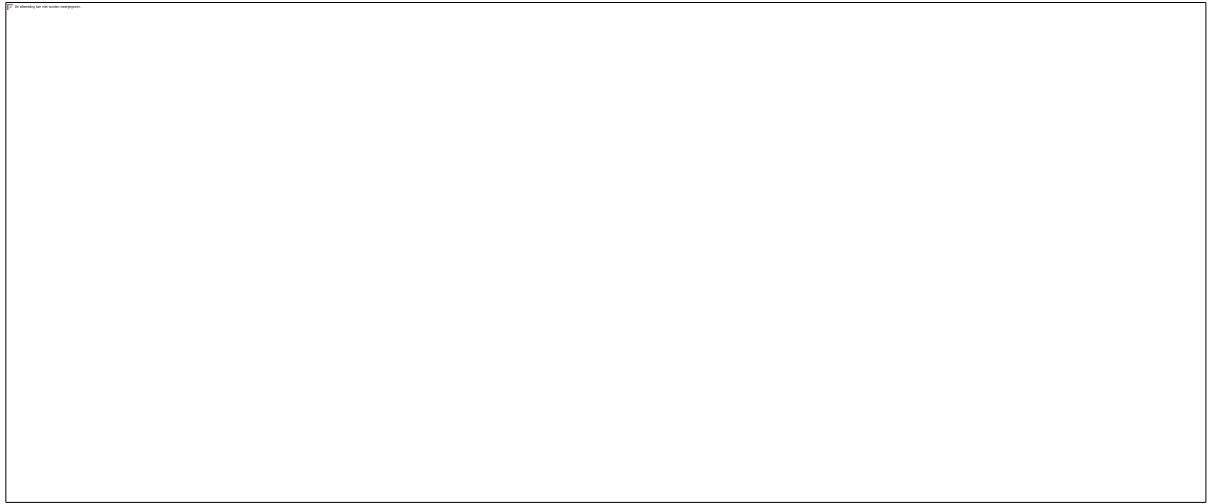
Deel A — De twee rechtswegen



Figuur XVI.1 — De twee rechtswegen. In België is de arbeidsrechtbank toegankelijk via een eenvoudig verzoekschrift, zonder rolrecht en zonder rechtsplegingsvergoeding voor de burger. De enige kosten zijn het ereloon van de advocaat. In Nederland begint de weg met een bezwaarschrift bij de instantie zelf, gevolgd door beroep bij de bestuursrechter, met griffierecht en advocaatkosten.

Deel B — De pro deo-drempel

Beide landen kennen een systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand: pro deo in België, toevoeging in Nederland. Wie onder een bepaalde inkomensgrens valt, krijgt een advocaat toegewezen waarvan de overheid de kosten (grotendeels) draagt. Maar de drempels zijn problematisch voor een grensarbeider in een medische crisis.



Figuur XVI.2 — De pro deo-drempels. In België wordt getoetst aan het netto maandinkomen van twee jaar eerder (het peiljaar). In Nederland aan het bruto jaarinkomen van twee jaar eerder. In beide landen is het werkelijke inkomen in de medische crisis gedaald tot nul, maar het peiljaarinkomen is nog gebaseerd op de periode vóór de crisis. De burger verdient op papier te veel, terwijl hij in werkelijkheid niets heeft.

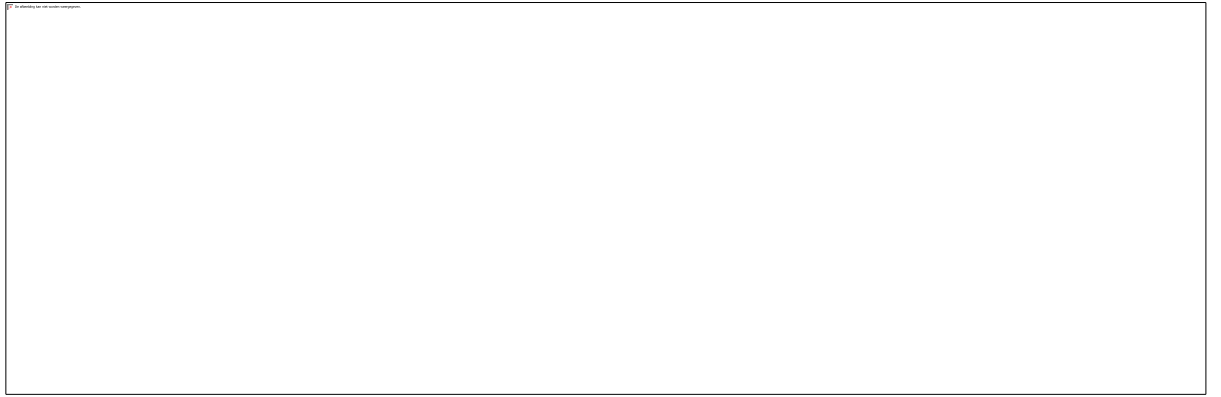
Deel C — De ironie van het peiljaar

De kern van het probleem is het **peiljaar**. Beide landen toetsen het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand aan het inkomen van twee jaar eerder. Dat is bedoeld om fraude te voorkomen: wie snel zijn inkomen verlaagt om in aanmerking te komen, wordt geweerd. Maar het systeem houdt geen rekening met een plotselinge, onvrijwillige inkomensdaling door ziekte.

In het dossier van de gebruiker:

- Twee jaar geleden was het inkomen nog normaal — de vader werkte, de medische crisis was nog niet begonnen.
- Nu is het werkelijke inkomen nul: de ziekte-uitkering is geblokkeerd, de WIA is geweigerd, de toeslagen staan op nul.
- De medische kosten hebben het beschikbare inkomen volledig uitgehold.
- Maar het peiljaarinkomen is nog steeds het oude, normale inkomen.

Het gevolg: de burger verdient op papier te veel voor pro deo, terwijl hij in werkelijkheid geen geld heeft om een advocaat te betalen. De drempel die bedoeld is om de zwaksten te beschermen, sluit juist degenen uit die door een plotselinge crisis in de problemen zijn geraakt.



Figuur XVI.3 — De ironie van het peiljaar. Het systeem toetst aan het inkomen van twee jaar geleden. In de medische crisis is dat inkomen niet meer representatief. De burger verdient op papier te veel voor pro deo, terwijl zijn werkelijke inkomen nul is. De drempel die bedoeld is om de zwaksten te beschermen, sluit juist degenen uit die door een plotselinge crisis in de problemen zijn geraakt.

Deel D — Wat dit betekent

De juridische weg is in theorie de ultieme oplossing. De rechter kan een instantie dwingen een beslissing te herzien. In de praktijk blijkt de toegang tot die rechter zelf een drempel te zijn. En die drempel is precies het probleem dat de rechter moest oplossen.

De burger die geen advocaat kan betalen, kan de juridische weg niet bewandelen. De burger die geen pro deo krijgt omdat zijn peiljaarincome te hoog is, kan de juridische weg niet bewandelen. De burger die geen inkomen heeft omdat zijn uitkeringen zijn geblokkeerd, kan de juridische weg niet bewandelen. Het systeem verwijst naar de rechter, maar de rechter is onbereikbaar voor wie het meest behoefte heeft aan toegang.

In België is de drempel lager: het verzoekschrift is eenvoudig en kosteloos, en de enige kosten zijn het ereloon van de advocaat. Maar ook dat ereloon is voor veel mensen onbetaalbaar. In Nederland is de drempel hoger: griffierecht, advocaatkosten, en een toetsingskader dat nog strenger is.

Voor wie in dezelfde situatie zit: de juridische weg is niet onmogelijk, maar de toegang is beperkt door het peiljaar. Drie dingen om te weten:

1. Vraag bij het Bureau voor Juridische Bijstand (BE) of de Raad voor Rechtsbijstand (NL) om een **peiljaarverlegging**. In Nederland is dat mogelijk als het inkomen met minimaal 15% is gedaald ten opzichte van twee jaar eerder. In België kan het Bureau voor Juridische Bijstand ook rekening houden met de actuele bestaansmiddelen.
2. In België is het verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank gratis. U kunt het zelf opstellen, zonder advocaat. Een vakbond of sociale organisatie kan u helpen.

3. In Nederland is een bezwaarschrift bij de instantie zelf gratis. Als dat niet helpt, is de volgende stap de bestuursrechter, maar daar zijn kosten aan verbonden. Vraag een toevoeging aan als uw inkomen in het lopende jaar laag is — ook als het peiljaarinkomen hoger was.

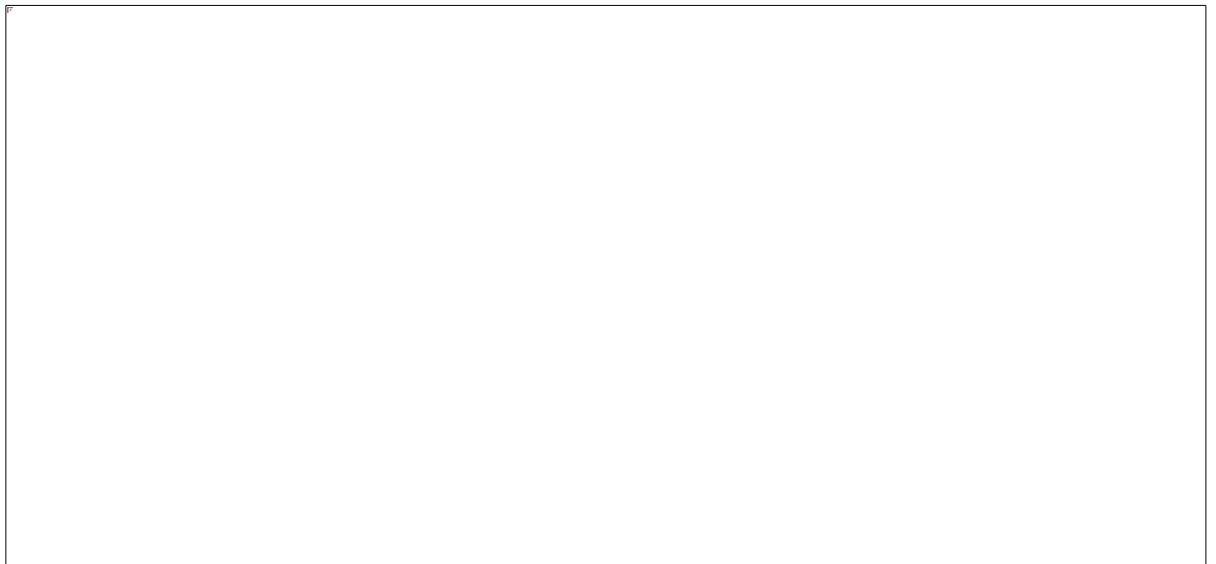
De juridische weg is de laatste weg. Maar hij is niet voor iedereen even toegankelijk.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. De inkomensgrenzen voor pro deo en toevoeging zijn gebaseerd op de officiële communicatie van de betrokken instanties (advocaat.be, Raad voor Rechtsbijstand). Dit hoofdstuk is geen juridisch advies. Raadpleeg bij twijfel een gespecialiseerde dienst of advocaat.

De politiek

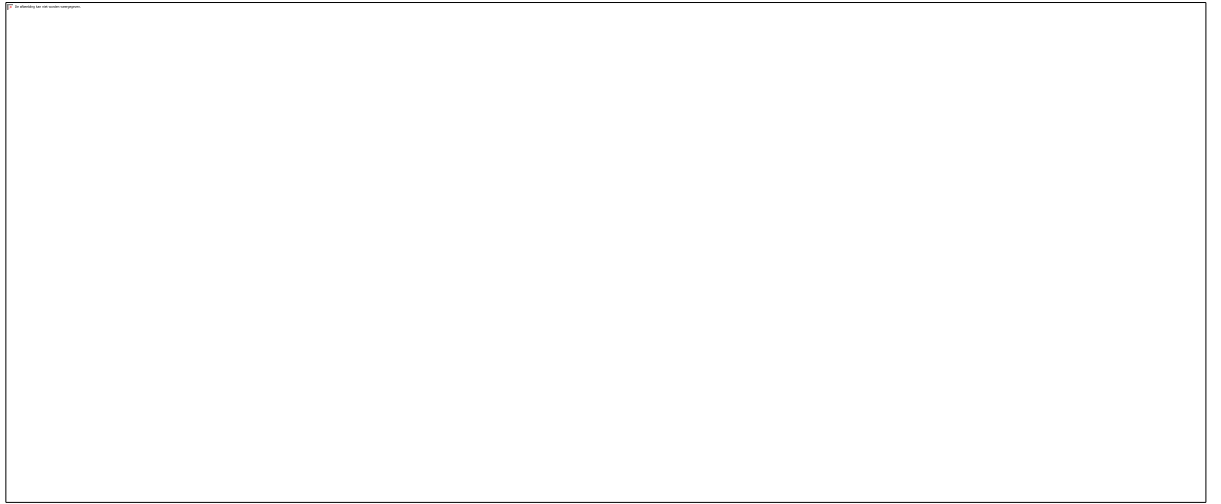
De politiek heeft de macht om wetten te veranderen, budgetten toe te wijzen en uitvoeringsinstanties bij te sturen. In theorie is het de ultieme correctiemacht. In de praktijk blijkt dat de politiek die macht alleen uitoefent wanneer het probleem als een collectief systeemfalen wordt gepresenteerd — niet wanneer het als een individuele klacht aankomt.

Deel A — De scheiding der machten



Figuur XVII.1 — De scheiding der machten. België kent een klassieke trias politica, vastgelegd in de artikelen 33, 36, 37 en 40 van de Grondwet. Nederland kent geen strikte scheiding, maar een stelsel van checks and balances, met de ministeriële verantwoordelijkheid (art. 42) en de inlichtingenplicht (art. 68) als kern.

Deel B — Wat de politiek wel en niet kan

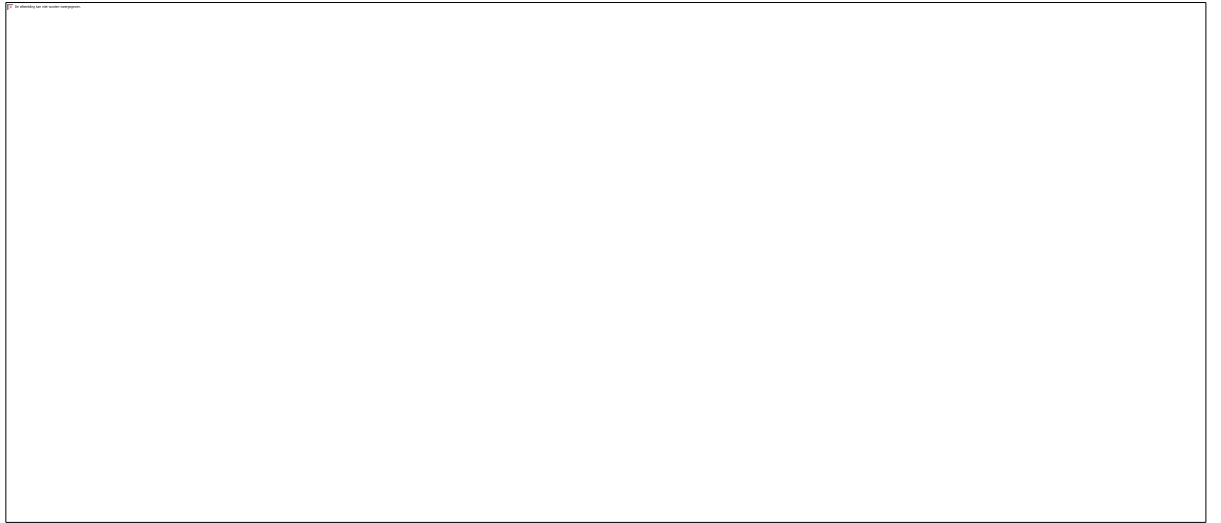


Figuur XVII.2 — Wat de politiek wel en niet kan. De politiek kan wetten maken en wijzigen, maar kan geen individuele beslissing herzien. Ze kan een uitvoeringsinstantie nieuwe opdrachten geven, maar kan een individueel dossier niet openen of sluiten. De scheiding der machten verbiedt inmenging in concrete zaken.

Deel C — De Belgische parlementaire praktijk

In België beschikt de Kamer van Volksvertegenwoordigers over een uitgebreid arsenaal aan controle-instrumenten. De vaste commissies — waaronder de commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen — bereiden wetgeving voor en controleren de regering. Binnen die commissies kunnen Kamerleden schriftelijke en mondelinge vragen stellen, en interpellaties houden die kunnen uitmonden in moties van aanbeveling of wantrouwen.

Daarnaast bestaat de Commissie voor de Verzoekschriften. Iedere burger kan daar een verzoekschrift indienen. De commissie gaat na of het verzoekschrift ontvankelijk is, en zendt het vervolgens door naar de bevoegde commissie of de bevoegde minister. Die minister wordt geacht binnen zes weken schriftelijk uitleg te geven. Daarna kan de commissie beslissen om het verzoekschrift te klasseren, door te verwijzen, of een hoorzitting te organiseren.

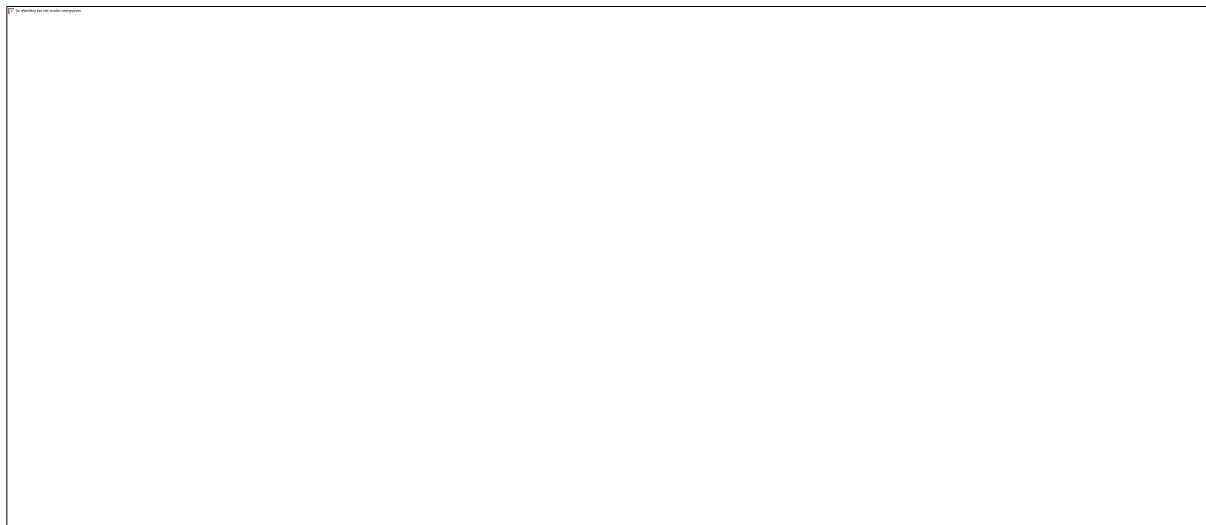


Figuur XVII.3 — De Belgische weg. De burger dient een verzoekschrift in. De Commissie voor Verzoekschriften verklaart het ontvankelijk en stuurt het door naar de bevoegde commissie en de minister. De minister geeft binnen zes weken uitleg. Daarna stopt het. In dit dossier: ontvankelijk verklaard, doorgestuurd, geen inhoudelijke reactie.

Deel D — De Nederlandse parlementaire praktijk

De Tweede Kamer kent een vergelijkbaar instrumentarium. Kamerleden kunnen schriftelijke vragen stellen, mondelinge vragen, interpellaties houden en moties indienen. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bevoegd voor de controle op het ministerie van SZW en de daaronder vallende uitvoeringsorganisaties.

Wat Nederland onderscheidt, is de parlementaire enquête. Dat is het zwaarste onderzoeksinstrument: een commissie die onder ede getuigen kan horen, documenten kan vorderen en een openbaar rapport uitbrengt. De toeslagenaffaire is het meest recente voorbeeld van hoe dat instrument werkt — en hoe lang het duurt voordat het wordt ingezet.



Figuur XVII.4 — De Nederlandse weg. De Tweede Kamer behandelt geen individuele klachten. De commissie SZW kan een dossier parkeren. Het zwaarste instrument — de parlementaire enquête — vereist een meerderheid en wordt alleen bij grote systeemcrises ingezet. De toeslagenaffaire toont hoe lang dat duurt.

Deel E — De verschillen op een rij

Aspect	België	Nederland
Individuele klacht	Via Commissie Verzoekschriften · ontvankelijkheidstoets · doorverwijzing naar minister · schriftelijke uitleg binnen 6 weken	Niet in behandeling · juridische weg moet openstaan of uitgeput zijn · brief aan Kamerlid leidt zelden tot actie
Parlementair instrument	Schriftelijke en mondelinge vragen · interpellaties · moties van aanbeveling · motie van wantrouwen · onderzoekscommissie	Schriftelijke en mondelinge vragen · interpellaties · moties · dertigledendebat · parlementaire enquête
Zwaarste middel	Parlementaire onderzoekscommissie · recht van onderzoek (art. 56 Grondwet)	Parlementaire enquête · getuigen onder ede · wettelijke basis (Wet parlementaire enquête 2008)

Aspect	België	Nederland
Praktijk in dit dossier	Verzoekschrift ontvankelijk verklaard, doorgestuurd, daarna stilte. Negen partijen aangeschreven, vijf reageerden niet, vier verwezen naar studiedienst of onbevoegd.	Brandbrief geregistreerd, geparkeerd voor commissiedebat, geen individuele actie. Partijen verwezen naar Ombudsman of studiedienst.
Doorlooptijd	Minister: 6 weken voor schriftelijke uitleg · daarna beslissing commissie	Geen termijn voor behandeling van individuele brieven · enquête: jaren

Deel F — De kracht van de framing

Dit is het centrale inzicht. Dezelfde feiten kunnen op twee manieren worden gepresenteerd, en die twee presentaties leiden tot twee volstrekt verschillende reacties van de politiek.



Deel G — Wat dit dossier doet

Dit dossier is geen klacht. Het is een audit. Dat is geen retorische keuze — het is een strategische keuze.

Een klacht wordt behandeld als een individueel probleem. Een audit wordt behandeld als een systemisch probleem. En alleen een systemisch probleem activeert de politieke instrumenten die tot echte verandering kunnen leiden.

De documenten in dit dossier zijn daarom opgebouwd als een audit:

- **Document B** is geen aaneenschakeling van klachten, maar een *data-matrix*: een feitelijke vastlegging van datums, referentienummers en correspondentie.
- **Document C** is geen prentenboek, maar een *visuele architectuur*: een structurele analyse van de institutionele lagen en de mechanismen die het falen veroorzaken.
- **Document D** is geen samenvatting, maar een *synthese*: de conclusies en de drie bouwstenen voor hervorming.

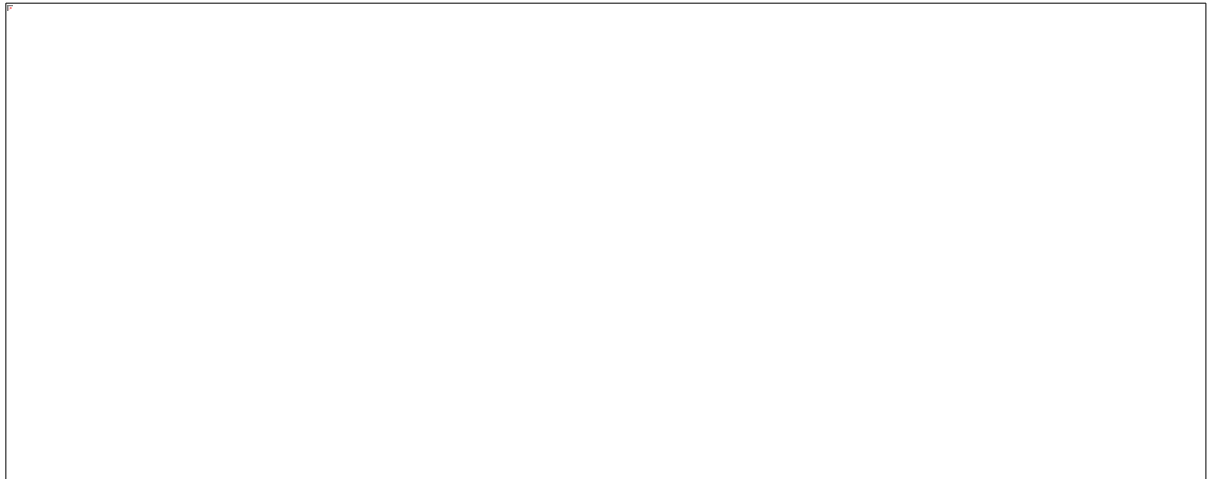
Het verschil is niet cosmetisch. Het bepaalt of de politiek het dossier kan wegschuiven — "wij gaan niet over individuele dossiers" — of dat ze zich ertoe moet verhouden.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool (σ , $\varnothing$). De feiten zijn gebaseerd op Document B. De constitutionele basis is artikel 33, 36, 37 en 40 van de Belgische Grondwet, en artikel 42 en 68 van de Nederlandse Grondwet. De parlementaire procedures zijn gebaseerd op de reglementen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Tweede Kamer. De informatie over de toeslagenaffaire is gebaseerd op openbare rapporten van de Nationale Ombudsman en de parlementaire enquêtecommissie. Dit hoofdstuk is geen juridisch advies.

De adel

De koning is in België en Nederland het symbolische hoofd van de staat. Formeel heeft hij geen zelfstandige macht: zijn handelingen zijn alleen geldig met de medeondertekening van een verantwoordelijke minister. Toch ontvangt hij jaarlijks duizenden verzoekschriften van burgers. Die verzoekschriften zijn geen juridische procedures. Ze zijn een informeel kanaal — en juist omdat ze informeel zijn, kunnen ze de politieke agenda bereiken op een manier die formele klachten niet lukt.

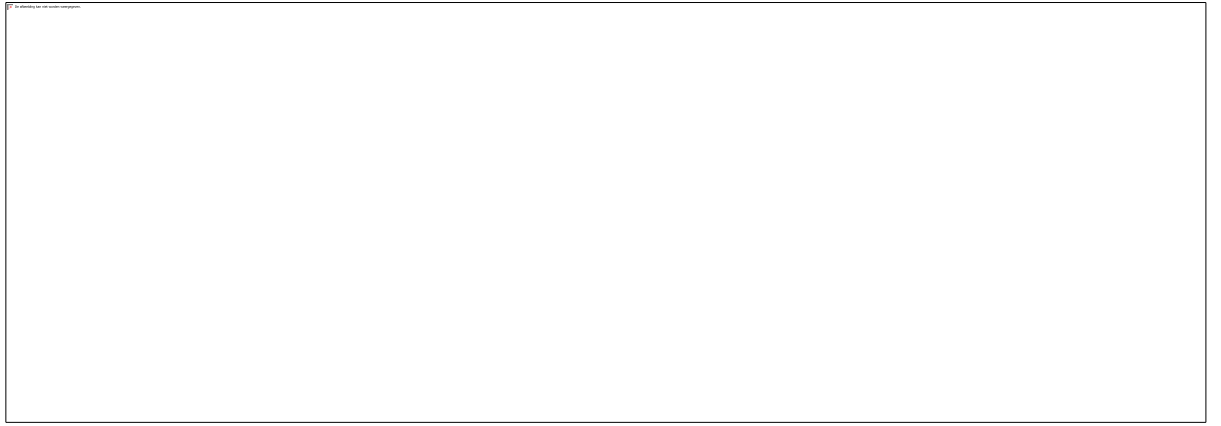
Deel A — De formele macht: wat de koning wel en niet kan



Figuur XVIII.1 — De formele positie van de koning. In België maakt de Koning deel uit van de wetgevende macht (art. 36) en berust de uitvoerende macht bij hem (art. 37), maar geen enkele akte is geldig zonder medeondertekening van een minister (art. 106). In Nederland is de Koning onschendbaar (art. 42) en beschikt hij niet over zelfstandige staatsrechtelijke bevoegdheden. In beide landen: de koning regeert, maar bestuurt niet.

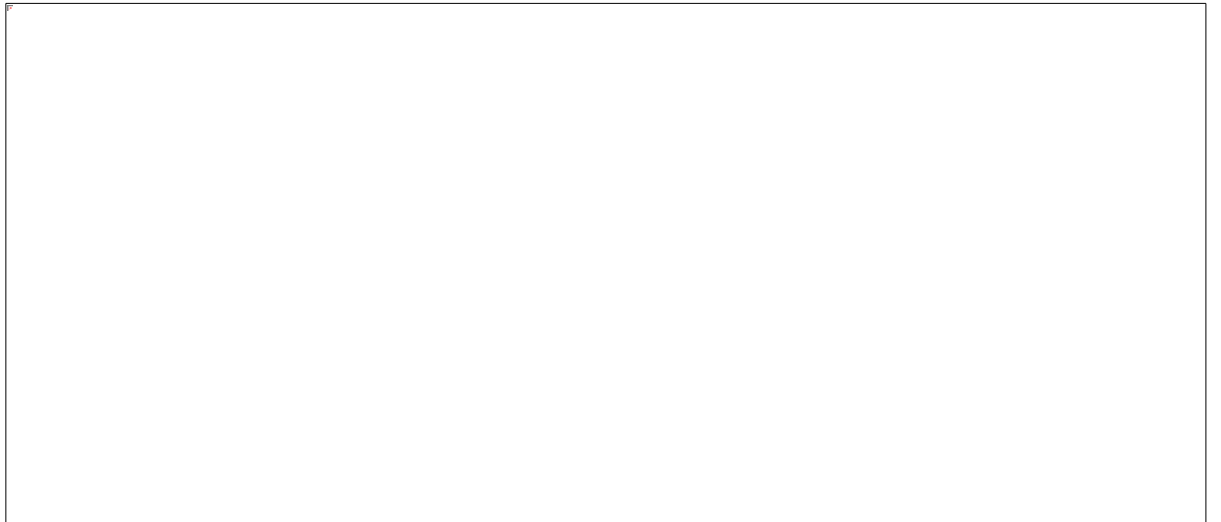
Deel B — Het petitierecht

In beide landen is het recht om een verzoekschrift in te dienen grondwettelijk verankerd.



Figuur XVIII.2 — Het petitierecht. In België is het petitierecht opgenomen in artikel 28 van de Grondwet, en artikel 57 geeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de bevoegdheid om verzoekschriften naar de ministers te verwijzen, die verplicht zijn uitleg te verschaffen. In Nederland is het petitierecht opgenomen in artikel 5 van de Grondwet, zonder specifieke parlementaire procedure. De Tweede Kamer heeft een eigen regeling voor de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven.

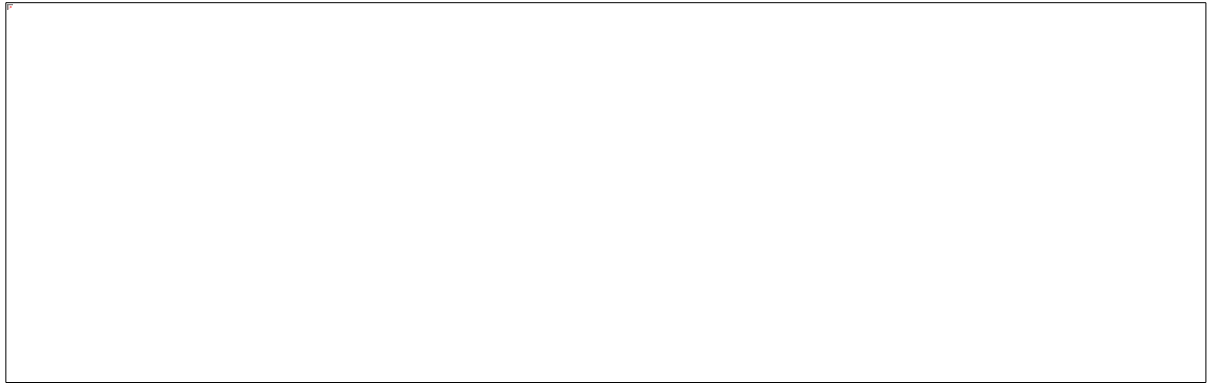
Deel C — De praktijk: hoe petities worden behandeld



Figuur XVIII.3 — De weg van een verzoekschrift. In België ontvangt de Dienst Verzoekschriften van het Paleis jaarlijks ongeveer tienduizend aanvragen. Elke aanvraag wordt onderzocht en ofwel van advies voorzien, ofwel doorverwezen naar de meest geschikte instantie. In Nederland ontvangt het Kabinet van de Koning jaarlijks drieduizend tot vijfduizend brieven. Het Kabinet analyseert en draagt over aan de verantwoordelijke minister. In beide gevallen: geen bindende doorwerking.

Deel D — De paradox van het informele kanaal

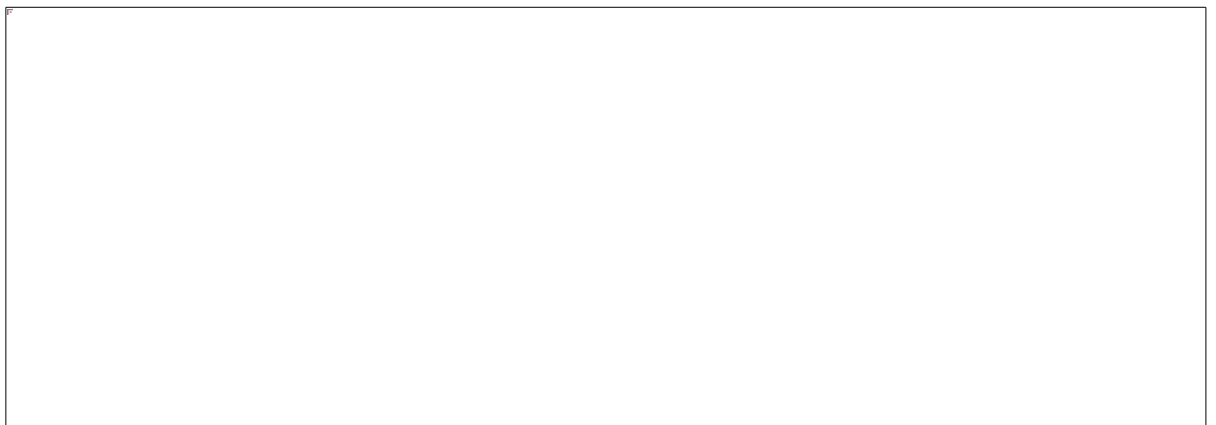
De koning heeft formeel geen macht. De minister is verantwoordelijk. De politiek bepaalt. En toch: het verzoekschrift aan de koning bereikt een plek die een gewone klacht niet bereikt.



Figuur XVIII.4 — De paradox van het informele kanaal. Een gewone klacht blijft in de uitvoerende laag. Een verzoekschrift aan de koning bereikt de politieke laag, omdat het door het Kabinet wordt geanalyseerd en door een minister moet worden beantwoord. De koning heeft geen macht, maar zijn postbus wel.

Deel E — De praktijk in dit dossier

In dit dossier is in beide landen een verzoekschrift ingediend bij het staatshoofd.



Figuur XVIII.5 — De twee verzoekschriften. In beide landen is een verzoekschrift naar het staatshoofd gestuurd. In België werkte de digitale weg niet door een DNS-fout op de mailserver van het Paleis; alleen de fysieke brief bereikte het Paleis. In Nederland werkte de digitale weg wel. In beide gevallen: doorverwijzing naar de verantwoordelijke minister, zonder inhoudelijke tussenkomst van de koning.

Deel F — Wat dit hoofdstuk vaststelt

De adel — de koning en zijn kabinet — heeft in België en Nederland geen uitvoerende macht. De koning regeert, maar bestuurt niet. Hij is onschendbaar, maar zijn handelingen zijn alleen geldig met de medeondertekening van een verantwoordelijke minister.

Toch is het verzoekschrift aan de koning een kanaal dat de politieke laag wél bereikt. Een gewone klacht blijft in de uitvoerende laag. Een verzoekschrift aan de koning wordt door het Kabinet geanalyseerd, door een minister beantwoord, en — belangrijker — de minister is er politiek verantwoordelijk voor. Daarmee bereikt het signaal een plek waar de uitvoerende laag het niet kan negeren.

De paradox is dat de koning geen macht heeft, maar zijn postbus wel. Het is een informeel kanaal. Geen juridische procedure. Geen recht op een beslissing. Maar een kanaal dat het signaal een laag hoger brengt. En in een dossier waarin de uitvoerende laag weigert te luisteren, is dat niet niets.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool. De constitutionele basis is artikel 28, 33, 36, 37, 57 en 106 van de Belgische Grondwet, en artikel 5, 42 en 68 van de Nederlandse Grondwet. De procedure voor verzoekschriften is gebaseerd op de officiële communicatie van het Koninklijk Paleis en het Kabinet van de Koning. Dit hoofdstuk is geen juridisch advies.

De bondgenoten en de waakhond

Naast de overheid en de private markt bestaan er organisaties die de burger zouden moeten bijstaan: vakbonden, gelijkekansencentra, mensenrechtenorganisaties, academici. In dit dossier komen vier van hen aan bod. Eén helpt daadwerkelijk, met een fiscale dienst die het verschil maakt. Eén verklaart zich onbevoegd op een technisch criterium. En de academische wereld opent zich pas wanneer het dossier onweerlegbaar is geworden — en dan gaat het snel.

Deel A — ACV: de vakbond die helpt en stopt

Het Algemeen Christelijk Vakverbond is de grootste Belgische vakbond. Naast syndicale vertegenwoordiging biedt het juridische bijstand, fiscale dienstverlening, en uitbetalingsdiensten voor werkloosheidsuitkeringen. In dit dossier speelt de vakbond drie rollen.

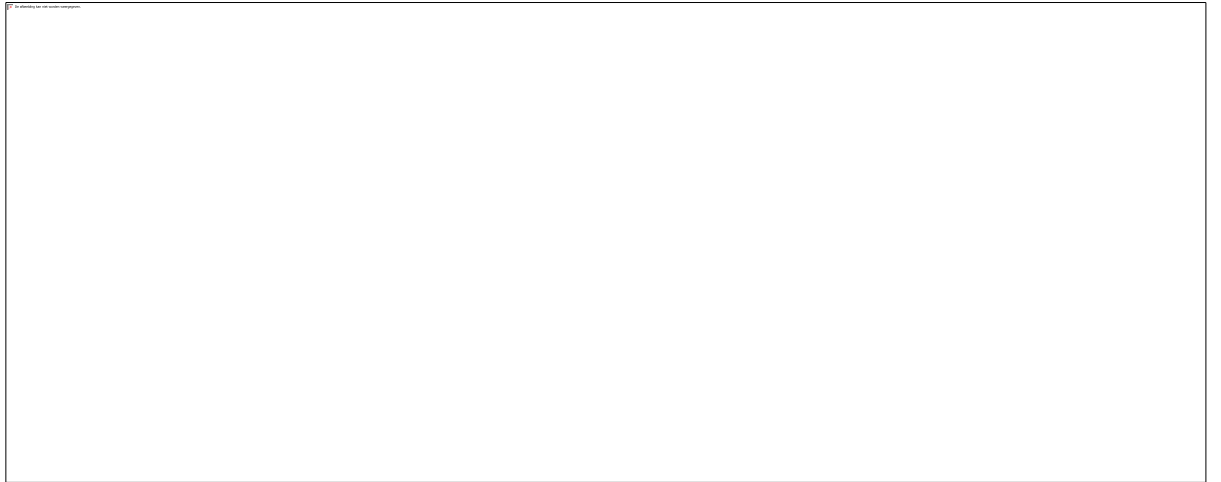
Wat werkt: de fiscale dienst

Via de fiscale dienst van het ACV Oost-Vlaanderen wordt de jaarlijkse Belgische belastingaangifte opgemaakt. De code invaliditeit wordt correct ingevuld. De attesten voor kinderopvang worden manueel toegevoegd. Het resultaat is een terugbetaling van € 2.669,97, definitief ingediend op 25 september 2026. Deze dienstverlening functioneert naar behoren.

Wat niet werkt: de juridische bijstand bij de CM

Wanneer de CM de ziekte-uitkering weigert en de samentellingsregels niet toepast, wordt de vakbond formeel geactiveerd. Het is niet de patiënt die lid is, maar zijn partner — zelf vakbondsafgevaardigde in het onderwijs. Via haar functie roept ze de hulp in van het Christelijk Onderwijzersverbond, de onderwijstak van dezelfde vakbond.

De juridische dienst erkent de systeemfout volmondig. De administratieve scheiding tussen invaliditeit en handicap wordt bevestigd. Toch weigert de vakbond juridische interventie tegen de CM, met een formeel argument: de patiënt zelf heeft geen lidnummer. Het betalende lid — de partner — ondervindt de financiële nevenschade, maar krijgt geen rechtsbijstand voor een dossier dat niet op haar naam staat.



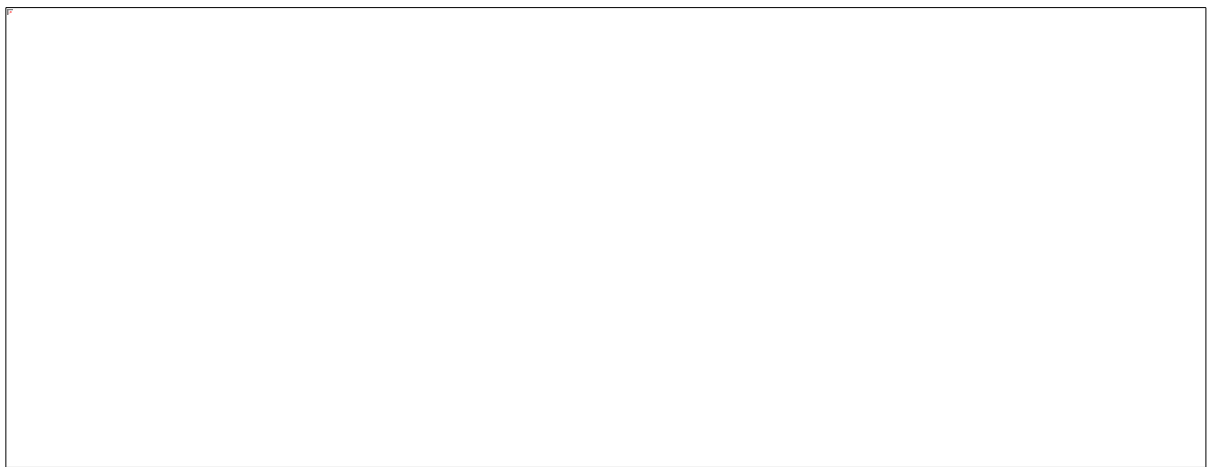
Figuur XXI.1 — ACV: twee poorten, twee uitkomsten. De fiscale dienst werkt. De juridische dienst stopt bij de individuele lidmaatschapsgrens: alleen het lid dat zelf een dossier heeft, krijgt bijstand.

Deel B — UNIA: de waakhond die niet mag bijten

UNIA is het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Het is de Belgische onafhankelijke waakhond tegen discriminatie. Wanneer uitvoerende instanties weigeren een burger te erkennen op basis van zijn woonplaats in een buurland, rijst de vraag of dat discriminatie is.

In april 2026 wordt UNIA formeel op de hoogte gesteld van de structurele uitsluiting van grensarbeiders. De melding betreft de weigering van medische erkenningen puur vanwege een Nederlands domicilie.

De beoordeling door UNIA ontmaskert een tekort in de Belgische antidiscriminatiewetgeving. De waakhond verklaart zich formeel onbevoegd, om twee dodelijke redenen.



Figuur XXI.2 — De onbevoegdheid van UNIA. UNIA verklaart zich onbevoegd om twee redenen: woonplaats is geen beschermd criterium in de antidiscriminatiewetgeving, en de uitsluiting vloeit voort uit de wet zelf.

UNIA sluit het dossier. En bevestigt daarmee ongewild dat de uitsluiting van grensarbeiders binnen het huidige systeem volkomen gelegaliseerd is.

Deel C — De academische observatielaag

De academische wereld is de laatste laag die de burger zou kunnen bijstaan. Universiteiten en expertisecentra bestuderen systeemfalen, publiceren over institutionele uitsluiting, en beschikken over de analytische middelen om een dossier wetenschappelijk te wegen. Wat gebeurt er wanneer hen een levende casus wordt aangeboden?

Maanden van stilte

Tussen mei en september 2026 worden verschillende academici en instellingen aangeschreven. Het expertisecentrum ITEM van de Universiteit Maastricht, het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven, het Montaigne Centrum van de Universiteit Utrecht, transitie-instituut DRIFT van de Erasmus Universiteit, en Amsterdam UMC. De reacties zijn maandenlang stil. Er komt geen enkele inhoudelijke reactie op een dossier dat precies de thema's belichaamt waarover deze instellingen publiceren.

De opening

Wanneer het volledige dossier in het najaar van 2026 de drempel van 250 pagina's onweerlegbaar empirisch materiaal overschrijdt, opent het expertisecentrum ITEM zich voor een inhoudelijke bestudering. Een hoogleraar bevestigt op 17 september 2026 de ontvangst van het dossier en zegt de stukken eerst te zullen lezen alvorens inhoudelijk te reageren.

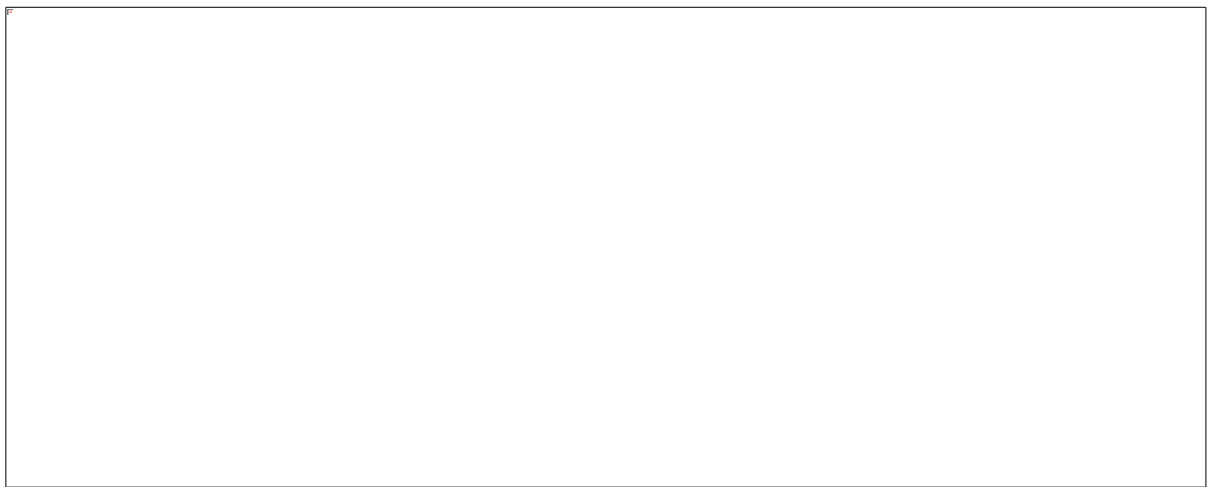
Wat volgt

In de week daarna wordt het dossier actief getoetst. Een onafhankelijk onderzoeker grensarbeid — werkzaam aan een academische instelling en niet bij het dossier betrokken — neemt het materiaal in behandeling en levert binnen enkele dagen een reeks van juridische analyses en alternatieve routes:

- De Wajong-route en de beperkingen onder Bijlage X van Verordening 883/2004 (niet-exporteerbare uitkeringen).
- Het Schumacker-arrest (C-279/93) en de 90-procentnorm als grondslag voor fiscale gelijkstelling.
- Het arrest-Dimitri Hendrix (C-385/17) over behoud van uitkering bij verhuizing.
- De koppeling tussen het Vester-arrest en de systeemtheorie van Frederic Vester.
- De centrale rol van de tuchtklacht bij de Orde der Artsen als systeemknoop.
- De weigering van de Europese parkeerkaart door de gemeente Hulst.

Daarnaast verkrijgt de onderzoeker een formele schriftelijke bevestiging van de FOD Financiën (Belasting Niet-Inwoners PG15 Ledeberg) dat het spontaan toevoegen van medische verklaringen bij de aangifte een geldige route is om de fiscale handicapstatus aan te tonen. Enkele dagen later levert hij een officieel schrijven van de Europese Commissie (DG EMPL, 25 september 2026) aan, waaruit blijkt dat de Commissie al sinds 2022 en 2023 drie inbreukklachten tegen België en Vlaanderen onderzoekt zonder tot een besluit te komen.

Wat maandenlang onmogelijk leek, gebeurt in vier dagen. Het academisch netwerk dat eerder zweeg, levert in één week een reeks van juridische doorbraken. De academische wereld werkt retrospectief, niet curatief — en wanneer zij eenmaal begint, werkt zij snel.



Figuur XXI.3 — Van stilte naar opening. De academische wereld reageert maandenlang niet op het dossier. Pas wanneer het 250 pagina's onweerlegbaar materiaal bevat, opent het expertisecentrum ITEM zich voor een inhoudelijke bestudering. En dan gaat het snel: binnen vier dagen worden nieuwe juridische routes, arresten en systeemkoppelingen aangeleverd.

Deel D — Wat dit hoofdstuk vaststelt

De vier bondgenoten die de burger zouden moeten bijstaan, werken alle vier binnen een eigen grens.

De vakbond werkt voor de leden, maar alleen voor het dossier dat op hun naam staat.

UNIA werkt voor discriminatie, maar alleen voor discriminatie die niet uit de wet zelf voortvloeit.

De academische wereld werkt voor de theorie, maar opent zich pas wanneer het dossier volledig en onweerlegbaar is geworden. Wat maandenlang stil bleef, wordt in enkele dagen actief. De inzet is dan niet meer het dossier, maar de wetenschappelijke validatie.

En wat overblijft voor de burger, is dat de structurele uitsluiting van grensarbeiders niet alleen juridisch is gelegaliseerd, maar ook maatschappelijk

is genormaliseerd. Wie het dossier opbouwt en volhoudt, krijgt uiteindelijk gehoor. Maar alleen wie het volhoudt.

Voor wie in dezelfde situatie zit:

1. *Vakbond*: controleer op wiens naam de lidmaatschapsdossiers staan. Als het dossier niet op uw naam staat, kan de vakbond weigeren tussen te komen.
2. *UNIA*: als de uitsluiting uit een wet voortvloeit, kan UNIA niet tussenkomen. De enige weg is het Grondwettelijk Hof via een rechtszaak. Dat is lang en duur.
3. *Academie*: blijf het dossier aanbieden aan expertisecentra. Vaak pas wanneer een dossier compleet en onweerlegbaar is, opent een instituut zich. Het is een kwestie van volhouden en documenteren.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie. De feiten zijn gebaseerd op Document B. De rol en het mandaat van UNIA zijn gebaseerd op de Belgische antidiscriminatiewetgeving (Wet van 10 mei 2007). De aangehaalde arresten zijn C-279/93 (Schumacker), C-134/18 (Vester), C-385/17 (Hendrix). Dit hoofdstuk is geen juridisch advies.

VII. Slot

Slot — de volledige piramide

Vijf lagen. Drieëntwintig hoofdstukken. Eén lichaam in het midden. Dit is het volledige speelbord van de Systeem-Audit, in één oogopslag.

De piramide



Wat dit dossier heeft laten zien

Vijf lagen, elk met een eigen logica, elk met een eigen mandaat, elk met een eigen beperking. Wat het dossier heeft laten zien, is niet dat één laag faalt, maar dat de lagen samen falen op een manier die niemand kan repareren.

- **De uitvoering** past de regels toe, maar de regels zijn niet gebouwd voor wie in twee landen tegelijk bestaat.

- **Het toezicht** ziet de fout, maar verklaart zich onbevoegd of wacht op een andere instantie.
- **De rechtspraak** kan dwingen, maar de toegang is beperkt door kosten en het peiljaar.
- **De politiek** kan de wet veranderen, maar reageert alleen op systeemfalen — niet op individuele klachten.
- **De symboliek** heeft geen macht, maar wel een informeel kanaal dat de politieke laag kan bereiken.
- **Europa** coördineert, maar harmoniseert niet. Elk land houdt zijn eigen stelsel.

Wat overblijft is het lichaam. Een lichaam dat door alle lagen is gezien, beschreven en beoordeeld. En dat nergens volledig is erkend als één geheel. De mens draagt zelf de rol van data-hub, van dossierdrager, van verbindingskabel tussen twee systemen die elkaar niet lezen. En wanneer hij die rol niet meer kan dragen, valt het systeem stil.

De brug naar Document D

Document C heeft het speelbord en de mechanismen getoond. Document D trekt de conclusies. Drie bouwstenen voor hervorming, gebaseerd op het inzicht dat de fout niet bij de individuele ambtenaar zit, maar in de architectuur van de coördinatie zelf.

Wat in Document C zichtbaar is geworden, is de structuur van het vacuüm. Wat in Document D wordt uitgewerkt, is de structuur van de oplossing. Niet omdat één maatregel alles oplost, maar omdat de architectuur kan worden aangepast op drie punten waar het nu stilvalt.

Dit is het slot van Document C. Alle organisaties in dit document zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool (σ , ϑ). Document C is de visuele tegenhanger van Document B (data-matrix) en Document A (narratieve audit). De conclusies en bouwstenen staan in Document D (synthese).

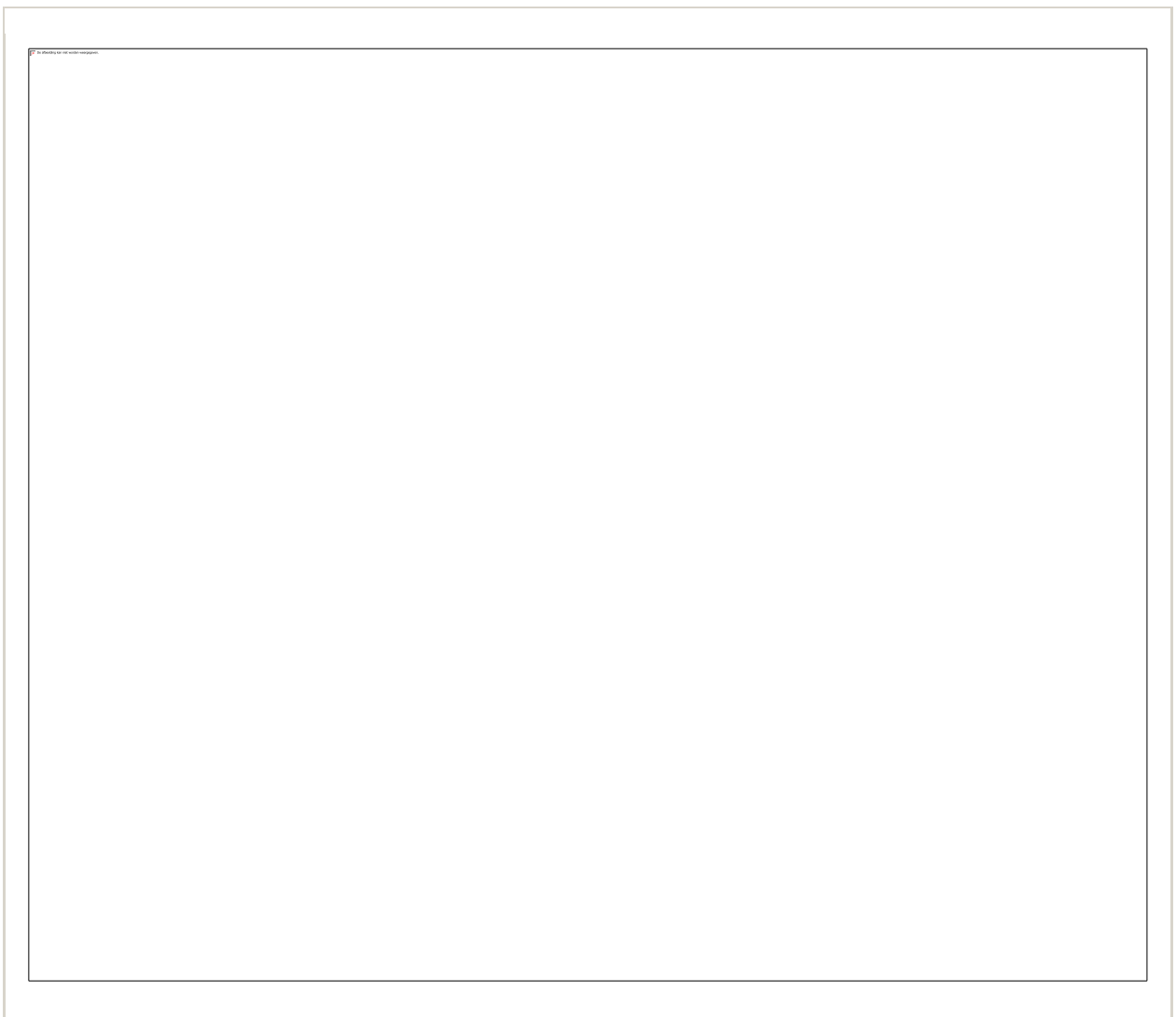
Het volledige netwerk

Alle vorige hoofdstukken toonden elk één mechanisme, één instantie, of één patroon. Dit hoofdstuk toont alles tegelijk. Dezelfde knooppunten, dezelfde kanalen, dezelfde kleuren — maar nu in één beeld, zonder ordening, zoals het gezin het ervaart.

Wat het gezin ziet

De lezer die tot hier is gekomen, heeft elk onderdeel afzonderlijk leren kennen. Elke instantie had een eigen hoofdstuk. Elk mechanisme had een eigen schema. Elke kleur had een eigen betekenis. Maar het gezin dat in deze situatie zit, heeft die orde niet. Het gezin ziet alleen het geheel. En dat geheel is een wirwar.

Dit is dat geheel.



Figuur XXIV.1 — Het volledige netwerk. Wat het gezin ziet wanneer het probeert te navigeren. Twee werelden, elk met een eigen set organisaties. Eén gezin in het midden. En 127 verbindingen, waarvan het grootste deel geblokkeerd. In de vorige hoofdstukken was elk onderdeel afzonderlijk te volgen. Hier is het geheel — zonder ordening, zonder hiërarchie, zonder rust.

Wat dit schema doet

Alle vorige hoofdstukken waren geordend. Elk had een titel, een kader, een afgebakend onderwerp. Wie die hoofdstukken leest, krijgt de indruk dat het systeem te begrijpen is, dat elk onderdeel een eigen functie heeft en dat de chaos slechts schijn is.

Dit schema ontkracht die indruk. Hier is geen ordening. Hier is geen titel per knooppunt. Hier is alleen het geheel: 54 organisaties, één gezin, 127 verbindingen waarvan 96 geblokkeerd. En in het midden een lichaam dat zich moet staande houden.

De lezer die de vorige 23 hoofdstukken heeft doorlopen, wist waar hij moest kijken. Hij kon de knooppunten volgen, de kanalen herkennen, de kleuren lezen. Maar het gezin dat in deze situatie zit, heeft die ordening niet. Het ziet niet dat Vitaz in de zorgsector valt en CM in de financiële sector. Het ziet niet dat CZ een verdragspolis uitvoert en CAK het register beheert. Het ziet alleen: er zijn mensen die mijn dossier moeten behandelen, en ze doen het niet.

Dat is wat dit schema toont. Niet het falen van één instantie. Niet het falen van één mechanisme. Maar het falen van het geheel — een netwerk zo complex dat het voor een simpele mens onmogelijk is om er zijn weg in te vinden, en zo star dat het voor een simpele mens onmogelijk is om er iets in te veranderen.

Wat er niet in staat

De 127 verbindingen die in dit schema zijn getekend, zijn de belangrijkste. In werkelijkheid zijn er meer. Elke brief die naar een instantie gaat, elke keer dat een ambtenaar in een systeem kijkt, elk telefoontje dat wordt gepleegd — dat zijn allemaal verbindingen die niet in dit schema staan.

En de 96 geblokkeerde verbindingen die hier zichtbaar zijn, zijn alleen de geblokkeerde verbindingen tussen het gezin en de organisaties. In werkelijkheid zijn er ook geblokkeerde verbindingen tussen de organisaties onderling. Tussen CM en UWV. Tussen CZ en CAK. Tussen FOD SZ en FOD Financiën. Elke geblokkeerde verbinding tussen organisaties is een extra laag die het gezin moet navigeren.

Wat dit schema toont, is niet het volledige netwerk. Het is een representatie van het volledige netwerk. Als alle verbindingen zouden worden getekend, zou het schema onleesbaar worden. En dat is precies het punt.

Alle organisaties in dit hoofdstuk zijn rechtspersonen. Natuurlijke personen worden aangeduid met hun functie of hun symbool. De organisaties zijn gebaseerd op Document B. De verbindingen zijn gebaseerd op de feitelijke correspondentie in Document B, waar relevant samengevat. De aantallen (54 organisaties, 127 verbindingen) zijn indicatief; het werkelijke aantal is hoger. Dit hoofdstuk is geen juridisch advies.